

目 录

内 科

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 急性支气管
炎.....(1) | 17. 胆石病 (胆结
石)(40) |
| 2. 慢性支气管
炎.....(2) | 18. 急性胆囊炎.....(45) |
| 3. 阻塞性肺气
肿.....(8) | 19. 慢性胆囊炎.....(47) |
| 4. 慢性肺原性心脏
病.....(12) | 20. 心绞痛.....(48) |
| 5. 萎缩性胃炎.....(14) | 21. 血脂过高症.....(52) |
| 6. 胃柿石.....(17) | 22. 单纯性肥胖
症.....(55) |
| 7. 消化道憩室
病.....(18) | 23. 钩端螺旋体
病.....(60) |
| 8. 慢性非特异性溃
疡性结肠炎.....(20) | 24. 膀胱炎.....(63) |
| 9. 阿米巴肠病.....(22) | 25. 前列腺肥大.....(64) |
| 10. 钩虫病.....(24) | 26. 慢性前列腺
炎.....(66) |
| 11. 蛔虫病.....(26) | 27. 中暑.....(69) |
| 12. 蛲虫病.....(28) | 28. 肩关节周围
炎.....(72) |
| 13. 绦虫病.....(29) | 29. 关节风湿病.....(74) |
| 14. 姜片虫病.....(31) | 30. 类风湿性关节
炎.....(78) |
| 15. 囊虫病.....(32) | 31. 肢端动脉痉挛病
(雷诺氏病)(81) |
| 16. 肝硬化.....(34) | |

32. 慢性肾上腺皮质
机能减退症(阿
狄森氏病).....(83)
33. 皮质醇增多症
(柯兴氏综合
征).....(85)
34. 瘰症.....(86)
35. 小脑共济失调
症.....(89)
36. 脑溢血.....(90)
37. 蛛网膜下腔出
血.....(94)
38. 脑血栓形成.....(96)
39. 脑栓塞.....(97)

40. 脑外伤后综合

- 征.....(99)
41. 脑积水.....(101)
42. 脊髓空洞症.....(103)
43. 多发性神经
炎.....(105)
44. 流行性乙型脑
炎.....(107)
45. 精神分裂症.....(110)
46. 流行性出血
热.....(114)
47. 白细胞减少
症.....(118)
48. 过敏性紫癜.....(121)
49. 脂膜炎.....(123)

妇 产 科

50. 经前期紧张综合
征.....(125)
51. 妊娠水肿.....(126)
52. 妊娠高血压.....(127)
53. 妊娠呕吐.....(128)
54. 产后尿潴留.....(130)
55. 产褥感染.....(133)

儿 科

56. 鹅口疮.....(135)
57. 蚕豆黄.....(137)
58. 佝偻病.....(139)
59. 小儿屏气发作综
合征.....(142)
60. 女童性早熟
症.....(143)

外科·皮肤科

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 61. 急性腰扭伤……………(145) | 66. 肛裂……………(154) |
| 62. 慢性腰背痛……………(147) | 67. 接触性皮炎……………(156) |
| 63. 化脓性指头炎……………(149) | 68. 尿布皮炎……………(158) |
| 64. 甲沟炎……………(150) | 69. 脓疱疮……………(159) |
| 65. 化脓性骨髓炎……………(151) | 70. 硬皮病……………(162) |
| | 71. 眼、口、生殖器三联综合征……………(165) |

五官科

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 72. 急性结膜炎……………(167) | 77. 慢性单纯性鼻炎……………(176) |
| 73. 麦粒肿……………(169) | 78. 萎缩性鼻炎……………(178) |
| 74. 白内障……………(170) | 79. 过敏性鼻炎……………(180) |
| 75. 急性化脓性中耳炎……………(173) | 80. 副鼻窦炎……………(181) |
| 76. 慢性化脓性中耳炎……………(175) | 81. 急性咽炎……………(184) |
| | 82. 慢性咽炎……………(185) |

肿瘤科

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 83. 鼻咽癌……………(187) | 93. 肾癌……………(212) |
| 84. 食道癌……………(190) | 94. 膀胱癌……………(214) |
| 85. 喉癌……………(193) | 95. 睾丸肿瘤……………(216) |
| 86. 甲状腺癌……………(194) | 96. 乳腺癌……………(217) |
| 87. 肺癌……………(196) | 97. 子宫颈癌……………(220) |
| 88. 胃癌……………(199) | 98. 卵巢癌……………(223) |
| 89. 结肠癌……………(202) | 99. 白血病……………(225) |
| 90. 直肠癌……………(205) | 100. 脑瘤……………(228) |
| 91. 原发性肝癌……………(207) | 附: 癌症患者的饮食
注意事项……………(230) |
| 92. 胰腺癌……………(210) | |

内 科

1. 急性支气管炎

急性支气管炎是病毒或细菌的感染，或物理、化学刺激所引起的气管和支气管的急性炎症。病愈后支气管结构可以恢复正常。

急性支气管炎起病往往有鼻塞、喷嚏、咽痛、声嘶等呼吸道症状，全身反应轻微，只有轻度畏寒、发热、头痛、全身酸痛等。主要症状是咳嗽，可有粘液痰，有的可转为粘液脓性痰。有的病人在早晨起床、晚上睡觉体位改变时，或吸入冷空气，或体力活动后发生咳嗽，有时终日咳嗽。急性气管炎发热和全身不适可在3~5日内消退，咳嗽有时延长数周方愈。

听诊可有干性啰音或湿性啰音。

急性支气管炎属于祖国医学的“外感咳嗽”范畴。中医认为多由风寒或风热外侵，邪袭肌表，肺气不宣，清肃失职，痰液滋生，或感受燥气，肺津受灼，痰涎凝结所致。治宜疏风润燥，宣肺止咳。

方一：淫羊藿30克，荆芥10克，前胡12克，桔梗12克，紫苑10克，百部10克，陈皮10克，法夏10克，生姜10克，甘草10克。水煎服。（本方适用于风寒咳嗽）

方二：冬花12克，紫菀12克，桑叶15克，菊花12克，连翘12克，杏仁12克，清明菜30克，肺经草15克，五匹风15克。水煎服（本方适用于风热咳嗽）

方三：沙参15克，麦冬15克，桔梗12克，川贝6克，杏仁12克，枇杷叶30克，麻仁10克。水煎服（本方适用于燥热咳嗽）。

方四：胆南星10克，法夏10克，黄芩12克，茯苓15克，陈皮10克，杏仁12克，枳实10克，瓜蒌15克。水煎服（本方适用于急性支气管炎其他症状已消失，而咳嗽经久不愈者）。

治疗支气管炎的单方验方：

①枇杷叶10克，苏叶10克，杏仁15克，大蒜10克。先将大蒜和杏仁捣烂如泥，再将苏叶、枇杷叶加水煎煮，然后以沸透的药汁冲入蒜、杏泥中，搅拌加盖，稍沉淀即可服用。每日一剂。

②枇杷叶5份，百部4份，橘叶5份，甘草2份。加水浸过药面煮沸两次，每次煮沸1小时，把两次煎煮药液混合，过滤，将滤液加热浓缩成1:1浓度（即1毫升浓缩药液相当药物总量1克），然后按100毫升药液加白糖25克，加热将白糖溶解，待冷加入防腐剂（苯甲酸钠），加薄荷水适量搅匀，即可灌瓶封口备用，成人每次口服15毫升，每日3次。小儿酌减。

2. 慢性支气管炎

慢性支气管炎是一种常见的疾病，多因急性支气管炎未

及时治愈转变而成。主要临床症状有长期咳嗽，吐痰，有时伴有喘息。凡是一年当中有三个月咳嗽，这种情况连续两年以上，而且这种咳嗽不是由于心肺等其它疾病引起的，就可诊断为慢性支气管炎。

慢性支气管炎发病主要与下列三个因素有关。

1. 感染：常见的病原菌有流感嗜血杆菌、甲型链球菌、肺炎双球菌、鼻病毒及流感病毒等。病毒感染所造成的呼吸道上皮损伤有利于细菌的继发感染，引起慢性支气管炎的发作。

2. 理化因素：寒冷，气温骤变，气压改变，湿度改变，粉尘，烟尘，有害气体等均能降低支气管自净一排出功能，诱发慢性支气管炎。

3. 过敏：具有过敏体质的人，当食入、吸入或皮肤接触某些刺激物后，如花粉、尘埃、羊毛、某些食物或药物，以及冷空气等，都可引起慢性支气管炎的发作。

慢性支气管炎的临床表现：发病缓慢，初起多在寒冷季节发病，咳嗽，咳痰，痰呈白色粘液泡沫状，感染后症状加剧，痰量增多，多为黄色脓痰，终年都有咳嗽、咳痰，伴有哮喘样发作，气急不能平卧等。

慢性支气管炎，属于祖国医学的“咳嗽”、“痰饮”、“哮喘证”、“喘证”等范畴。病因病机复杂，其内在因素，与脏腑有关。“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”，但其中与脾、肺、肾关系密切。因为肺气虚弱，卫阳不固，腠理疏松，容易出汗，常易感冒而诱发支气管炎。脾虚失运，津液不布，聚而成痰，痰湿上泛而为病。肾虚精亏，肾元不固，纳气无权，而为咳喘。且“痰之原，本于肾，痰之动，主于

脾，痰之成，贮于肺”。肺脾肾三脏中，尤以肾为重要。且肾为先天之本，寓真阴真阳，全身之阳赖肾阳供给，全身之阴靠肾阴滋养。若肾之阴阳失调，可加速或加重慢性支气管炎的发展，故治疗慢性支气管炎，补肾是很重要的法则。

方一：熟地20克，山萸12克，山药30克，制附片（先熬）20~30克，淫羊藿30克，核桃仁30克，补骨脂12克，麻黄10克，地龙12克，款冬花12克。水煎服。

方二：菌灵芝30克（先熬），丹参30克，党参30克，麦冬20克，五味子20克，枸杞20克，肉桂6克，川贝6克，甘草6克。水煎服。

加减：虚寒者加附片、熟地。痰热者去肉桂，加银花、桔梗。肺燥者加黄精、熟地。瘀血症状明显者，加赤芍、莪术。

方三：蛞蝓（即无壳蜗牛，浙江民间称为蜒蚰螺，四川民间称为漩巴虫），洗净，加热致死，斩成肉酱，拌以炒熟面粉，搓成丸药，口服，每丸重10克，每日服三次，每次服2丸。连服2~6月。本方能增加患者之抗病能力。

方四：蛤蚧60克，紫河车60克，肉桂20克，制附片60克，补骨脂60克，巴戟60克，仙茅60克，仙灵脾120克，菟丝子60克，鸡血藤60克，共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，早晚各服二丸，开水吞服。最好在夏季开始服用。此为冬病夏治，疗效良好。

治疗慢性支气管炎的单方验方：

1. 在患者背部、颈部两侧及肩胛区拔火罐。每日或隔日1次，每次15分钟。

2. 生姜500克，纯蜂蜜120克。将生姜捣烂取汁，弃去姜渣，澄清，再弃去上清液，取沉淀液（似淀粉状），加入蜂蜜，搅匀，晚饭后一次服下，卧床休息，微汗。

3. 茯苓、山楂、苏子、桔梗、黄芩、川贝或浙贝、白芍、黄芪各15克，香附、杏仁、天冬、牛蒡子、桑皮、百合、阿胶、山药、沉香、人参各10克，胆南星、法半夏、甘草各6克，神曲、白术、橘红、瓜蒌、五味子、前胡、紫菀各12克，共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每次服2丸，早晚各服1次。

4. 当归10克，川芎10克，枸杞10克，黄芪15克，茯苓10克，陈皮10克，杏仁15克，法半夏10克，地骨皮15克，五味子10克，川贝粉10克（冲），甘草6克。水煎服，每日一剂。

5. 沉香24克，蛤蚧2对，人参50克，地龙50克，胡桃肉100克，丹参100克，黄芪100克，补骨脂100克，肉桂40克，麻黄40克，厚朴80克，炙甘草30克。共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，早晚各服2丸。

6. 制附片30克（先熬），补骨脂15克，菟丝子30克，山药30克，枸杞30克，麦冬30克，五味子15克，杏仁15克，仙鹤草30克，当归30克，黄芪30克，牛蒡子10克，核桃仁30克。水煎服，每日一剂。

7. 党参30克，桑白皮30克，五味子15克，阿胶15克，桔梗15克，冬花15克，乌梅30克，川贝粉10克（冲），附片15克（先熬），杏仁10克，前胡12克，甘草10克。水煎服，每日一剂。

慢性支气管炎复发的主要诱因是感染，特别是上呼吸道

感染。要预防慢性支气管炎，必须加强体育锻炼，提高身体抵抗力，戒烟，改善环境卫生，平时养成良好的卫生习惯。得了上呼吸道感染等疾病，应及时而彻底地治疗。

慢性支气管炎患者的注意事项：

1.宜常行“毛刷疗法”。何谓“毛刷疗法”？就是用毛刷照人体经络通行的路线来回刷动，作为慢性气管炎的辅助治疗，效果较好，而且简便易行，患者乐于接受。

手臂内侧有一条经络直通大拇指少商穴，在中医学上被称为肺经（在针灸挂图上能找到），若用毛刷从手臂内侧一直刷向大拇指少商穴，即按肺经的流向刷，就可使呼吸器官“健壮”，就可使咳嗽、多痰等气管炎症状逐渐减轻以至消失。切记不能逆向刷动（不能从手指少商穴刷向手臂内侧）。逆向刷动会引起不好的后果。这种毛刷最好是用动物毛制作的，不能用尼龙制作的毛刷。

手臂内侧的皮肤较柔嫩、敏感，刷的次数可多可少，通常刷至皮肤呈桃红色为宜。在睡前施行毛刷疗法，疗效较好。

2.患者宜常吹笛。近年来，医学家们发现吹笛作为慢性支气管炎的一种辅助治疗手段，效果比较好。其理由是：吹笛能使横膈肌运动范围增大。吹笛时要作深呼吸，必然使横膈肌的上下运动增大，从而使呼吸加强，缓解支气管炎发作时的呼吸困难和缺氧现象。

吹笛还可使肺泡开放的数目增多。正常呼吸时并不是所有肺泡都开放，而是按一定比例轮流开放。支气管炎时气体交换发生障碍，需要开放更多的肺泡以代偿其损失，而吹笛

可使肺泡开放增多。

3. 宜重视饮食调理。

慢性支气管炎稍愈后常易复发。未发作时宜以扶助正气为主，饮食调理即是扶助正气，增强抗病能力的一种积极手段。

预防发作也可常服新鲜胎盘炖瘦肉（或炖鸡）。新鲜胎盘含多种激素，其中的胎盘脂多糖能增强机体免疫力，因此，慢性支气管炎患者宜常服用。

预防发作也可用胡桃肉同生姜一起嚼服。或常服四仁鸡蛋粥（白果仁、甜杏仁、胡桃仁、花生仁各等份，共研末混匀，每日清晨取20克，鸡蛋一只。煮一小碗服下）。

止咳化痰宜常服“雪羹汤”（海蜇120克，鲜荸荠120克，一共煎汤，频频饮服）。

治咳喘也可常服柚子皮蒸蜂蜜（柚子一只，取皮，削去内层白髓，切碎，置于有盖碗中，加适量蜂蜜，隔水蒸熟），早晚各服1匙。或用佛手1~2个，切碎，如上述制法，也可治疗咳喘。

民间单方：川贝、蒸梨，治咳嗽也有较好疗效。可用川贝5克，冰糖15克（也可用蜂蜜1匙），与梨（勿剥皮）同蒸，将梨与汁同服。

三仙饮（生萝卜250克，鲜藕250克，梨2个，切碎绞汁，加入蜂蜜250克），治疗热咳也有较好疗效。

平时宜常吃萝卜、刀豆、蘑菇、冬瓜、丝瓜、鲜藕、豆腐皮之类蔬菜。宜常吃梨、枇杷、荸荠、橘子等水果。

3. 阻塞性肺气肿

肺气肿是肺泡腔扩大、肺泡内充气增多而导致肺组织的弹力减退和肺的容积膨大。

肺气肿可分为阻塞性肺气肿、老年性肺气肿、代偿性肺气肿和间质性肺气肿等临床类型。

现着重谈谈阻塞性肺气肿的中药治疗。

阻塞性肺气肿是肺气肿中最常见、影响身体健康最严重的一种。多见于中年人或老年人。

阻塞性肺气肿多发生在老年慢性支气管炎、尘肺、支气管哮喘、支气管扩张、肺结核等病之后，凡能引起支气管的炎性变化，使通气阻塞的，都可导致阻塞性肺气肿。

阻塞性肺气肿发病缓慢，主要症状是咳嗽、痰多、气急。早期症状较轻，劳动时才发生气急，随着肺气肿程度的增加，气急症状就逐渐明显，甚至平地走路或休息时也感气急。当气候寒冷，支气管分泌物增多时，患者常感胸闷，气急亦较明显。此时若并发呼吸道感染，支气管阻塞更严重，由于肺通气和肺换氧功能障碍，可造成缺氧，进一步严重时则导致二氧化碳潴留，出现紫绀、头痛、心动过速、嗜睡、精神恍惚等。若不及时治疗，可迅速发生呼吸衰竭。

阻塞性肺气肿可通过X线检查而确诊。

阻塞性肺气肿，属于祖国医学的“咳嗽”。“上气”、“痰饮”、“肺胀”、“肺痿”、“虚劳”等范畴。中医认为阻塞性肺气肿多由正虚所致。本病由肺及脾，肺虚不能宣发，脾虚滋生痰饮。本病早期应及时宣肺祛邪，健脾祛痰。

晚期常致大气虚极，肺失鼓动而淤阻，水失制约而泛滥。老年肾气已虚，若加此病，更易耗伤精血，肾气更虚。冬季症状加重者往往是阳虚，夏季症状加重者多为阴虚或湿盛。

本病邪实正虚，标本互见，其治疗，宜扶正祛邪。

方一：山药30克，芡实12克，白果10克，白术15克，茯苓30克，甘草10克，黄芪30克，苏子10克，牛蒡子12克，莱菔子12克。水煎服。

加减：胸闷加瓜蒌。呼气难倍用黄芪。呼气吸气俱难加党参、麦冬、五味子。便溏便秘均重用白术。发热、痰黄加银花、连翘。心悸、浮肿、畏寒加红参、附子。冬季症状加重，属于阳虚者，加红参、附子。夏月湿盛，头重胸闷者加杏仁、苡仁、白蔻仁。五心烦热、失眠、颧红者属于阴虚，加沙参、麦冬、知母。

注：古有“嗽家忌参”之说。实证喘咳自当忌参，然而虚证非用参不可。如出现心衰，还须加大黄芪用量。

方二：北沙参30克，麦冬30克，五味子30克，苡仁30克，杏仁12克，陈皮10克，法半夏10克，茯苓20克。水煎服。

加减：风寒加生姜、麻黄。风热加桑叶、菊花。阴虚加生地、丹皮。阳虚加炮姜、细辛。

阻塞性肺气肿是由慢性支气管炎、支气管哮喘、矽肺等引起的，因此，要预防阻塞性肺气肿，就要防止和彻底治疗上述疾病。

阻塞性肺气肿患者的注意事项：

1. 阻塞性肺气肿并非“不治之症”，但是，单纯求助于

药物，并不能解决问题。阻塞性肺气肿，由于肺功能损害，影响了身体的健康及抵抗力，两者互为因果。因此，增进身体健康及抵抗力，是改善肺功能的最根本的方法。

做呼吸体操，洗冷水脸甚至冷水澡，步行，慢跑（在步行锻炼到一定程度时再作慢跑）等，都能增进健康，增强抵抗力。肺气肿患者应坚持锻炼，持之以恒，日久自见成效。

肺由肺泡组成，经常使用肺泡就能保持和增强其弹性，反之则会使弹性下降。人在安静时呼吸，肺泡仅张开 $1/20$ ，绝大部分并不使用，一直要到下次呼吸时再轮换，使用率不高。人过中年，肺泡弹性明显下降，肺活量和通气量也减少。如果经常锻炼，肺泡张开率就会经常大幅度地提高。如在慢跑时，通气量就可增加好几倍，可保持肺泡的弹性，又可延缓呼吸功能的衰老。坚持慢跑，气体交换十分充分，血液中的氧气含量高，这对防治阻塞性肺气肿有着十分良好的作用。

2. 有条件的患者还可经常使用空气负离子发生器。

空气负离子，除能使空气纯净，改善生活和工作环境，提高工作效率外，对肺气肿也有一定的治疗作用。

要想获得必需的空气负离子，一是从自然界获取，二是求助于人工发生。

森林、海滨、飞泉附近，空气中负离子浓度往往比城市高几十倍或上百倍。但从自然界获取空气负离子往往受各种条件的限制，于是，科学工作者发明了空气负离子发生器。从现有资料看，小小空气负离子对人体健康确实能起很大的作用。

负离子浓度随着负离子发生器距离的增加而骤然下降，一般到2米外只剩原始浓度的百分之几或更少。负离子在空气中不会无限增多，不会长期停留。而是不断产生，不断消失。在清洁空气中一般寿命为4~5分钟，在污浊空气中寿命仅1分钟。因此，在使用空气负离子发生器时，应将出口尽量靠近人的呼吸带。

负离子开放时间的长短，没有严格规定，作治疗用时，一般每次放30分钟，每天1~4次。一般说，不会有任何副作用。连续治疗10多天后，就能看出疗效。

3. 患者切忌使用安眠药。肺气肿的主要特点是呼吸功能不全，表现为缺氧和二氧化碳潴留，有胸闷、气急、呼吸困难以及口唇发绀、指甲发绀等症状。以及睡眠时通气功能下降。上述情况的存在，如再服安眠药就可能发生危险。有人曾经观察过中度或重度慢性支气管炎、肺气肿病人睡眠时的呼吸变化，在218分钟内，患者发生呼吸暂停的次数为5~74次，平均血氧饱和度下降7.5%，有明显的二氧化碳潴留，但是机体还处于代偿阶段，即使血中二氧化碳浓度升高，由于中枢神经发生冲动使呼吸加快加深，以维持正常生理功能，也不致危及生命。

催眠药如鲁米那、速可眠、阿米妥等都是通过抑制中枢神经而产生催眠作用的，在催眠的同时，也抑制呼吸中枢，这对肺气肿病人是非常危险的，可使呼吸变浅而次数减少，加重缺氧和二氧化碳潴留，引起发绀，严重者可发生肺水肿，或导致呼吸麻痹而死亡。其他安眠药如安眠酮、利眠宁、安定等均有抑制呼吸中枢的副作用。肺气肿患者均应忌用。

4. 慢性肺原性心脏病

慢性肺原性心脏病，简称肺心病，是指肺气肿或其它慢性肺部疾患，使肺循环阻力增加，引起肺动脉高压，导致右心肥大，最后发生心力衰竭的一类心脏病。

慢性肺心病以气短、咳喘、心悸、水肿、不能平卧等为特征。

慢性肺心病发生的主要环节是肺动脉高压。在肺高压的情况下，右心室收缩时必须加大压力，时间一长，右心室负担过重，心肌缺氧，右心肥大，当心功能不全时，可出现肝大，颈静脉怒张，全身浮肿等右心衰竭现象。肺心病引起的心力衰竭与其他类型的心脏病不完全一样，除了有心力衰竭的表现外，还常常有严重的呼吸衰竭，影响气体交换，空气中的氧气吸不进来，血液中的二氧化碳排不出去，病人平常就有气短、心慌、口唇和指端青紫等缺氧现象。

肺内感染往往是促进心功能不全的重要因素。感染时的发热能增加心脏负担；某些毒素可以直接引起心肌变性、坏死；肺内感染能使肺部原有病变加重，严重的影响肺换气功能。机体的缺氧又可促使心功能不全的发生与发展。

由慢性肺部疾患发展到肺心病，一般要经过几十年的时间。

慢性肺心病可通过听诊、X线检查、心电图检查等确诊。

慢性肺心病，属于祖国医学的“痰饮”、“肺胀”“喘咳”、“水气”、“心悸”等范畴。中医认为主要由于水饮

之邪，影响于心肺而发病。本病病变部位在肺，但与脾肾关系密切，并影响于心。肺为华盖，居于五脏之上，外合皮毛，职司清肃，若外邪侵袭，日久不愈，损伤肺气，肃降失权，不能通调水道，水湿停聚而成水饮，水饮停于心下，就能凌心射肺，出现心悸、紫绀、气短、汗出、水肿等，即现代医学之心力衰竭。

慢性肺心病可按急性发作期和缓解期分别予以治疗。

一、急性发作期

（一）风寒型（急性发作初期）

咳嗽喘促，不能平卧，心悸，痰多白沫，胸痞干呕，肢体浮肿，发热恶寒，苔白腻，脉弦紧。治宜解表散寒，温里化饮。

处方：麻黄10克，桂枝10克，法半夏12克，细辛6克，白芍12克，五味子12克，杏仁12克，干姜6克。水煎服。

（二）痰热型（呼吸道感染加重期）

发热，面赤，烦躁，痰壅气塞，难以咯出，苔黄，脉浮数。治宜清热，祛痰，化饮。

处方：生石膏30克，鱼腥草30克，知母12克，黄芩15克，川贝6克，栀子20克，苇茎30克，杏仁12克，板蓝根30克，桔梗12克，前胡12克，冬瓜子30克，苡仁30克，桃仁10克。水煎服。

（三）水气凌心型（心功能不全）

咳喘气急，发热畏寒，面色苍白，不能平卧，张口抬肩，心悸，浮肿，口唇指甲青紫。舌淡，苔白腻，脉沉弱。治宜温阳利水，散结化饮。

处方：茯苓30克，白术30克，党参60克，桂枝10克，泽泻10克，制附片20克（先熬），葶苈子12克，麦冬20克，桑白皮12克。水煎服。

二、缓解期

慢性肺心病缓解期仍有气短、咳喘、心悸等症状，不过比之急性期有所减轻和缓解。此期治宜扶正补虚。

处方：菌灵芝30克（先熬），核桃仁30克，麦冬20克，黄芪30克，党参30克，五味子20克。水煎服。

此方宜常服，才能减少急性发作。

缓解期除了扶正补虚的治疗以外，还必须从事体育锻炼，增强体质，才能减少发作，单纯依靠服药，疗效不能巩固。

5. 萎缩性胃炎

萎缩性胃炎是慢性胃炎的一种。临床表现：食欲不振，胃痛，舌红绛无苔，舌糜烂疼痛，舌体缩小，贫血，腹泻，消瘦。萎缩性胃炎多发生于青壮年。胃脘作痛多为隐痛，或刺痛，或冷痛，胃中或有嘈杂、烧灼感，食后作胀，或口干，喜食酸物。平素乏力易倦，面色少华，腹胀嗳气，多见便干，但有少数病人便溏。

萎缩性胃炎的病理变化是以粘膜退化、胃壁变薄、胃腺萎缩为特征。症状持续，病程长。如果具有上述症状，作胃液分析发现胃液中游离酸减少或缺乏，空腹胃液中常有上皮细胞、白细胞、粘液及细菌等，再借助胃镜检查，可发现胃

粘膜呈灰色或灰绿色，或粘膜层变薄。局限的萎缩区粘膜隆起，并可清晰见到粘膜下血管等病理改变即可确诊。现代医学认为本病由于胃粘膜长期处于炎性刺激状态，导致胃粘膜退化变薄、胃腺萎缩的病理改变，使分泌胃酸的功能减退，胃酸减少或缺乏，从而产生一系列的临床症状。

萎缩性胃炎属于祖国医学的“胃脘痛”范畴，临床表现以胃阴不足为多见。中医认为发病原因与饮食有关，平素饮酒，进食辛辣肥甘炙煨，暴饮暴食，或久服刺激性强的药物，均可导致本病的发生。治宜酸甘化阴，养胃理气止痛。

中医治疗萎缩性胃炎，一般可分以下三种类型：

1. 胃阴虚

食欲不振，胃脘痛，口干，舌红绛无苔，脉细数。

处方：乌梅20克，沙参15克，玉竹12克，石斛15克，麦冬12克，莲米12克，扁豆12克，竹叶10克，栀子10克，甘草10克。水煎服。

2. 气滞血瘀型

食欲不振，胃脘刺痛，痛有定处，舌紫暗，有瘀点或瘀斑，脉弦涩。

处方：丹参30克，降香10克，川楝子10克，元胡10克，竹叶12克，沉香3克，沙参15克，石斛15克。水煎服。

3. 湿盛困脾型

食欲不振，胃脘闷胀，口淡不渴，苔白。

处方：白蔻10克，苡仁30克，茯苓30克，白术15克，厚朴10克，佩兰10克，藿香10克，滑石30克，竹叶12克，陈皮10克，甘草6克。水煎服。

萎缩性胃炎，除上述辨证分型治疗外，也可服用基本处

方，根据不同兼证，在基本方中加减治疗。

基本方：乌梅20克，白芍15克，沙参15克，麦冬15克，木蝴蝶6克，刺猬皮6克，麦芽30克，甘草6克。水煎服。

加减：

胃脘胀痛，痛及两胁，暖气呃逆者，加佛手、香附、没药、青皮。

胃脘疼痛部位固定，痛如针刺，舌质有瘀斑或瘀点，或胃镜检查有息肉增生者，可选加活血化瘀药桃仁、红花、三棱、莪术、延胡索、姜黄、九香虫。

疼痛喜按，得温痛减，喜热饮，纳呆乏味，腹胀肠鸣便溏，舌质淡，苔薄白，可选加良姜、炮姜、附片、白术、山楂炭、肉桂。

口苦，口干，口中臭秽，口渴欲饮，便干，苔薄黄，舌红，可选加黄连、蒲公英、石打穿、红藤、制大黄、玄参。

对于经胃镜检查发现胃粘膜有结节等息肉样病理改变者，除在方中加活血化瘀药如红花、三棱、莪术、九香虫等外，再加用乌梅、僵蚕等量研末为散，长期服用，对消除息肉有效。

对于萎缩性胃炎，表现腹胀、纳呆、呕恶、舌苔白而厚腻者，当先予以和胃化浊或酸甘养胃之药。如有胃阴不足又兼有脾阳不振者（便溏，喜热饮，手足欠温等），应大胆使用干姜、附片、白术、黄芪等，但酸甘化阴养胃法，应贯穿于整个治疗过程之中。

治疗萎缩性胃炎的验方：

①党参、白术、茯苓、甘草、当归、白芍、麦冬、五味

子、元胡、乌梅、川楝子、枸杞、香附、蒲黄、五灵脂，各等份，共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每次服2丸，开水送服，早晚各服1次。

②茵灵芝30克（先熬），乌梅20克，丹参30克，五味子30克，酸枣仁30克，白芍30克，人参叶30克，石斛15克，生地30克，党参30克，炙甘草12克，白术10克，茯苓10克。水煎服。

6. 胃 柿 石

胃柿石系食入大量柿子（特别是未成熟的）或黑枣后，在胃中形成结石。其症状有：食入柿子后数小时或2~3天后，胃脘阵痛或堵闷，恶心，呕吐，反酸，嗝气，腹泻，腹胀，有的患者感到口中有柴油味上泛。检查可见胃脘部稍隆起，可触及鸡蛋大或拳头大之包块，推之可移动，有轻微压痛，腹软。

根据患者有进食大量柿子或黑枣史，并具有上述症状，通过X线钡餐检查及胃镜检查，可确诊为胃柿石。

胃柿石属于祖国医学的“积聚”范畴。多由饮食不节，停滞于胃所致。治宜消导化滞，消坚破积。

方一：金钱草30克，甲珠10克，三棱10克，莪术10克，陈皮10克，木香10克，白蔻10克，大黄10克，玄明粉10克，鸡内金10克，谷芽15克，麦芽15克。水煎服。

本方用白蔻、陈皮行气健胃，内金、麦芽、谷芽化滞消导，三棱、莪术、山甲消坚破积，金钱草化石，大黄、玄明粉攻积通下，可使胃柿石裂解，随大便排出。

方二：藿香10克，法夏12克，砂壳10克，白术10克，槟榔12克，苍术10克，陈皮10克，神曲10克，鸡内金10克，人参6克，麦芽15克，生姜10克。水煎服。

方三：党参30克，白术20克，黄芪30克，神曲15克，鸡内金12克，山甲15克，瓦楞子10克，生龙骨12克，生牡蛎12克，厚朴10克，三棱10克，莪术10克，枳壳10克，郁金10克，莱菔子10克，甘草3克。水煎服。

体外溶石试验证实，本方对柿石裂解作用显著，12小时柿石全部溶解成糊状。服本方后均应再给予导泻剂，使柿石从大便排出。

7. 消化道憩室病

消化道憩室病是胃肠道壁层局部向外膨出形成的圆形袋状或囊状突出。也就是说，憩室是类似疝气一样的一种囊肿，是挂在食管壁、胃壁、肠壁上的一种袋状物，小的象黄豆，大的有鸽蛋那样大，甚至比鸽蛋更大。这种病多发生于40岁以上的中、老年人。

憩室形成的原因尚未完全明了，胃肠道器官壁虚弱及腔内压力过高，可能是憩室形成的主要原因，肥胖、便秘、少吃蔬菜的人容易得这种病。

消化道憩室病的自觉症状主要是疼痛。食管憩室发炎时，胸骨后部及胸上部会出现疼痛，而且往往是在进食时发生。如果是胃憩室发炎，也会在上述部位发生疼痛，³但疼痛时间是在饭后。十二指肠憩室往往引起胸上部和右肋下部疼痛。肚脐周围及右髂区疼痛，有时是因为回肠和盲肠长了

憩室。总的说，消化道上部的憩室发炎，病人就会出现唾液过多，食物从食管中通过受阻，出现胃灼热，恶心，呕吐。肠憩室可有腹胀，时而便秘，时而腹泻，常常有需要排便的错觉。憩室加剧时，上述症状会变得更加明显，同时体温升高，打寒战。如不及时治疗，可引起器官化脓或穿孔、大出血、肠梗阻等症状。

消化道憩室病的诊断，除详细询问病史外，主要依靠X线钡餐检查而确诊。

消化道憩室属于祖国医学的“胃脘痛”、“噎膈”等范畴。中医认为系阴虚肠燥、气滞血瘀所致。治宜滋阴润燥，解郁理气、活血止痛。

方一：白花蛇舌草30克，野菊花15克，半枝莲15克，半边莲15克，威灵仙15克，银花10克，皂刺10克，鸡内金10克，陈皮10克，木香10克，橘核15克。水煎服（本方适用于食道憩室，吞咽困难者）。

方二：橘络10克，木香10克，枳壳10克，陈皮10克，瓜蒌20克，厚朴10克，茯苓15克，苏叶10克，法夏10克，苏合香丸一粒。上药煎水，吞服苏合香丸（本方适用于胃憩室、十二指肠憩室，食后痛剧者）。

方三：先用Ⅰ号方：五灵脂30克，白薏仁15克，三棱15克，莪术15克，乳香15克，没药15克，水煎服，连服三剂。然后用Ⅱ号方：乌贼骨15克，甘草10克，白芨30克，锻瓦楞子30克，浙贝12克，三七粉3克，蜂蜜60克。上药煎水，兑蜂蜜服。

注：体弱或憩室过大者，Ⅰ号方应慎用或不用，以防出血、穿孔之弊。

护理及注意事项:

一旦发现消化道长了憩室,饭后要喝开水兑蜂蜜,吃东西不要吃得过快,要细嚼慢咽,食物不可太热或太冷,要少吃多餐。多吃蔬菜和海带,保持大便通畅。忌吃葱、豆类、红薯、牛奶等容易胀气的食物。

8. 慢性非特异性溃疡性结肠炎

慢性非特异性溃疡性结肠炎是一种原因尚未阐明的炎症性肠病。病变以溃疡为主,多累及远端结肠,也有遍及整个结肠者。主要症状有腹泻,腹痛,粪便中含有脓血和粘液,病程缓慢,病情轻重不一,有反复发作趋势。本病可发生于任何年龄,但多在20~40岁之间,男女都可发病。

近年来认为本病的发生与遗传、免疫因素等有关,而细菌感染、精神因素则为诱发因素。

临床表现:除少数患者起病急骤外,一般起病缓慢,病情轻重不一,症状以腹泻为主,严重者每日10~30次,排出含有血、脓和粘液的粪便,伴有阵发性结肠痉挛性绞痛与压痛,多位于左下腹,肠鸣音亢进,并有里急后重,排便后症状即缓解。

情绪激动、劳累、感染,饮食失调等可诱发本病。

本病可分以下三种类型:

1. 轻型 起病缓慢,无全身症状,只是粪便中有脓血和粘液,有时仅排出脓血、粘液而无粪便,有时先排脓血粘液,后排粪便。

2. 严重慢性型 病程持续数月或数年，患者极度消瘦、衰弱，有发热、心动过速等现象。并可并发贫血、多关节炎、多种维生素缺乏症、结节性红斑、鹅口疮、失水、电解质平衡紊乱等。此型较少见。

3. 暴发型 起病急骤，有发热、心动过速、虚脱等毒血症征象，每日大便10~30次，粪便中有脓血、粘液，并有腹部膨胀、腹痛及压痛。此型更少见。

慢性非特异性溃疡性结肠炎可通过粪便检查、直肠乙状结肠镜检查、X线检查等而确诊。

慢性非特异性溃疡性结肠炎，属于祖国医学的“肠澼”、“久痢”、“脏毒”、“肠风下血”、“血痢”、“滞下”等范畴。中医认为多由外感六淫之邪，内伤七情及饮食不节、劳倦过度所引起。《素问·太阴阳明论》说：“饮食不节，起居不时者，阴受之。阳受之则入六腑，阴受之则入五脏。……入五脏则膜满闭塞，下为飧泄，久为肠澼”。

其治疗，应按临床不同证型辨证施治：

1. 湿热下注型 腹痛，腹泻，大便中有粘液脓血，里急后重。治宜清热燥湿，辅以止血止泻。

处方：白头翁30克，五倍子10克，黄连10克，黄柏10克，赤石脂30克，槐花30克。水煎服。

加减：血多加地榆炭15克。粘液多加乳香、没药各10克，久病体虚加黄芪、党参、五味子各30克。腹痛甚，加玄胡索、川楝子各10克。

2. 下元虚寒型 四肢不温，久泻滑脱不禁，大便中仍有脓血粘液。治宜温补下元，收涩固脱。

处方：炮姜炭10克，赤石脂30克，诃子肉15克，肉豆蔻

(去油)10克, 槟榔炭10克, 海螵蛸15克。水煎服。

治疗慢性非特异性溃疡性结肠炎的单方验方:

1. 云南白药(成药)每次服0.2克, 每日服3次, 3~10天为一疗程。

2. 锡类散(成药), 每次口服2支, 开水吞服, 空腹服, 每日服3次。临睡前又用锡类散3~4支, 加温开水40毫升混和, 作保留灌肠。本方可使药物直接作用于溃疡面, 控制炎症, 促进愈合。

3. 蒲公英30克, 败酱草30克、红藤30克、穿心莲30克、黄柏15克, 加水煎至150毫升, 温度在30~40℃时作保留灌肠。保留8小时以上疗效更佳。

9. 阿米巴肠病

阿米巴肠病即阿米巴痢疾, 是阿米巴(原虫)侵入大肠后所致的以痢疾症状为主的疾病。这种病易于复发变为慢性。原虫可由肠壁经血流—淋巴或直接迁移至其他器官而导致其他脏器的阿米巴病, 如阿米巴肝脓肿等。

阿米巴病的临床表现轻重缓急不一。

急性典型的阿米巴肠病起病缓慢, 以腹鸣腹泻开始, 大便次数逐渐增加而变为痢疾样, 一日10次左右, 解便时有腹痛和里急后重, 大便带血和粘液, 呈暗红色或紫红色, 糊状, 腥臭, 含大量阿米巴滋养体。病情较重者可呈血便, 或白色粘液上盖有少许鲜红色血液。患者早期体温可升高, 白细胞计数增加。

急性阿米巴肠病没有及时治愈，就可能成慢性，病程可持数月或数年，腹泻反复发作。饮食不当，暴饮暴食，受寒，情绪变化均可诱发腹泻，每天3~5次，腹痛，大便呈黄糊状，腐臭，带少量粘液。

间歇期中患者无特殊症状，或仅有便秘，腹痛，腹胀，腹部不适等现象。

典型的阿米巴肠病，粪便中检查发现阿米巴原虫，即可确诊。

阿米巴肠病，属于祖国医学的“湿热痢”、“休息痢”等范畴。多由感受暑湿疫毒之气，湿热积滞肠中，以致传导失职，痢下脓血。治宜清热祛湿。

方一：槟榔12克，黄连10克，黄芩10克，茯苓12克，泽泻10克，木香10克，厚朴10克，白芍15克，当归12克，白头翁20克。水煎服。

方二：鸦胆子10~15粒，打碎后装入胶囊，开水吞服，每日3次，连服7~10天。

方三：白头翁30克，煎汁分三次服（成人一日量），连服10天，或同时用白头翁60克煎成药液100毫升，每日保留灌肠一次。

方四：大蒜，每日口服一枚，连服10天，或同时用大蒜液灌肠（大蒜30克，捣汁，兑温开水100毫升，作保留灌肠）。

方五：檳白皮100克。加水600毫升，煎2小时再用文火浓缩至100毫升。服前可加入白糖矫味。每次10毫升（较重病例可服20毫升）。每日服3次，7日为一疗程。

方六：干石榴皮60克。加水200毫升煎至100毫升，滤取

药液，每日服3次，每次饭后服20毫升，连服7日为一疗程。两疗程之间停药3日。

方七：赤石脂50克，乌梅30克，鸦胆子30克，食盐10克，陈米饭适量。将鸦胆子去油（打碎去壳，用吸水纸反复将油质吸干），赤石脂研成细末，乌梅去核（用温水泡胀即可去核），打烂备用。将上药共拌均匀，加陈米饭共捣如泥状，制成绿豆大小丸粒，成人每次服15~20丸，小孩5~10丸，每日2次，饭后温开水吞服。

10. 钩虫病

钩虫病是由十二指肠钩虫或美洲钩虫寄生于人体小肠所致的疾病，以贫血、虚弱及肠胃道机能障碍为主要症状，严重者可致心力衰竭。

钩虫寄生在人体的小肠里，不断吮吸血液，使人产生贫血，面色萎黄。钩虫病的传播是雌虫产生的虫卵，随粪便排出，通过施肥，在泥土中孵出幼虫，生长发育成为一种具有感染性的丝状幼虫。当人赤脚下地劳动时，幼虫即钻入皮肤，经过心、肺、上达咽部再经食道到肠子里，住下来发育为成虫，进行吸血，产卵。此病每年5~9月最易受感染。大便检查可找到钩虫卵。钩虫病在我国南方广大农村多见。

钩虫病的早期症状：当钩虫的幼虫侵入皮肤时，可出现红色高出皮肤的小丘疹，有时也可呈小泡状，非常痒，抓破后往往发炎。这种皮疹常发生于足趾或手指之间，或足踝、手腕等与泥土接触的部位。俗称“打粪毒”、“粪疙瘩”、“粪触块”、“粪毒”。

钩虫的幼虫侵入皮肤后，随血流移行到肺部时，可出现咳嗽、气喘、痰中带血丝等症状。

钩虫病后期症状：钩虫的幼虫到达小肠，发育为成虫，吸附于小肠上部肠壁上，可引起上腹部不适，肚脐周围疼痛，恶心，呕吐。少数病人喜嚼生米、泥土等杂物。

钩虫寄生吮血，又使肠壁损伤和出血，长期下去，可使病人出现严重贫血，面色苍白或萎黄，皮肤干燥，浮肿，劳动时气短，头昏，甚至全身无力，稍动则心跳心累。

儿童得了钩虫病可影响发育，孕妇得了钩虫病可引起流产或早产。

钩虫病，祖国医学称为“黄胖病”、“黄肿病”、“懒黄病”、“水积病”等。认为由于虫栖肠胃，阻碍运化，产生脾虚湿困、气血不足的证候。其治疗，当以驱虫为主。严重贫血的先予改善贫血，再予驱虫。

一、驱虫

方一：贯众30克，苦楝皮10克，榧子30克，红藤30克，水煎服。

方二：雷丸12克，槟榔10克，石榴皮10克，苦楝皮10克。水煎服。

方三：鲜马齿苋90克，慢火浓煎，去渣后加醋15毫升，白糖15克，每晚睡前服，连服三晚。儿童用量酌减。

二、治贫血

处方：枯矾15克，炮甲珠10克，鸡血藤30克，香附12克，生铁落30克。水煎服。

钩虫病的预防：

1. 搞好粪便管理，这是预防钩虫病的根本措施。

2. 加强个人防护：用大蒜捣烂调桐油少许，在下地劳动前外擦手足，每日三次。

11. 蛔虫病

蛔虫病是蛔虫寄生于人体所造成的疾病，除肠道症状外，有时蛔虫可钻入胆道引起胆道蛔虫病。

无论城市和农村，蛔虫的感染都比其它寄生虫为高，儿童的感染高于成人。这是因为：蛔虫排卵多，虫卵对外界抵抗力强；蛔虫卵的传播方式很广泛；病从口入，不注意个人卫生，很容易感染。

得了蛔虫病有哪些临床表现呢？

短期内吞食大量感染性虫卵时，8~9天后即可出现发热、干咳、哮喘、痰带血丝、荨麻疹等症状。蛔虫移行至肝、脑、胸膜、眼等器官，可引起相应的局部症状。

成虫引起的症状有：儿童患者常有脐周腹痛，反复发作，大便中常有蛔虫和不消化食物，少数病人可吐出蛔虫，甚至蛔虫从鼻孔或肛门爬出。严重感染者，可引起营养不良，智力迟钝和发育障碍，可有精神不安、烦躁易怒、失眠、磨牙、瘙痒、惊厥等。有的患者甚至伴发顽固性荨麻疹等过敏反应。蛔虫绞结成团可引起肠梗阻。蛔虫窜进胆道，可引起胆道蛔虫病。

大便中发现蛔虫或粪便涂片镜检发现蛔虫卵即可确诊。

蛔虫病属于祖国医学的“虫积”、“虫疳”、“蛔疳”等范畴。中医认为多由饮食不洁，过食生冷，食滞中焦，湿热内生，久而致成虫疾。治宜驱虫导滞。

方一：使君子15克，榧子10克，鹤虱10克，苦楝皮15克，大黄10克。水煎服。

方二：芜荑10克，雷丸10克，乌梅30克，细辛6克，槟榔12克。水煎服。

治疗蛔虫病的单方验方：

- 1.使君子肉（炒熟），每岁每天1~2粒，最大剂量不超过15粒（一天量）。连服三天。服时勿吃热食，防止打呃。
- 2.苦楝根皮30克，槟榔30克。水煎，早晚空腹分服。

蛔虫病患者注意事项：

- 1.宜在睡前或空腹时服药，这样可以提高驱虫效果。
- 2.宜注意清洁卫生。饭前便后要洗手，不吃不洁净的食物。凉拌菜在制作前要充分冲洗干净，吃黄瓜等容易带蛔虫卵的食物，更要注意清洗。这样才能预防反复感染。
- 3.宜在服驱虫药后多吃高纤维食物。为了及时把被驱虫药麻痹的虫体连同粪便一起排出，患者宜在服驱虫药后多吃高纤维食物如粗粮、含麸食品、芹菜、韭菜、小白菜、白萝卜、土豆、香蕉、苹果等，这些食物能增加肠蠕动，及时地将虫体随粪便排出体外。
- 4.忌在服驱虫药时吃油腻食物。这是因为服了驱虫药（西药）再吃肥肉或油，会增加药物吸收而引起中毒。忌吃辛辣食物，以防便秘而影响驱虫效果。

12. 蛲虫病

蛲虫病是蛲虫寄生于人体所致的一种寄生虫病。蛲虫病的流行极广，在儿童集体机构中更易传播，十岁以下儿童感染率最高。

蛲虫排卵的方式特殊，雌虫在夜间爬到肛门产卵，刺激局部，引起肛门及会阴发痒，因而患者常用手搔痒，虫卵易于污染手指，儿童饭前便后没有洗手，在进食或吮手指时虫卵被吃入，造成重复感染，这是直接感染。另外，蛲虫卵排出后，有时附着于患者的衣裤、被褥、用具及玩具上，再污染食物或手指，被吃入造成感染，这是间接感染。

蛲虫卵还可从患者的衣着或被褥落到地面上，以致在尘土中含有虫卵，尤以住房中为多。因此，人们也可吸入混于尘埃中的虫卵而受感染。鼻子有病的患者常用口呼吸，更易于造成吸入感染。

蛲虫病的临床症状以夜间肛门口及阴部奇痒为主要特征，其他尚有食欲不振，消瘦，好咬指甲，烦躁不安，夜惊等。由于蛲虫在肠道内引起机械性刺激，故临床上亦可出现胃肠道症状如恶心、呕吐、腹痛、腹泻，严重时可有脱肛现象。女孩患者常可因虫体钻入阴道而发生阴道炎，出现阴道作痒。

蛲虫病的诊断须根据：①夜间肛门及阴部奇痒。②从肛门周围皮肤皱襞处直接采集标本，放在显微镜下寻找虫卵，亦可在夜间入睡后1~2小时，患者的肛门括约肌松弛时，直接肉眼观察有无成虫从肛门爬出，如能检得成虫，诊断亦可

确立。

蛲虫病属于祖国医学的“虫积”、“虫疳”等范畴。由于饮食不洁，致成虫疾，日久消耗正气，面黄消瘦。治宜驱虫消积。

方一：百部10克，苦楝皮10克，槟榔10克，鹤虱10克。

服法：煎服。同时也可将上药共研细末，装入胶囊，每晚睡前纳入肛门，每次一个，连续一周。

方二：槟榔30克，击碎后加水500毫升，浸泡一夜，浓煎一小时，空腹一次服，连服2~3天。

方三：使君子，去壳，每于饭前半小时嚼碎服之，一岁小儿每次1~5粒，每日三次。

方四：每晚睡前用脱脂棉花蘸好醋（陈醋、浓醋），塞于肛门。此方简便有效。因蛲虫于夜晚爬到肛门产卵，浓醋能抑制蛲虫。

预防：饭前便后洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤换衣被，纠正儿童吮手指的不良习惯。

13. 绦虫病

绦虫常见的有猪肉绦虫和牛肉绦虫两种。虫体由节片构成，扁而长，一节一节连起来象一根带子，长约1~2丈或3~4丈，寄生于人体小肠内。大多由于吃了没有煮熟的含有囊尾蚴（绦虫的幼虫）的猪肉或牛肉所引起。患者的大便中可发现虫体节片，牛绦虫的虫体节片常自动由肛门爬出，猪绦虫的虫体节片常在大便时成串被排出，患者可有轻度肛痒，约有半数病人有上腹部或全腹隐痛，有的病人有腹泻，

食欲亢进，体重减轻，少数病人有头痛、乏力、神经过敏等。

患者粪便中找到有白色面条状或带状能活动的虫体，或粪便中查获绦虫卵，即可确诊。

绦虫病，祖国医学称为“寸白虫”或“白虫”。中医认为“寸白者，九虫内之一虫也，长一寸（绦虫的一个节片），而色白，形小扁”，“连绵成串，几长数尺”，“或如带，长丈余”，“食生肉饱饮乳，变成白虫”。治宜驱虫导滞。

方一：南瓜子60克，槟榔60克。先将南瓜子去皮捣烂，加入少许糖水，研成浆液，空腹顿服。隔两小时后，再服槟榔煎剂（槟榔60克加水浓煎），服药后5小时左右，即见大便排出虫体，如不大便，可冲服玄明粉10克。

槟榔、南瓜子能使绦虫虫体全部麻痹，丧失附着及蠕动能力，因而被驱除，治愈率高。

方二：仙鹤草60克，水煎服。或将仙鹤草晒干，制成丸剂、片剂服用，成人每次服50克，小儿每公斤体重1克，空腹顿服，不用泻药。

仙鹤草驱绦虫的有效成份为鹤草酚。实验研究证明，仙鹤草对绦虫体壁的渗透极为迅速，能使绦虫先痉挛，后松弛，并在30分钟停止活动。如在胆汁存在的情况下，可加速这种药理作用。仙鹤草驱各种绦虫的总治愈率可达94.5%。仙鹤草对人体的副作用轻微，仅少数人感到恶心，呕吐，故在治疗当天应注意休息。

14. 姜片虫病

姜片虫病是布氏姜片虫寄生在人体小肠所致的一种肠寄生虫病，由生食水红菱等而引起感染。姜片虫卵随粪便落入水中，在一定的温度下孵出毛蚴，钻入扁卷螺体内，经过一系列发育过程，产生尾蚴，从螺体逸出，随着在菱角、荸荠等水生植物下，形成囊蚴。如果这些囊蚴被人吃入，则发育成为成虫。

姜片虫病以慢性腹泻、消化功能紊乱、营养不良为主要临床表现，患者以15岁以下儿童为多见。主要分布在南方各省。

姜片虫形如生姜片，以吸盘附在人体肠粘膜上，造成十二指肠及空肠粘膜发炎，影响消化功能。因此患者有上腹部不适，食欲不振，腹泻，消化不良等。感染严重者造成营养不良，面部、下肢甚至全身浮肿，对儿童的身体和智力发育常有严重影响。虫体成团时，可能阻塞肠腔造成肠梗阻。姜片虫病可通过粪便的虫卵检查而确诊，患儿吐虫、便虫经确认后亦可肯定诊断。

姜片虫病属于祖国医学的“虫积”、“虫疳”、“赤虫”等范畴。中医文献中“赤虫状如生肉”、“片如鸡肝”的记载，便是对姜片虫的确切的描述。中医认为本病多由饮食不洁所致。治宜驱虫消积。

方一：槟榔30克（打碎），清水500毫升浸泡一夜，浓煎，空腹一次服，连服2~3天。

方二：榧子肉30克（打碎），槟榔30克（打碎），大黄

10克，木香10克。服法：水煎，早晚空腹服。服时亦可加白糖适量调味。

15. 囊虫病

囊虫病是链状绦虫的幼虫（囊尾蚴）寄生于人体各组织所引起的疾病。寄生部位极为广泛，肌肉、皮下组织、脑、眼、心、舌、口、肺、骨骼等处均有发生，但以脑、肌肉与皮下组织、眼较为常见。

临床表现：

1. 脑囊虫病：出现癫痫发作，颅内压增高，阵发性头痛，呕吐，视神经萎缩，双目失明，精神失常，语言障碍，口眼歪斜，牙关紧闭，口不能开大，皮下有囊虫结节存在。X线头颅平片检查可见多数钙化点，有助于诊断。

凡青壮年最近发作癫痫而无家族史者，应考虑脑寄生虫病（包括脑囊虫病）的可能。脑囊虫病大多与皮下结节同时存在，皮下发现结节，可作为诊断的佐证。而皮下结节的确诊应依靠活组织病理切片检查。

患者如有肠绦虫病病史，或粪便中发现绦虫虫卵或妊娠节片，亦可作为诊断囊虫病的重要参考。

2. 肌肉与皮下组织囊虫病：囊虫病结节（依靠活体组织病理切片检查证实）数目少的只有1~2个，多的有数百个甚至数千个，头部躯干（如颈后、耳后、口腔粘膜、肩胛等处）较多，四肢较少。皮下结节，质坚硬，推之可自由移动，与皮肤周围组织无粘连，不痛不痒，无炎症，无色素沉着。

3. 眼囊虫病（依靠眼底镜检查）：囊尾蚴长久沉着，可诱

致双目失明。

厨师或炊事员容易得囊虫病。

祖国医学中无囊虫病的病名，但中医古籍中有关“九虫”的论述，与囊虫病近似。囊虫病癫痫发作的主要原因，在于囊虫入脑，致使脑部的脉络郁阻而成。郁阻日久，不仅致痛，又可致残，或目盲，或舌謇，每因情志过激，忧郁不解，将息失宜，痰浊郁火内生，随气血而上逆，犯脑阻络而引起癫痫发作。

脑囊虫病的中医治疗当以痫为标，以虫为本进行辨证施治。

方一：全蝎50克，蝉蜕75克，甘草25克，朱砂15克，琥珀20克，冰片5克。服法：研细末，每次服5克，每日服3次，温开水送服。

注：使用这个处方，能控制脑囊虫病患者癫痫发作，肌肉和皮下的囊虫结节也能逐渐消失。全蝎、蝉蜕是否具有杀囊虫的作用，尚待研究。

方二：生明矾（研末另包，分次冲服）10克，雷丸12克，干漆（炒）10克，水蛭（略炒）6克，白芥子10克，大腹皮10克，羌活10克，牛膝10克，五灵脂10克，大黄3克。水煎服。

方三：生明矾160克，雷丸60克，瓦楞子60克，甘草30克，槟榔30克，炮甲珠30克。

服法：共研细末，水丸如绿豆大，每次服10克，早晚各服一次，开水吞服。处方二和处方三交替服用，一个月为一疗程。

注：要杀死囊虫，须摧毁囊虫周围包着的结缔组织包

膜，槟榔、大腹皮、雷丸有较强的杀虫作用，水蛭、干漆、五灵脂、炮甲珠有活血通络的作用，生明矾、瓦楞子、白芥子有化痰软坚作用，有溶解囊虫结节包膜的功能，羌活、牛膝引药至病所，大黄清郁毒，甘草护肠胃。以上药物相辅相成，共同发挥治疗作用。

方四：蛇蜕：研成细粉，每次服5克，每日服二次，同时服用大戟汤（大戟4.5克，槟榔90克，木瓜30克，钩藤18克，加水浓煎）。

针灸疗法：用针灸针直刺囊胞，破坏囊虫生存条件，在囊胞正中及周围刺入五针如梅花状，周围四个针尖刺向囊胞中心，刺破囊壁。针眼内可出现透明液体，针后用碘酒除之，并用纱布盖之以防感染。

16. 肝 硬 化

肝脏具有消化、代谢、解毒、储存和免疫等功用，对于我们的生命是极其重要的，有“生命器官”的称谓。然而，在某些致病因素的作用下，肝脏却容易受到不同程度的损害，发生各种病变，肝硬化就是其中的一种。

肝硬化是一种较常见的慢性病，整个肝脏出现肝细胞损害，纤维组织增生、肝细胞形成再生结节等病变，破坏了正常肝组织结构，使肝脏变形及变硬。

肝硬化的种类很多，按病理形态分类，可分为门静脉性肝硬化，坏死后性肝硬化，胆汁性肝硬化。按病因分类，可分为肝炎后肝硬化，血吸虫病性肝硬化，酒精性肝硬化，胆汁性肝硬化，循环障碍性肝硬化，代谢障碍性肝硬化，原因

不明性肝硬化。也即是说，肝硬化可由各种原因引起，肝炎长期不愈可形成肝硬化，血吸虫病晚期可出现肝硬化，慢性胆囊炎反复发作也可发展成为胆汁性肝硬化，风湿性心脏病长期肝郁血会引起心源性肝硬化（循环障碍性肝硬化的一种），慢性酒精中毒或化学中毒也可引起肝硬化。

肝硬化按病情可分为早期和晚期。肝硬化早期，肝细胞虽已受损，但肝脏的功能还能代偿，医学上称为肝功能代偿期。这时，症状多不明显，有的仅出现轻度消化不良、劳动后疲劳等现象。到了晚期，肝脏功能不能完全代偿或已丧失代偿能力，医学上称为肝功能代偿不全期。这时，病人症状已很明显，可出现腹胀，腹痛，腹泻与便秘交替，发热，消瘦，皮肤色素沉着（面部黧黑），黄疸，出血现象，胸水，腹水，蜘蛛痣（见于颈部、面部、前臂、手背及胸上部），肝掌（又称“朱砂掌”，病人手掌大鱼际、小鱼际出现红斑），男性乳房发育、阳痿，女性月经失调、性欲增强。病情进一步发展，还可能出现因食道静脉曲张破裂而引起的上消化道出血，或发生肝昏迷等危及病人生命的并发症。

肝硬化病人肝质硬，或可扪到肝脏硬化结节。肝功能试验、食管X线钡餐检查、超声波检查、肝活组织检查等均有助于肝硬化的确诊。

肝硬化属于祖国医学的“胁痛”、“黄疸”、“积聚”、“症瘕”、“膨胀”、“单腹胀”等范畴。中医认为本病多由情志抑郁、饮食不节、湿热内蕴，或肝病失治，伤害肝脾、累及肾脏，形成肝脾肾俱损，血瘀症积，气血水搏结，三焦失司，水泛络伤。其治疗，宜清热疏肝，活血化瘀，补气养血，滋阴补肝肾。

对晚期肝硬化，一般可采用下列主方治疗：

处方：当归15克，白芍15克，丹参30克，郁金12克，生地30克，鳖甲15克，白术30克，枸杞30克，茯苓20克，黄芪30克，柴胡12克，甘草10克。水煎服。

加减：口干苦，尿黄赤者，加败酱草30克、栀子12克、丹皮12克。

少气懒言，食少纳呆，加党参30克、山药30克、白豆蔻10克，木香10克。

面色晦暗，或有红斑赤缕，胁下痞块，刺痛，鼻衄齿衄者，加小蓟10克，桃仁10克，鸡血藤30克，三七6克。

心悸失眠，五心烦热，遗精或月经不调者，加沙参20克，麦冬20克、五味子20克。

腹胀如鼓，形如蛙腹，肚脐突出，小便不利，饮食难下者，加白茅根45克，半边莲30克、汉防己30克。

形体瘦弱，少气乏力，腹胀满，大便不畅，小便短赤、口干舌燥，舌苔光剥者，加砂仁6克、阿胶10克、白茅根60克、紫河车粉10克（吞服）、汉防己30克。

肝硬化病人，不论证属何型，其肝内病变的实质是相同的，因而治疗肝硬化的主方可不变。但必须随证加减，灵活化裁运用（某一症状突出，可针对这一症状加用相应药物，如纳差为主要矛盾时，还可加用白蔻、神曲、山楂等；如腹水为主要矛盾时，还可加用大腹皮、茯苓皮、玉米须等，以此类推）。治疗中首先要做到攻邪不伤正，保证脾胃健运，本着“急则治标”的原则，有腹水者先治腹水。消腹水宜采用滋阴利水、健脾利水，慎用温阳利水，或峻泻利水。腹水

一消，即应减用利水药，用扶正养阴之剂，缓慢调治。

治疗肝硬化的单方验方：

1. 三七粉，每次服3克，每日服2次。
2. 大黄鳖虫丸（成药），每次服1~2丸，每日服2次。
3. 鳖甲煎丸（成药），每次服1~2丸，每日2次。
4. 大枣30克，党参30克，白术30克，郁金12克。水煎服（本方四味药，均有增加血清白蛋白的作用，对肝硬化蛋白倒置的患者，甚为适宜）。
5. 汉防己45克，川牛膝30克，淮牛膝30克，白术30克，苍术30克。水煎服，连服2~3周，改用补中益气汤调理之。本方适用于肝硬化腹水患者。
6. 黄芪30克，党参30克，枸杞30克，菌灵芝30克（先熬），败酱草30克，柴胡12克，甘草10克。水煎服。本方各药，均有保肝，促进肝细胞再生的作用。
7. 丹参30克，鸡内金10克，三棱10克，莪术12克，鳖甲15克，山甲15克。水煎服。本方各药，均有软缩肝脾，改善肝脏血液循环的作用。可与第6方交替服用。
8. 生白芍100克，生山药100克，生甘草50克。水煎服，每日一剂。（适用于肝硬化腹水）
9. 西瓜1个（重约7斤），砂仁120克，大蒜瓣半斤，（剥去皮）。先将西瓜开一小盖，挖去瓜瓤，保留瓜皮（连皮白约1寸厚），再把砂仁、大蒜放入。用黄泥浆涂西瓜如泥球，置木柴火炉（忌用煤炭）上，徐徐烘干（最好用铅丝将西瓜捆扎，以防西瓜坠入火中）。待西瓜烘干后，去

泥，碾成细末，装入瓶内，严防泄气。每日服药末3克，分3次服，温开水送服（适用于肝硬化腹水）。

肝硬化患者的注意事项：

①宜坚持慢跑。因为慢跑是治疗肝硬化的良方之一。浙江省丽水县食品公司职工金尔温，患早期肝硬化，开始时思想很苦闷悲观。怎么办？有人告诉他，坚持慢跑是个好办法。于是，他下决心用坚持慢跑来治疗这个病。开始是散步，开始一个月，情况很好，肝功能好转。两个月，腹水消失。他更增强了信心，第六个月开始，坚持慢跑，每天清晨慢跑三千米，后来增加到五千米。跑了一年后，面部不再黧黑，肝超声波复查“密集微波伴低中波”已去掉“伴低中波”四字，恢复工作。通过这个具体例子，说明坚持慢跑的确可以治好早期肝硬化。

②应重视饮食调理。肝硬化病人的饮食应为高热卡、高蛋白质、高碳水化合物、高维生素。选用这类饮食能防止肝细胞进一步变性，亦可使损害不太严重的肝组织得以再生。由于肝硬化病人食欲差，消化功能亦差，因而食物的品种宜多样化，且要求美味新鲜，才能促进食欲并有利于消化。饮食中蛋白质对肝脏有保护作用，且为修复肝细胞所必需。每日每公斤体重需要蛋白质1~2克，应进食牛奶、鸡蛋白、鱼虾、瘦肉等优质蛋白。碳水化合物有保护肝脏和提供能量的作用，每天应摄入300~400克碳水化合物，可选用蜂蜜、果汁等。主粮采用大米、白面等。脂肪应控制在50克以下，尽量采用植物油。过多之脂肪势必增加肝脏的负担。蔬菜因体积大，热量低，不宜多吃，以免影响其他食物的摄入。肝硬化

代偿期应适当淡食，如有腹水，应吃得更淡。待腹水消退，再适当增加食盐。

以下食疗方，及供肝硬化患者选用。

1. 赤小豆60~90克，冬瓜（带皮）250~500克，一并煮汤服，每日一剂。适用于肝硬化有少量腹水者。

2. 活鲤鱼一条（500克以上），赤小豆150克，加水2000毫升，煮至烂熟，再除掉鱼的内脏及鱼鳞、鱼骨。将鱼肉及汤分次服下。适用于肝硬化腹水患者。

3. 泥鳅500克，去鳃及内脏，洗净，加水清炖至五成熟，加入豆腐250克，再炖至鱼烂熟即可食用。

4. 大黑鱼一条（500克以上），去肠留鳞，于鱼腹中放入大蒜瓣及赤小豆，以填满鱼腹为度，用粗厚纸包裹数层，清水中浸透，放入灰火中，煨熟，取出淡食，或以糖醋蘸食鱼肉。

也可用大黑鱼一条，留鳞去肠，加等量冬瓜，再加少许葱、蒜，不加盐，煮熟，喝汤吃鱼。适用于肝硬化蛋白倒置者。

5. 鹅血，烧熟佐餐。能改善肝脾肿大，升高红细胞、白细胞。

6. 猪肚200克，洗净煮熟，捞出，切成丝，再将大米、猪肚丝共煮成粥（可用煮猪肚的汤去油煮粥）。加葱、姜等调料食用。

如患者伴有脾功能亢进之出血倾向时可常吃花生衣、藕、藕粉、香菇、猪肝、猪皮、蜂乳、葡萄、黄鱼、猫肉、大枣、莲子、海参等食品。

肝硬化患者切忌饮酒，切忌饮含酒精的饮料，忌吃霉变

花生米，忌吃辛辣食物，忌吃油炸食品，忌吃红薯、土豆、豆类、汽水等产气食品，忌吃各种含有铅及其添加剂的罐头食品，忌吃沙丁鱼，青花鱼、秋刀鱼、金枪鱼，因为这些鱼脂中含有二十碳五烯酸，它是一种不饱和的有机酸，二十碳五烯酸的代谢产物——前列腺素能够抑制血小板聚集，而肝硬化病人凝血因子生成障碍，血小板减低，若进食二十碳五烯酸较多的鱼，就容易引起出血，而且这种出血很难止住。

17. 胆石病（胆结石）

胆结石又称胆石病，是一种常见疾病，从婴儿到老年人都可以发生，但40~50岁是发病的高峰年龄。胆汁郁积，胆道感染及胆固醇代谢失调是胆石病的主要病因。

健康人的肝脏每日分泌600~1000毫升胆汁，正常时能通畅地流过胆囊、胆道进入肠道帮助消化，一部分胆汁贮藏在胆囊里，倘若因胆囊胆道发炎或胆道蛔虫阻塞等原因，使胆汁流出不畅而淤滞，胆汁里的结石“原料”就容易析出和沉淀（结石“原料”是指胆汁性质改变，胆汁中的胆固醇、胆色素成分增多，它们是形成胆固醇结石、胆色素结石或混合结石的“原料”）；较大的胆固醇、胆色素颗粒可以成为结石形成的核心，细菌、蛔虫卵、死蛔虫残体等亦可作为核心形成结石。

人到中年，由于饮食、运动等各方面生活习惯的改变，无形中为胆石的形成创造了有利条件。首先是中年人体内胆石“原料”增多。有不少中年人进食较多，吃入大量脂类物

质，直接影响胆汁成份，胆固醇与胆色素的含量增加，兼之中年人运动量减少，胆囊、胆道的收缩能力降低，致使胆汁淤滞，胆汁浓缩，其中高浓度的胆盐会刺激胆囊与胆道的粘膜，削弱粘膜的抗病能力，容易诱发细菌感染。而细菌往往是形成胆结石的核心物质。

胆石病的临床表现主要有胆绞痛。胆绞痛大都在饱餐或吃高脂肪饮食后数小时内，或在腹部受到震动（例如在崎岖的路上骑车、骑马等）后发作。痛多在中上腹或右上腹，开始时呈持续性钝痛，以后逐渐加重至难以忍受的剧烈疼痛。病人常坐卧不安、弯腰打滚，用拳头紧压腹部，甚至哭喊。疼痛常放射至右肩胛处或右肩部。痛时常大汗淋漓，面色苍白，恶心呕吐。有些病人呕吐后胆绞痛可稍减轻。一次发作的时间长短不一。胆结石退入胆囊或进入十二指肠后，疼痛可完全消失。

有的病人中上腹或右上腹有饱闷感，有时有胃灼热、嗝气、嗝酸及腹胀，吃油腻食物后这些症状更明显。如合并有胆道感染，可出现黄疸、高热、寒战、头晕头痛、血压下降、白细胞增高、胆囊区压痛。

X线检查有助于胆石病的确诊。

胆石病属于祖国医学的“胆胀”、“癖黄”、“黄疸”、“胁痛”等范畴。《内经》说：“胆胀者，胁下痛胀，口中苦，善太息”。《诸病源候论》说：“气水饮停滞结聚成癖，因热气相传，则郁蒸不散，故胁下满痛，而身发黄，名为癖黄”。中医认为胆石病的病因病理是情志抑郁不畅，致使肝胆之气郁结，疏泄失常，或因饮食不节，过食油腻，致使脾胃运化失健，继而生湿蕴热，阻碍肝胆疏泄功能。湿热久蕴不散，则

胆汁久瘀不畅而凝结成为砂石。其治疗，宜疏肝理气，清热湿热。

方一：柴胡20克，黄芩20克，枳实15克，金钱草30克，元明粉10克，大黄15克。水煎服。

注：黄芩中所含黄芩甙能间接地扩张胆管平滑肌，并有解痉止痛等作用。大黄能显著增加胆汁流量，均为治疗胆石病的有效药物。

方二：虎杖30克，山楂30克，菖蒲15克，木香15克，枳壳15克，郁金15克，香附15克。厚朴12克。水煎服。

注：本方中的木香、郁金、香附、厚朴均有松弛胆道括约肌的作用，以利于结石排出。

方三：乌梅30克，金钱草30克，马鞭草30克，鸡内金15克，满天星30克，海金砂15克。水煎服。

注：本方中乌梅、金钱草、马鞭草、鸡内金均有祛胆结石作用，满天星、海金砂也有排石作用。

上述方剂可任选一方，每日一剂，至少连服七天，一般用药后一周开始排石，应嘱患者家属淘洗患者的大便，寻找结石，连续找七天以上。

治疗胆结石的验方：

①鲜满天星30克，鲜海金砂30克，大枣10枚，煎水代茶饮。

②郁金45克，鸡内金15克，柴胡30克，黄芩30克，虎杖30克，枳壳15克，生大黄10克，金钱草30克。水煎服。

③茵陈60克，龙胆草12克，栀子12克，生大黄15克，木香10克，白花蛇舌草30克，玉米须30克。水煎服。

胆结石患者的注意事项:

1. 患者应养成平卧及向右侧睡的习惯。因为胆绞痛的发作与向左侧睡有关。我们知道,胆囊形如一只小酒瓶,当人体向左侧睡时,胆囊“瓶口”朝下方,“瓶底”朝上方。这样胆囊结石在重力作用下就容易落入“瓶颈部”而发生嵌顿,引起胆绞痛发作。加上夜间病人入睡后,迷走神经张力增强,胆道平滑肌兴奋性增高,胆囊颈管一旦发生痉挛,可使结石嵌顿更严重,疼痛即刻加重且持久。

2. 患者应“吃好”早餐。据国外调查,20~35岁的女性胆石症患者多有不进早餐的不良习惯。不进早餐为什么容易引起胆结石呢?科学家初步研究认为,可能是由于空腹使胆汁分泌减少,胆汁中胆酸含量降低,而胆固醇含量不变,以致形成一种高胆固醇胆汁。如果空腹时间过久,进而使胆汁中的胆固醇呈现过饱和状态,在胆囊里沉积形成结晶,产生结石。

3. 患者应常吃能抑制胆结石的食物,以减轻症状,预防复发。

能抑制胆结石的食物有:生姜、青菜头、菠菜、青笋、莲花白、洋葱、蕃茄、四季豆、玉米、大青椒、南瓜、白萝卜、莲藕等。

据日本学者研究发现,生姜中所含的姜酚成分能抑制前列腺素的合成,并且有很强的利胆作用。人体胆红素分泌过多,可导致胆汁中粘蛋白的含量增加,而粘蛋白与胆汁中的钙离子和非结石型胆红素结合成胆石支架和核心,形成胆结石。姜酚恰好能抑制前列腺素的合成,能相对减少胆

汁中粘蛋白的形成，从而达到抑制胆结石的目的。所以，胆结石患者应多吃生姜，以减少形成胆结石的机会。

我国科学研究工作者用引流管引流出的胆汁及手术摘出的胆结石，用某些蔬菜汤剂作混合试验，发现青菜头、菠菜、青笋、莲花白、洋葱、蕃茄等蔬菜汤，对不同病例手术摘出的胆结石，有不同程度的溶解作用，加入胆汁不发生沉淀。四季豆、玉米、大青椒、南瓜、红皮白萝卜、莲藕亦有一定程度的溶解作用。

4. 患者宜少吃糖。医学科学研究证明，日常生活中精制糖摄入过多，是导致胆结石的重要原因之一。医学专家们调查了267名胆结石病人的饮食情况，并与对照组的600名健康人的饮食情况相比较，发现饮料和甜食中糖分含量的多寡与胆结石的发病率成正比。换句话说，糖吃得愈多，胆石症发病率愈高。

糖为何与胆石症有关呢？专家们认为，过多的糖分可以刺激胰岛素β细胞大量分泌胰岛素。业已证明，胰岛素会使胆固醇增加，而过多的胆固醇可以引起胆结石（胆固醇结石）。动物实验也证实了这一论点。

为了预防和治疗胆结石，奉劝患者少吃糖，并且不要使自己过于肥胖。

胆石病的预防：

脂肪类食物能增强胆囊的收缩，胆石病的急性发作期间，应禁食脂肪类食物。即使在不发作的静止期，均应少食富含胆固醇的食物如蛋黄，鱼子，动物的肝、腰、脑等。平时还应多吃蔬菜、水果，保持大便畅通，有利于胆汁的排

出。积极参加体育活动，健全体格，增强内脏功能，防止胆汁淤滞。还要驱除蛔虫，积极防治胆囊和胆道的炎症。

18. 急性胆囊炎

胆囊炎是最常见的胆囊疾病，女性病人较男性病人多。

急性胆囊炎可由细菌感染所致，亦可由高浓度浓缩的胆汁或反流入胆囊的胰液所产生的化学刺激而引起。

引起胆囊发炎的细菌可来自肠道，经胆管蔓延到胆囊，也可从血流或淋巴管中播散到胆囊。

胆囊炎发作较急。腹痛是必具症状。表现为右上腹疼痛，常伴有呕吐，疼痛可放射到右侧背部或肩部。伴有胆结石的病人发作更为突然，疼痛也更为剧烈。由于细菌的感染，病人有高热寒战，右上腹有明显压痛，并有肌肉紧张。按扪右上腹时病人不敢深呼吸，有时可扪到或看到肿大的胆囊。

胆囊炎可通过血液检查和腹部X线平片检查等而确诊。

急性胆囊炎属于祖国医学的“胁痛”、“腹痛”，“黄疸”等范畴。中医认为胆是六腑之一，以通降下行为顺，如因情志抑郁，饮食不节，引起肝胆气郁，疏泄失常，通降失调，即产生“不通则痛”的症状。如湿热熏蒸，浸淫肌表，则可发为黄疸。治宜理气活血，清热燥湿，通里攻下。

中医治疗急性胆囊炎，一般可分为以下三种类型：

1. 气滞型胁脘隐痛，闷胀痛或窜痛，并牵引肩背，伴恶心呕吐、口苦咽干，寒热往来，食少腹胀，发热不重。苔薄白，脉弦紧。治宜疏肝理气，清热止痛。

处方：茵陈30克，龙胆草12克，柴胡20克，黄芩15克，木香12克，元胡10克，白芍15克，生大黄12克，郁金12克，香附12

克，水煎服。

2. 湿热型：右上腹持续胀痛，偶有阵发，寒热往来，或身热不扬，头昏目眩，身倦无力，心烦呕恶，口渴不欲饮，多有目黄、身黄，黄如橘子色，尿黄浊，便秘，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。治宜清利湿热，舒肝理气。

处方：银花30克，连翘15克，板蓝根30克，生大黄12克（后下），黄芩15克，法夏10克，木香10克，丹皮10克，赤芍10克。水煎服。

3. 实火型：右上腹持续性胀痛，痛剧而拒按，上腹痞闷，高热气粗，口苦心烦，或有呕恶，便秘尿赤，舌质红，苔黄燥，脉弦数。治宜清肝泻火，利湿通下。

处方：生大黄12克（后下），龙胆草10克，败酱草30克，芒硝10克（冲服），生石膏30克，栀子10克，茵陈30克。水煎服。

治疗急性胆囊炎的验方：

1. 虎杖30克，黄芩15克，木香12克，丹参30克，枳壳12克，金钱草30克。水煎服。

2. 乌梅30克，五味子30克，木香12克，紫花地丁30克，半枝莲30克，大黄12克（后下），厚朴10克。水煎服。

3. 龙胆草12克，苦参30克，郁金30克，生大黄12克，猪胆汁5毫升（兑服），丹参30克，黄芩20克。水煎服。

4. 生大黄15克，芒硝12克（冲），青蒿30克（后下），柴胡30克，黄连10克，丹皮15克，赤芍30克。水煎服。

5. 熊胆10克，郁金15克，姜黄10克，茵陈30克。共研极细末，装入胶囊，每次服3克，每日服3次。

19. 慢性胆囊炎

慢性胆囊炎多有反复急性发作史。由于炎症的破坏，胆囊壁粘膜损坏，影响正常浓缩胆汁的功能，当胆囊壁严重破坏并为疤痕代替时，舒张和收缩功能也随着丧失，食物的消化和吸收均受影响。因此病人常有消化不良的表现，如食后上腹饱胀，暖气等，与溃疡病的一些表现基本相同，难以从临床上加以区别。吃了油腻食物有时可引起疼痛。若同时有胆结石存在，则常有绞痛，尤其当结石移位时绞痛更为剧烈。慢性胆囊炎的诊断比较困难，常须多次检查或进行胆囊造影方能确诊。

慢性胆囊炎属于祖国医学的“腹痛”、“胁痛”等范畴，多由饮食失节，情志不畅，脾失健运，湿浊内生，肝胆气滞血瘀所致。治宜理气活血，利胆祛湿。

方一：海金砂10克，泽泻10克，郁金12克，玄明粉10克（冲），茵陈30克，栀子10克，生大黄12克（后下），枳壳10克。水煎服。

方二：木香90克，枳壳90克，郁金90克，茵陈120克，龙胆草90克，猪胆汁500克。

先将以上各药研细和匀，再将猪胆汁熬浓至半斤；拌入以上药粉，加蜂蜜适量为丸，每丸重10克，早晚各服一丸。

方三：威灵仙30克。水煎，分2次服，每日1剂，连服10天为1疗程。

方四：青蒿30克（后下），柴胡30克，枳实12克，郁金30克，虎杖30克，金钱草30克。水煎服。

20. 心 绞 痛

心绞痛是心肌急剧的、暂时性的缺血与缺氧所引起的临床症候，其特点为阵发性的前胸压榨或疼痛感觉，主要位于胸骨后部，可放射至心前区与左上肢。

心绞痛典型的发作是在劳动或兴奋时、受寒或饱餐后突然发生前胸疼痛。疼痛的部位是在胸骨上段或者中段之后，亦可能波及大部分心前区，疼痛可放射至肩、颈、背、上肢，甚至直达小指与无名指。疼痛多为压榨性，窒息性或闷胀性，有时伴有濒死的恐惧感觉。每次发作历时1~5分钟。休息后或用药后可缓解。病重者心绞痛也可在休息时（包括夜间）发生。发作时患者面色苍白，表情焦急，不愿活动，出冷汗。心绞痛，根据患者的疼痛发作特点，结合心电图检查（特别是心电图的运动试验，饱餐试验等），可以确诊。

心绞痛，属于祖国医学的“真心痛”、“胸痹心痛”、“厥心痛”等范畴。中医认为由于血脉瘀阻，心脉不通，气机不畅，即心血不通，引起的心痛、胸闷，此属标证。而病的本质是由于脏腑功能衰弱所致，属于虚证。

治疗原则：

（一）急则治其标

1. 急救处理可采用以下药物：

①. 寒心舒气雾剂（适用于舌淡苔白之心绞痛患者，这种气雾剂有温通散寒、理气止痛的作用。主要成分为肉桂、香附等，北京中药厂出品），对准舌下，每次喷雾1~2下。

②. 热心舒气雾剂（适用于舌红苔黄之心绞痛患者，这种气雾剂有凉血清热、活血止痛的作用。主要成份为丹皮、川芎等，北京中药厂出品）对准舌下，每次喷雾1~2下。

③. 麝香保心丸，1～2粒含服或吞服。有芳香温通，益气强心的作用。主要成份为麝香、蟾酥、人参提取物等（上海中药制药一厂出品）。

④. 速效救心丸，1～3丸含服。有活血理气的作用。主要成分为川芎、冰片等（天津第六中药厂出品）。

⑤. 苏冰滴丸，2～4丸含服。有芳香开窍、理气止痛的作用，主要成分为苏合香、冰片等，（上海中药制药一厂出品）。

⑥. 活心丸，1～2丸含服或吞服。有养心活血的作用，主要成分为人参、灵芝、麝香、熊胆等（广州白云山中药厂出品）。

对于重度心绞痛患者，或经上述急救治疗无效者，可配合吸氧，或选用川芎嗪针、丹参针、生脉针静脉滴注。

2. 针灸治疗

主穴分两组，取穴膻中和内关、巨阙和间使，交替轮换，每日针刺一次，获得酸、胀、麻等针感后，留针15分钟，10次为一疗程。

（二）缓则治其本

急救处理后应根据辨证论治原则进行分型治疗。

1. 气阴两虚型

胸部隐痛，五心烦热，汗多，口干，气短乏力，舌红少苔或舌淡苔薄黄，脉细数或代、促。

方药：人参叶30克，麦冬30克，五味子20克，生地30克，白芍30克，桂枝12克，黄芪30克。水煎服。

2. 心阳不振型

胸部闷痛时作，形寒心悸，面白肢冷。舌淡胖苔薄白，脉沉细或沉迟或结代，甚则脉微欲绝。

方药：炙甘草12克，党参60克，桂枝15克，熟地20克，阿胶12克，干姜10克，瓜蒌15克，薤白30克，白酒30毫升，枳实10克，水煎服。

3. 心血亏损型

忧思隐痛，虚烦惊惕，心慌不宁，少寐多梦。舌尖红少苔或舌淡苔薄白，脉沉细弱或细数。

方药：党参30克，白术15克，黄芪30克，茯苓30克，龙眼肉12克，当归15克，远志10克，酸枣仁15克，炙甘草12克，大枣30克，生姜10克。水煎服。

4. 痰浊闭塞型

闷痛痞满，口粘乏味，纳呆脘胀。苔腻或白滑或黄，脉滑或数。

方药：陈皮12克，法半夏12克，茯苓30克，枳实12克，柴胡15克，白芍30克，甘草10克，郁金40克，玄胡12克，三七粉3克（冲服），瓜蒌15克。水煎服。

5. 心血瘀阻型

胸刺痛，痛有定处，面晦唇青，怔忡不宁。舌质紫暗或见瘀斑，或舌下脉络紫胀，脉涩或结、代。

方药：生蒲黄10克，五灵脂10克，葱白3枚，丹参30克，赤芍30克，三七粉3克（冲服），桂枝15克，郁金30克。水煎服。

6. 寒凝气滞型

遇寒则心痛发作，彻背掣肩，手足欠温。舌淡苔白，脉沉迟或弦紧或促。

方药：桂枝15克，枳实12克，瓜蒌15克，薤白30克，玄胡12克，川楝子12克，丹参30克，黄芪30克，党参30克。水煎服。

（三）护理要点

1. 发作频繁（每日发作3次以上），程度较重者，应卧床休息。病情稳定时宜强调适量运动，以助气血流畅，但要量力而行，以不引发心绞痛为度。

2. 作好思想工作，解除患者的顾虑和恐惧心理，减少情绪波动。

3. 忌肥甘厚味，忌烟酒。饮食宜清淡，食不过饱，不饥为度。心绞痛寒证患者（舌淡苔白）宜适当多吃山楂、木耳、茴香、葱头、生姜等。热证患者（舌红苔黄）宜适当多吃冬瓜、芹菜、蕃茄、黄瓜等。

4. 注意保暖，避免劳累，保持大便通畅，便秘时可服麻仁丸或番泻叶。

（四）心绞痛患者注意事项

1. 宜采取头高脚低的睡眠姿势。最近国外医生提出，心绞痛患者在夜间睡眠时，应采取头高脚低的姿势，做到床头比床尾高出20~25厘米。即在床头的两个床脚垫两块厚25厘米的木块即可。这样就可以减少甚至消除心绞痛发作。但必须注意的是，如仅抬高床的上半部（半坐位），是无效的。采取头高脚低的睡眠姿势可减少回心血量，使中心静脉压和肺动脉舒张压明显下降，从而减少心绞痛发作。

2. 患者宜在睡前和早晨散步。

心绞痛进一步发展，可导致心肌梗塞。而心绞痛患者如能坚持在睡前和早晨散步，则能防止心肌梗塞。

在睡眠时，身体活动水平下降，心脏输送的血液量减少，处于休息阶段，此时血管内腔变得狭窄，脂肪容易在毛微血管内沉淀。吃了晚饭后，由于摄取了营养物，血液变粘，到

天明时的血液更浓粘，浓粘的血液处于没有弹性的细小血管中，就很容易产生心肌梗塞。

睡前散步，可以使下肢末梢血管畅通，血流加速，新陈代谢增强，血液中的陈旧废物容易排出体外，这样血流就处于畅通无阻的状况。如在早晚散步前饮一杯水，血液会变得稀薄，这样，心绞痛患者就能防止心肌更塞的发作。

3. 患者忌受寒。心绞痛患者如果突然受寒，会使去甲肾上腺素分泌增加，心率加快，心肌耗氧量增多，容易引起心肌梗塞。因此，心绞痛患者切忌受寒。

21. 血脂过高症

当血浆胆固醇或甘油三酯含量高于正常时，分别称为胆固醇过高症或甘油三酯过高症。几种血脂或所有血脂成份均增高则称为血脂过高症。

我国正常成人空腹时血脂的含量如下：

甘油三酯	20—110毫克%
总胆固醇	120—200毫克%
游离胆固醇	30—70毫克%
胆固醇酯	90—130毫克%
游离脂肪酸	0.2—0.9毫克当量/升

在临床上具有重要意义的血脂成分是甘油三酯和胆固醇。

患有糖尿病、肾病综合征、肝胆疾病、胰腺炎等疾病时，可伴有血脂增高。近年来更发现高脂血症与动脉粥样硬化有密切的关系，动脉粥样硬化最早期的病理变化是动脉壁胆固醇

醇和胆固醇酯的沉积，患者的血胆固醇或甘油三酯的浓度常高于健康人。对胆固醇或甘油三酯升高的人群进行随访观察，动脉粥样硬化的发病率比血脂正常的人群为高。动物实验也证明，喂饲大量的胆固醇可诱发实验性动脉粥样硬化。目前认为，脂类的代谢失调（血脂的蓄积）是动脉硬化的标志，高脂血症是冠心病的“促进因素”或“危险因子”，因此，探讨高脂血症的治疗就成为防治冠心病的重要手段之一，也即是说，及时地纠正高脂血症，有可能减轻或推迟动脉粥样硬化及其并发症（冠心病）的发生。

中医药治疗高脂血症有较好的疗效。

方一：白金丸（成药，内含白矾、郁金），每次服6克，每日三次，饭后服，20天为一疗程，连服2~3个疗程。

方二：三七3克，山楂30克，泽泻60克，决明子15克，虎杖30克。（近年研究证明，泽泻每日用量大于60克方有明显降脂作用）。水煎服。

方三：首乌30克，丹参30克，赤芍15克，红花10克，琥珀10克，当归15克，黄精30克，大枣30克，夜交藤30克。

服法：水煎服（本方尤其适用于失眠、便秘的高脂血症患者。）

方四：寄生30克，杜仲15克，玄参15克，菌灵芝30克（先熬），金樱子30克，枸杞15克，骨碎补10克。

服法：水煎服（本方尤其适用于有肾虚表现的高脂血症患者）。

方五：水牛角粉12克。

服法：加水煎2小时后分二次连渣服。服后有轻泻、腹胀等反映，不需处理。本方不仅能降低胆固醇和甘油三酯。

而且还能减轻体重，尤其适用于肥胖的高脂血症患者。本方药源广泛，价廉，可用水牛角加工时刨下的刨花磨粉，煎服。

注：上述第二、三、四、五方都有降血脂的作用，安全，价廉，效著，可长期服用。

方六：草决明85克，山楂45克，丹参90克。上药分别粉碎后，留草决明粉5克，其余水煎3次浓缩成稠膏，放冷至60℃时，加入草决明细粉5克，制成片剂口服，每片含浸膏0.25克，相当于生药2.9克，每次服2~4片，每日服3次，连服一个月为一疗程。

方七：丹参30克，首乌15克，黄精15克，桑寄生15克，葛根15克，甘草5克。水煎服，每日1剂，亦可作成片剂常服。

血脂过高症患者的注意事项：

①应坚持慢跑。这是极为重要的治疗手段之一。人体需要胆固醇，胆固醇在体内无所不在，胆固醇是人体不可缺少的物质。问题是如何防止胆固醇在血管壁内沉积。

人体内胆固醇是与脂蛋白结合在一起的。脂蛋白一般可分为高密度脂蛋白和低密度脂蛋白，低密度脂蛋白把胆固醇在血管壁上，形成动脉粥样硬化斑块，而高密度脂蛋白能把动脉粥样硬化斑块上的胆固醇移走。人体高密度脂蛋白含量多，就能够防止动脉粥样硬化。喜欢运动的人的血液中高密度脂蛋白含量就多。如果每天慢跑半小时，几个月后高密度脂蛋白就会比原来高10%以上。

②应多吃富含多链不饱和脂肪酸的食物。正常人血浆胆固醇有两个来源，大部份来自富含胆固醇的食物，如蛋黄、

奶油、肥肉、动物内脏等，属外源性胆固醇；另一部份由体内合成，属内源性胆固醇。

医学研究表明，多链不饱和脂肪酸可促进肝内胆固醇氧化为胆酸而排出，且与胆固醇结合成酯而向血管外转移，又可形成磷脂而稳定脂蛋白分子，防止胆固醇及其酯化物沉积。故高胆固醇血症患者平时宜多吃富含多链不饱和脂肪酸的食物如胡桃、大豆油、玉米油、棉子油、花生油、芝麻油等等。

③.“糖致高脂血症”患者宜少吃糖。摄入过多糖类引起的高脂血症，医学上称为“糖致高脂血症”（甘油三酯增高）。高脂血症是冠心病的“促进因素”或“危险因子”。因此，有高脂血症倾向的人，应少吃糖（每天不应超过50克）。

④. 宜常吃降胆固醇的食物如玉米、花生、大蒜、香蕈、葵瓜子、红枣、红辣椒、牛奶、鱼（包括带鱼）等等。

玉米是胆固醇吸收的抑制剂，花生有降低胆固醇的作用。大蒜既能降胆固醇和甘油三酯，又可补充微量元素硒，是防治高脂血症和冠心病的理想食物。香蕈、葵瓜子对高脂血症有良好的预防和治疗作用。红枣既能降血脂，又有保肝、强壮、防癌等多种功效。红辣椒中的番椒素能降胆固醇。牛奶中的乳清酸能抑制胆固醇的合成，降低血液中胆固醇的总量。酸牛奶也有降胆固醇的作用。鱼中所含的鱼肝油等物质，能降胆固醇。带鱼鳞油更是降胆固醇的理想食物。

22. 单纯性肥胖症

肥胖系人体脂肪积聚过多所致。当进食热量超过消耗

量，多余的营养物质主要转化为脂肪，储存于各组织及皮下，形成肥胖。或因其它病理原因，增强了脂肪的贮存，也可形成肥胖。一般以超过标准体重10%为过重，超过20%以上者为肥胖。

标准体重的计算方法：身高（厘米）-105=标准体重（公斤）。

例加：身高170厘米-105=65（公斤）。即是说，一个身高1米7的人，他的标准体重应该是65公斤。身高1米6的人，他的标准体重应该是55公斤。超过这个标准10%就叫过重，超过这个标准20%就称为肥胖。

肥胖可分为单纯性肥胖和继发性肥胖两种。

继发性肥胖常继发于其他疾患，例如脑炎、脑部损伤、肿瘤等原因引起下丘脑损害时，可发生肥胖；肾上腺皮质机能亢进症、性腺机能不足、甲状腺机能过低，也可发生肥胖；糖尿病、胰岛素分泌过多性低血糖患者也可常因多食而肥胖。

本文着重谈谈单纯性肥胖。

单纯性肥胖多发生于40岁以上，尤以女性为多。显著肥胖常造成身体的额外负担，患者畏热，多汗，呼吸短促，容易疲乏，不能耐受较重的体力劳动，常有头晕、头痛、心悸、腹胀、下肢轻度浮肿等。极度肥胖可产生肺泡换气不足，出现缺氧及二氧化碳潴留，嗜睡。严重时导致心肺功能衰竭。

肥胖的人对感染的抵抗力较低，容易发生冠心病、高血压病、糖尿病、痛风、胆石症等，各关节还可有退化性病变，常有腰酸、关节疼痛等症状。妇女月经减少，常有闭经、不育等现象。因此对单纯性肥胖应积极医疗，不可忽

视。

祖国医学认为肥胖症乃真元之气不足，痰湿内停所致。中医认为，脾主肌肉，能消化饮食，运输水谷精微到全身，以营养五脏六腑、四肢百骸。若真元之气不足，不能正常输布水谷之精微，变生脂肪痰湿蓄积于肌肤之中，而成为肥胖之疾患，陈修园说：“大抵素禀之盛，从无所苦，惟是痰湿颇多”。汪昂说：“肥人多痰，而经阻，气不运也”。

其治疗，宜燥湿化痰，消食理气。

方一：黄芪15克，党参15克，防己15克，白术15克，首乌30克，泽泻60克，山楂30克，茵陈30克，水牛角30克，仙灵脾30克，大黄10克。水煎服。

方二：三七3克，补骨脂12克，番泻叶10克，大黄10克。水煎服。

方三：首乌30克，当归30克，鸡血藤30克，茯苓20克。水煎服。

方四（耳针疗法）：耳穴主穴取饥点、口、肺、脾。配穴取内分泌、直肠下段、肾。贴敷药物为白芥子、王不留行。治疗时选取敏感之穴位，将白芥子或王不留行药粒贴敷穴位上，按压2~3分钟之后。用胶布固定，每周贴换一次，5次为一疗程。休息10天，再作第二疗程。

以上方法不仅能减肥，而且能降低血中甘油三酯和总胆固醇，调整机体的代谢，使紊乱的物质、能量、水盐代谢重新恢复平衡。

1. 单纯性肥胖症患者的注意事项：控制饮食，特别是晚餐更要控制进食量。科学实验证明，上半天进食对体重的影响要比下半天小。这是因为，一到傍晚，血中胰岛素的含量就上升

到最高峰。胰岛素可使血脂转化成脂肪贮存在腹壁之下，日积月累的脂肪堆积、会使人日益发胖。晚饭吃得过饱、血脂量猛然升高，加上人在入睡后血流速度明显降低，因此大量血脂容易沉积在血管壁上，造成动脉粥样硬化等疾患。

有人做过实验，两组人进食同样同量的食品，一组在早上七点进食，另一组在晚上六点进食。两组人一天就吃这一餐。结果，早晨进食者体重逐渐下降，晚上进食者体重不断增加（这是生物钟原理造成的）。

不少人不习惯于晚上吃得少，但对于肥胖症患者来说，一定要做到晚餐吃得少。晚餐可以多吃海带及蔬菜等粗纤维的食品，既能防止便秘，又能供给人体所需要的微量元素，防止动脉硬化，改善微循环，一举多得。

2. 体育锻炼也是防止发胖的好办法；步行、爬楼梯、跳绳等活动量较大时，额外的能量消耗必须动用原来储备的养料，这时，脂肪供应的能量比糖要大一倍左右，因此，储备的脂肪就被动用了。经常运动，皮下多余的脂肪就会不断被消耗掉，人就不胖了。

适合单纯性肥胖症患者锻炼的方法有以下几种：

①爬楼梯健身锻炼法：适当爬楼梯，对肥胖症患者很有好处。因为上楼要把腿抬高，兼有走和跳两个动作，所以比在平地走路活动量大得多，能起到减肥作用。据生理学家测定，一个60公斤体重的人，爬10分钟楼梯要消耗热量200卡，下楼梯消耗的热量为上楼的三分之一。在同等时间内，爬楼梯消耗的热量比游泳消耗多两倍半，比散步多四倍。

②步行锻炼减肥法：步行减肥，简而易行，人人都能办到。慢跑和步行能使体内脂肪更有效地燃烧，因而减肥的效

果肯定。据科学家测定,50%强度(中等强度)的运动(如步行、慢跑等),可使血液中的乳酸剧增,乳酸主要来自脂肪,乳酸剧增,脂肪的消耗(燃烧)便会增加。通俗地说,每天步行1小时,时速为5.5~6公里,脂肪的燃烧效率最佳。这样步行2~3个月后,减肥定会大见成效。

③跳绳减肥法:跳绳减肥也是非常有效的。据报道,美国、加拿大、墨西哥、巴西等国家的减肥者,通过跳绳运动,健身减肥,效果很好。据说,大腹便便者只要经过一年左右的跳绳锻炼,多余的脂肪便会不翼而飞。36岁的加拿大人雷德弗里克·皮尔逊,体重130公斤,他跳绳九个月,减去体重60公斤。

④饭后适量活动减肥法:饭后进行适量活动(例如散步20分钟等等),对于减肥也是很重要的,肥胖者切忌饭后即睡。

⑤食物减肥疗法也是肥胖者值得采用的措施。

减肥总离不开节食和运动两个环节。然而,有些食物实际上有消耗人体热量、减少体内脂肪的作用。多吃这些食物,不但不会肥胖,反而有减肥的功效。减肥食物主要有:

卷心菜:含有硫和铁质,它们联合起来能把顽固的热量通过胃肠道消除出去。

胡萝卜:含有胡萝卜素,可加速人体代谢和分解热量的积聚。

芹菜:含矿物质,能增强腺系统,产生能防止体重增加的激素。

蕃茄:含丰富的维生素C和天然酸,可加速人体代谢,促进肾脏过滤脂肪存积。

大豆:含卵磷脂等,有助于消除身体内的脂肪存积。

柑桔类水果：含丰富的维生素C，使脂肪更易被清除。

苹果、草莓：含天然物质，能限制细胞吸收热量和脂肪。

木瓜：含有木瓜蛋白酶，能分解脂肪组织。

菠萝：含有丰富的菠萝蛋白酶，可以消除积聚的脂肪。

啤酒酵母：含有丰富的铬，有消耗脂肪的作用。

葱：有抗血小板凝聚的作用，这种凝聚能导致热量和脂肪太多。

绿豆芽：含水分较多，被身体吸收产生后热量较少，更不易形成脂肪堆积在皮下。

韭菜：含纤维素很多，有通便作用，能排出肠道中过多的营养。

黄瓜：含丙醇二酸，能够抑制食物中碳水化合物在体内转化成脂肪。

白萝卜：含芥子油等物质，能促进脂肪类物质更好地进行新陈代谢，防止其在皮下堆积。

冬瓜：有利水作用，可使肥胖者逐渐消瘦。

大蒜：能除去一些帮助合成脂肪酸或胆固醇的酸，因而具有减肥作用。

魔芋：能化痰散结行瘀，有减肥作用。

此外，常喝醋也有良好的减肥效果。食醋中所含的氨基酸除了可以促使体内过多的脂肪消耗转变为体能外，还可以使摄入的脂肪与蛋白质等的新陈代谢的顺利进行，因而具有良好的减肥作用。

23. 钩端螺旋体病

钩端螺旋体病是由一组不同血清型别的钩端螺旋体所引

起。病原体可从患者的血液、尿中分离到，也可从鼠类及家畜以及疫水中找到。最主要的保菌和带菌宿主是鼠和猪，在尿中长期排菌，成为本病的主要传染源。

钩端螺旋体可通过皮肤侵入人体，故接触污水，是本病感染的主要方式，在疫区从事犁田、割谷、耨秧、施肥、捕鱼、防洪、排涝、游泳等活动，均可引起感染。

钩端螺旋体病的特征是发热，酸痛，一身疲乏，眼红，腿疼，淋巴结肿大。临床表现复杂多样，其具体症状和体征表现最多的是发热，眼结合膜充血，腓肠肌痛，头痛，衰弱无力，畏寒，腹股沟淋巴结肿大；头晕，尿少，出血倾向（咯血痰，眼结合膜出血，鼻出血，大便下血，皮肤出血），口渴，呕吐，咳嗽，不能步行，全身酸痛，各种疼痛（颈痛，腰痛，胸背痛，腹痛，两下肢痛）等等。

钩端螺旋体病通过血清学凝集溶解试验或病原体分离，可以确诊。

钩端螺旋体病属于祖国医学的“湿温”、“暑湿”范畴，其基本病机为暑湿合化，湿热蕴蒸，因而确定以清热、除湿、解毒为基本治疗法则。

基本方：银花30克，连翘30克，黄芩18克，白茅根30克，栀子15克，竹叶12克，藿香12克，芦根30克，通草9克。

加减：鼻衄、咯血明显者，上方去藿香，加藕节45克、茜草炭15克；发现黄疸者，上方加茵陈30克、枳壳12克、郁金12克，烦躁不安或呕吐者，可于上方加竹茹12克。

对肺大出血及心力衰竭患者，则采用中西医结合治疗。

用以上方药治疗钩端螺旋体病，疗效可靠，没有任何副作用及复发现象，与青霉素治疗的资料比较，临床症状消失

较快，后发热的现象较少。对青霉素过敏的患者，用以上方药治疗更为合适。

中医治疗钩端螺旋体病，也可分为以下五种类型进行辨证施治：

1. 暑温型：发热，头痛，头晕，口渴，目赤，倦怠，小腿痛，尿黄，或畏寒，身痛，面赤、呕吐，舌红、苔黄，脉弦数。治宜清热解毒祛湿。

处方：黄芩18克，青蒿18克，佩兰12克，白茅根30克，生石膏30克，鱼腥草30克（后下），土茯苓30克。水煎服。

2. 湿温型：发热，畏寒，身倦，四肢沉重，头昏胀闷，胸痞闷，腠肠肌酸痛，尿少，目赤，苔白腻，脉濡数。治宜清热除湿化浊。

处方：藿香12克，佩兰12克，千里光60克，青蒿18克，连翘30克，滑石30克，穿心莲30克。

3. 湿痹型：发热，畏寒，头痛，周身痛，小腿痛，步行困难，尿少，舌润苔白，脉滑。治宜化湿清热透络。

处方：黄芩18克，桑枝30克，苡仁30克，秦艽15克，鸭跖草30克，银花30克，茵陈30克，蚕沙12克，丝瓜络30克，山栀15克。水煎服。

4. 暑瘵型：发热，头痛，头晕，目赤，剧烈咳嗽，咯血，吐血，心慌，喘促，气急，鼻煽，脉细数或沉伏。治宜泻火解毒，凉血散血。

处方：犀角3克（锉屑冲服），生地30克，白茅根60克，赤芍15克，黄连12克，红参6克（嚼服），元参30克，旱莲草30克，地榆15克，板蓝根30克，银花30克。水煎服。

5. 瘟黄型（阳黄）：发热，目黄，身黄，黄如橘子色，

尿少，周身不适，舌黄，苔灰腻，脉滑数。治宜清热解毒，利湿退黄。

处方：茵陈30克，栀子15克，黄柏12克，黄连12克，青蒿18克，白茅根30克，千里光60克。水煎服。

防治钩端螺旋体病，要做到早发现，早诊断，早治疗，而且要就地治疗，争取时间尽快给予休息和药物治疗。对重症病人，应采取抗菌、解毒、镇静、强心、止血等中西医结合的综合治疗措施。

预 防：

- 1.管好传染源：灭鼠，管好家畜等。
- 2.切断传播途径：管水，管粪，保护水源，在大雨之后，不在污水中游泳、洗衣、洗澡等。
- 3.保护易感人群：打预防针。在流行期可服用银花、茅根、千里光、鱼腥草各30克，水煎服。或服穿心莲片，每人每日3克，连服3~5周。

24. 膀 胱 炎

膀胱炎是在身体抵抗力较差的情况下由细菌侵入而引起的一种常见病。细菌可以从血液或淋巴进入膀胱，但较常见的是从尿道上升（如尿道炎）或从肾脏下降（如肾盂肾炎）而进入膀胱。如果膀胱排尿不畅或膀胱有结石、结核、肿瘤等疾病时，就更容易引起发炎。

急性膀胱炎起病突然，其主要特征是尿频（排尿次数增多）、尿急（控制不住）、尿痛（尿道有烧灼或疼痛的感觉）、脓尿（尿色混浊，显微镜下可看到大量脓细胞）。

单纯的急性膀胱炎不引起发热、寒战、肠道不适等全身症状。如果有发热等症状，就表示有肾盂肾炎等泌尿系感染。

急性膀胱炎的病程较短，一般5—7天可治愈。若延误治疗，转入慢性，则病程可达数月以至数年。

膀胱炎的诊断，除尿路刺激症状（尿频、尿急、尿痛）和下腹部压痛外，尿液检查有脓细胞、红细胞即可确诊。

膀胱炎属于祖国医学的“热淋”、“溺血”、“下焦湿热”等范畴。中医认为是由于湿热毒邪蕴结下焦所致。治宜清利下焦湿热。

方一：车前草30克，黄柏10克，知母15克，土牛膝15克，生地30克，竹叶12克，木通10克，甘草梢6克。水煎服。

方二：石苇30克，鸭跖草30克，泽泻10克，丹皮12克，银花藤30克，篇蓄10克，瞿麦10克。水煎服。

治疗膀胱炎的单方验方：

1.鱼腥草（侧耳根）60克，炖瘦肉，每日一剂，连服1~2周，可治慢性膀胱炎。

2.生南瓜子30克，连壳嚼服，每日一剂。南瓜子有利尿作用，没有副作用，治疗膀胱炎，痊愈后不易复发。

25. 前列腺肥大

前列腺肥大是老年男子比较常见的疾病，大多数发生在50~70岁之间。发病可能与内分泌因素及前列腺慢性炎症等

有关。

前列腺腺体增大后，可阻塞尿道前列腺部及膀胱颈，使膀胱逐渐扩张，膀胱肌肉肥厚，以后输尿管也可发生扩张，引起肾盂积水和肾功能衰退，严重的可引起尿毒症。

前列腺肥大的主要症状是膀胱颈部阻塞而引起排尿费力，尿流变细，排尿次数增多，尤其是在晚间更为明显。前列腺肥大的早期尿液还能完全排空，以后阻塞情况逐步加重，尿液不能完全排空，因而在膀胱内可有残余尿。最后可发展成为完全性的尿潴留或充盈性尿失禁。

尿潴留可由寒冷、饮酒或受其他刺激后突然发生。病人有下腹部膨胀，疼痛，尿急的感觉，但尿液排不出。

前列腺肥大经直肠指诊检查、残余尿量测定、膀胱镜检查或将造影剂注入膀胱作X线摄片等检查后可以确诊。

前列腺肥大属于祖国医学的“癃闭”范畴。其原因为：痰湿壅塞，或肾气亏虚，膀胱气化无权。治宜健脾利湿，益肾补气，活血通窍。

方一：牛膝12克，桃仁12克，大黄10克，当归12克，通草10克，冬葵子10克，车前草30克，滑石30克，桂枝10克。水煎服。

注：本方适用于大小便不通，少腹急结，舌瘀脉涩的前列腺肥大的患者。古人说：“血瘀小便秘者，则以牛膝、桃仁为要药”。这完全是经验之谈，临床上用之多效。

方二：寄生30克，牛膝12克，肉桂3克，制附片20克(先熬)，山药30克，茯苓30克，熟地15克，丹皮15克，泽泻20克，女贞子30克，车前草30克。水煎服。

注：本方适用于年老肾气亏虚的前列腺肥大的患者。

方三：泽泻50克，红参25克。水煎服。

注：本方适用于年老气虚的前列腺肥大的患者。

方四：大黄10~30克，滑石20~30克，皂角10克。水煎服。

注：方中大黄、滑石用量可随证加减。

方五：蜣螂，研细末，每日服3克，开水一次送服。虚证加用补中益气汤，实证加用龙胆泻肝汤。

蜣螂有攻坚破症、活血祛瘀作用，能使前列腺腺体缩小，尿道梗阻解除。《本事方》说：推车散（蜣螂别名推车客）可治“大小便秘”。《本草纲目》也指出蜣螂能“治大小便不通”。可见古人对蜣螂有利于尿路梗阻的治疗。早已有实践经验。

方六：生葱白500克，切碎与麝香0.1克拌匀，分二包，先置脐上一包，热熨15分钟，再换一包，冰水熨15分钟，交替使用，以小便通为度。

针灸治疗前列腺肥大，也有较好疗效。取穴：关元、气海、曲骨、三阴交。强刺激，不留针。

26. 慢性前列腺炎

慢性前列腺炎是一种男性成年人的常见病，往往与后尿道炎、精囊炎、副睾炎同时并存，是尿道感染的一部分。慢性前列腺炎的症状颇不一致，有的虽有前列腺肿胀，前列腺液出现较多的白细胞，而临床上无明显的自觉症状。典型的症状为会阴、腹股沟、精索、睾丸部不适，腰痛，轻度尿频、尿后点滴不尽、尿道口灼热刺痛或尿道口有分泌物渗出，常伴有性欲减退及遗精等，前列腺液检查有脓细胞。

慢性前列腺炎的诊断,除泌尿系统自觉症状外,还可根据前列腺液涂片镜检白细胞增多,卵磷脂小体减少,直肠指检前列腺肿胀触痛等而确诊。

慢性前列腺炎属于中医的“淋浊”范畴。《内经》指出,燥气偏盛时,“小便黄赤,甚则淋”,湿气偏盛有“病中热胀,脾受积湿之气,小便黄赤,甚则淋”。《诸病源候论》说“若饮食不节,喜怒不时,虚实不调,则脏腑不和,致肾虚而膀胱热也”。说明急性阶段的病理主要是湿热下注,慢性阶段,则多为肾虚而夹有湿热或血瘀。治疗常以通利为原则,结合标本缓急而施治。部分患者经治疗后镜检虽然明显好转,但临床见证,例如少腹拘急、会阴胀痛及精索睪丸部不适等缠绵难愈,则可按经络辨证,以疏肝理气、活血化瘀、清热利湿等法治之。

中医治疗慢性前列腺炎一般可分以下三种类型:

1. 湿热型: 小腹及会阴胀痛,尿频数、短涩,终末尿浑浊,或大便时尿道滴白。前列腺液镜检白细胞增多,苔黄腻,脉滑数。治宜清热解毒,活血化瘀。

处方: 赤芍10克,丹皮10克,当归12克,黄柏10克,泽泻15克,银花24克,紫花地丁30克,王不留行10克。水煎服。

2. 肾虚型: 腰腿酸软,神疲乏力,小便频数,余沥不尽,眩晕,多梦,苔薄脉细。治宜利湿化浊,健脾益肾。

处方: 山药30克,寄生30克,续断20克,枸杞20克,赤芍10克,丹皮10克,牛膝12克,蒲公英30克,茯苓30克。水煎服。

3. 瘀滞型: 少腹、会阴胀痛,痛引精索睪丸,前列腺肿大,质硬,触痛,苔薄白,舌质暗或有瘀斑,脉弦细。治宜理气化瘀,清热利湿。

处方：延胡索15克，赤芍15克，王不留行25克，木香10克，皂刺15克，黄柏25克，败酱草30克，蒲公英25克，丹皮15克，穿山甲15克。水煎服。

说明：慢性前列腺炎的治疗不宜长期使用抗菌素。因长期用抗菌素副作用大，进入前列腺内的药物达不到有效的治疗浓度，故效果不大。而前列腺炎的主要病理变化是腺小管梗阻、炎细胞湿润和腺体纤维增生等，故应结合淋病病机的特点采用活血祛瘀、清热解毒的治疗方法。方中丹皮、赤芍凉血化瘀消肿，黄柏清下焦之湿热，败酱草、蒲公英清热解毒消肿，穿山甲、皂刺攻坚散结，木香、延胡索理气活血，王不留行通脉消肿。诸药合用，活血散结，解除前列腺腺小管的梗阻，消炎解毒，从而收到治疗效果。

治疗慢性前列腺炎的单方验方：

1.生南瓜子30克，去壳嚼服。本方无副作用，治愈后不易复发。

2.蒲公英注射液，每次肌注1毫升，每天两次。

3.生地30克，扁蓄30克，瞿麦30克，山药20克，山萸肉10克，丹皮10克，茯苓10克，泽泻30克，车前草30克，桔梗15克，海金砂10克，木通10克，竹叶10克。水煎服，每日1剂。

4.毛冬青（干品）300克。将毛冬青切碎，加水煎煮30~60分钟，共煎3次，将3次煎液混合浓缩至100毫升，即可使用。若加适量防腐剂（如0.05%尼泊金），或高压消毒（10磅压力115℃，30~45分钟）可备用3个月。使用时，取毛冬青煎剂100毫升，加温至35~38℃，患者取侧卧位，以

无菌的中粗导尿管轻柔插入肛门内7~8厘米，再用大注射器将药液缓慢注入，保留灌肠。每晚睡前一次，连续14次为一疗程。灌肠后嘱控制排便（灌肠前可先排便），尽量保留药液至次日，以使药物充分吸收。

5. 黄芪30克，茯苓30克，丹参30克，大黄10克（后下），穿山甲10克，桃仁10克，川牛膝15克，肉桂6克，芒硝6克（冲），气虚明显者黄芪可重用至90克。水煎服，每日一剂。

6. 麝香0.15克，白胡椒7粒。此为一次用量。按此比例配制，白胡椒研细末装瓶密封备用。用药前先将肚脐用温水洗净擦干，倒入麝香粉，再盖上胡椒粉，最后盖一圆纸片，外用胶布固定，须贴紧，勿令药粉漏出。每7~10天换药一次，10次为一疗程，每疗程间休息5~7天。

7. 猪苓30克，茯苓30克，当归15克，黄芪60克，小茴香15克，大枣10克，甘草3克，水煎服，每日一剂。

27. 中 暑

人体在代谢过程中产生大量的热，这些热必须以一定的方式散发出去，这样才能使人体的正常温度维持在 37°C 左右。如果外界环境的气温高，人体的蒸发散热受阻，或身体通过一系列调节还不能维持体热平衡而大量积蓄余热时，就可能发生中暑。

中暑可分为三种类型：

1. 先兆中暑：在高温环境下劳动一定时间后，感到昏眩、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、大量出汗。这就是先兆中

暑。若及时离开高温环境，以上这些先兆中暑的症状就可以消失。

2.轻症中暑：除有上述先兆中暑的症状外，患者体温随之上升至 $38\sim 39^{\circ}\text{C}$ ，面色潮红，皮肤灼热，大量出汗，脉细弱，血压下降，呼吸急促。也有的患者体温不高，皮肤湿冷，面色苍白。

3.重症中暑：上述症状进一步加重，并出现昏迷或痉挛等神经系统症状。

中暑，祖国医学称之为“中热”、“暍病”，俗称“发痧”。中医认为系感受暑热或暑湿秽浊之气，邪热内郁，蒙蔽清窍所致。治宜清暑解热化湿。

中医治疗中暑，按症状轻重不同而辨证施治。

1.轻症：头痛，头晕，目眩，心悸，身热，胸闷，恶心，呕吐，苔腻，脉数。治宜清暑化湿。

处方：西瓜翠衣（西瓜皮）30克，藿香、青蒿、佩兰、连翘各10克，银花15克，新鲜荷叶半张。水煎服。

推拿疗法：重拿合谷、内关、大中等穴。

瘀血（刮痧）疗法：用边缘光滑的磁匙蘸冷水或植物油，在脊柱两侧、肋间等处，自上而下，由轻到重地刮，以出现红紫色和出血点为度。

2.重证：高热，汗多或无汗，口渴多热，烦躁不安，甚则昏迷、抽搐。舌红、苔黄，脉洪数。治宜辛寒清热。

处方：生石膏60克，知母15克，芦根30克，麦冬15克，竹叶12克，西瓜翠衣30克，石斛15克，人参6克。水煎服。

出现昏迷、抽搐症状者，加紫雪丹1.5克，冷开水化服。

针灸疗法：针刺十宣、百会、人中、涌泉（用于昏迷）、

大椎、合谷、曲池、委中、承山（用于抽搐）。

中暑患者的注意事项

1.宜迅速降温，急用酒精（或白酒）擦腋下及全身，也可在头部、腋下、腹股沟放冰砖、冰袋或冰糕。

2.平时宜服补气药预防中暑。老年人，夏日服补气药可防中暑，如用生晒参、西洋参、黄芪、党参等泡水当茶饮。也可煎服。

3.宜采用食物疗法预防和治疗中暑。

食疗方：

①绿豆汤，加糖及少量盐，随意饮用。

②绿豆薄荷汤，即绿豆汤煮好后，放入少量薄荷煮沸片刻，即可饮用。

③绿豆、百合、苡仁、红枣共煮汤，放凉后饮用，并吃百合、绿豆、苡仁、红枣。吃时加糖及盐少许。

④西瓜汁，随意饮用。

⑤猕猴桃汁，随意饮用。

⑥蕃茄汁，加糖及盐少许，随意饮用。

⑦鲜藕、韭菜、梨，共榨汁，加糖及盐少许，随意饮用。

⑧菊花晶适量，开水冲泡，加入酸梅粉适量及糖、盐少许，随意饮用。

4.中暑患者切忌继续留在高温环境，忌捂汗，忌不及时补充水份（清凉饮料）。

28. 肩关节周围炎

肩关节周围炎是肩关节软组织的一种慢性退行性病变，多发生于50岁左右的人，所以又叫“五十肩”。

肩关节周围炎的患者一般体质较弱。

本病特征：早期以肩部疼痛为主，晚期以肩关节功能障碍为主。

肩关节周围炎起病缓慢（3个月以上），早期肩关节周围持续酸痛，往往抬举上臂或旋转上臂，即出现一种刺痛样剧痛，局部有广泛压痛，疼痛可向上臂和颈部放散。昼轻夜重，夜间有时可被痛醒，白天肩部稍活动后疼痛可减轻。患者可因肩痛而影响上臂活动，抬举、外旋、后伸受限，穿衣梳头都感困难。

肩关节周围炎是体质和代谢因素引起的，与长期缺乏运动有关，由于缺乏运动，局部血液循环不畅，肩关节的滑囊和周围的肌腱易发生炎症。人到中年，体内新陈代谢减弱，营养失调，全身出现退行性变化等身体衰退现象，肩关节功能活动减退，如果肩部着凉，出汗受风，或肩部软组织过度疲劳，造成劳损，日久失治，就容易使肩关节周围的肌腱挛缩，韧带和关节囊发生粘连，使肩部功能障碍日益加重。

肩关节周围炎，祖国医学称之为“凝结肩”，“冻结肩”、“漏肩风”，认为是由于气血虚弱，受寒或外伤引起，治宜舒筋活络，活血祛瘀。

方一：羌活12克，独活12克，秦艽10克，当归12克，威灵仙10克，桑枝30克，银花藤30克，桂枝10克。水煎服。

方二：络石藤30克，鸡血藤30克，海风藤30克，伸筋草30克，黄芪30克，续断15克，寄生30克。水煎服。

针灸疗法：

取穴：肩髃、肩髃、曲池透少海、外关、合谷。

耳针：肩、肩关节、神门、皮质下。

推拿疗法对肩关节周围炎亦有较好疗效。

加强体育锻炼是预防肩关节周围炎的有效方法，贵在坚持。

治疗肩周炎的验方：

1.天南星20克，生川乌20克，生草乌20克，羌活20克，苍术20克，姜黄20克，生半夏20克，白附子15克，白芷15克，乳香15克，没药15克，红花10克，细辛10克。上药共研细末，加食醋、蜂蜜、白酒、葱白（捣烂）、鲜生姜适量，再加白胡椒30粒（研碎），以上药物炒热后用旧布袋装，热敷患肩30分钟，1日2次，连用5~7日。

2.樟丹250克，乳香15克，没药15克，麻油500克，桑树枝、槐树枝、榆树枝、桃树枝、柳树枝各1段（长30厘米，直径12毫米）。将5种树枝切成3厘米长一段，放入麻油中炸焦捞出（呈黄色），乳香、没药研细加入油中，边加边搅拌（朝一个方向搅拌），均匀后再加入樟丹，搅拌至呈糊状，待温后分摊在25~30张牛皮纸上备用。用时将肩部周围皮肤用温水洗净后，贴上药膏，每5天换一次，同时开始活动肩关节并进行功能锻炼。

29. 关节风湿病

(风湿性关节炎)

风湿病是由溶血性链球菌引起的一种全身性的疾病。感冒、气管炎、鼻炎、中耳炎、扁桃体炎患者，特别是本来就有扁桃体肿大、龋齿等病灶的人，更容易诱发风湿病。

风湿病最先侵犯的是关节。除关节以外，它还可以侵犯其他的器官，其中最主要的是心脏。患风湿病的，以7~20岁的儿童、青少年为最多。成人的风湿病多半是童年及青春时期所患风湿病的继续发展。居室的阴暗、潮湿、肮脏、人口拥挤等不良的生活环境，阴雨绵绵的自然气候，都可以促使风湿病的发生。

风湿病按其侵犯的部位分为三种类型：即心脏风湿病（又称风湿性心脏病）、关节风湿病（又称风湿性关节炎）、神经系统风湿病（又称风湿性脑病、小舞蹈病，《百病良方》第一集已作介绍）。现着重谈谈关节风湿病（风湿性关节炎）的中医治疗。

关节风湿病的主要症状是周身关节特别是膝、肘、腕、肩胛等比较大的关节红肿，疼痛及活动受限，同时伴有发烧。关节的疼痛不是固定的，而是游走性的。关节痛与阴天下雨等气候变化有明显的关系。下肢与膝关节部位的皮肤常可发现红色、坚实、突出表面的圆形结节，触之疼痛，叫做风湿结节，这是关节风湿病的特征。

血常规检查白细胞计数升高、血沉增快、抗“O”增高，都有助于风湿病的诊断。

关节风湿病，属于祖国医学的“痹证”范畴。“痹证”分为“风寒湿痹”和“热痹”两大类型。风寒湿痹又分为“风痹”（行痹）、“寒痹”（痛痹）、“湿痹”（着痹）三种。中医认为痹证的发生，与体质虚弱、生活失常、居处潮湿、气候变化等因素有关。风寒湿痹是由于人体阳气不足，腠理空疏，卫气失调，风寒湿邪乘虚侵入，流注经络，以致气血运行不畅而成。《素问》说：“风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹也”。热痹系由素体阳气偏胜，内有热，感风寒湿邪，内热为外邪所郁，或风寒湿痹经久不愈，邪留经络蕴化为热而成。

中医治疗痹证一般分为以下两大类型：

1. 风寒湿痹 关节或肌肉酸痛，阴雨加重，反复发作，时轻时重，关节疼痛或呈游走性，或痛有定处，或痛处重着不移（以沉、重、麻为主）。治宜祛风散寒除湿，疏通经络。

方一：虎杖30克，威灵仙10克，络石藤30克，鸡血藤30克，海风藤30克，板蓝根30克，桂枝10克，羌活10克。水煎服。

方二：木瓜30克，苡仁30克，牛膝12克，千年健30克，豨筴草30克，桑枝30克，蚕沙10克，独活12克。水煎服。

方三：鹿含草30克，刺五加30克，黄芪30克，续断20克，寄生30克，千年健30克，当归12克，鸡血藤30克，杜仲15克。水煎服。

注：本方适用于老年关节风湿病患者。

2. 热痹 关节局部红肿热痛，触之痛甚，日轻夜重，伴

有发热，口渴，烦躁，舌红，苔黄，脉数。治宜清热祛风化湿。

处方：木防己15克，生地30克，防风10克，羌活10克，银花藤30克，水牛角30克（刮成粉末），蒲公英30克，野菊花20克，丹皮10克，赤芍12克，紫草15克，地龙10克。水煎服。

治疗风湿性关节炎的验方：

①干地黄94克，切片，加水600~800毫升，煮1小时，每日1剂，分2次服，连服3天，间隔3日，再服第二、第三疗程。

②地龙10克，蜣螂虫10克，乳香10克，没药10克，狗骨40克，全蝎6克，川乌6克，麝香0.3克。将地龙微煨，和狗骨先研为细末，再与余药混合，共研极细末，用黑大豆煮汁，制成丸子。服时用黄酒、开水各半送服，成人每次服10克，小儿酌减，每日早晚各服一次。

③红干辣椒20余个，花椒30克。先将花椒加水3000毫升，文火煎半小时后，加入红干辣椒煮软取出，将辣椒皮撕开去籽，贴于患处，共3层，以花椒水热敷加熏蒸1小时左右即可。每晚一次，连治一星期。上汁可连用1周。干椒辣则需每次换用。

④稀签草适量。将稀签草晒干切碎，以白酒拌匀，用文火蒸3小时，取出晒干拌酒再蒸，如此9次，研末，炼蜜为丸，每丸重10克，每次服2丸，早中晚各服1次，米汤送服。

⑤川乌15克，草乌15克，乌梅15克，红花15克，川牛膝15克，银花藤30克，甘草15克，白糖200克，白酒700克。先

将白酒倒入密闭的广口容器内，加白糖搅拌使之溶解后，将上述诸药放入容器内，浸15天过滤备用。每次服10毫升，1日2次。

⑥全蝎10克，乌蛇10克，蜈蚣10克，土元10克，地龙10克。共捣碎，加白酒500克浸泡1周后备用，每次服15~20毫升，早晚各1次。

风湿病的预防：

风湿病一旦发生，常迁延数年，严重的要贻害终生，所以要积极预防。要防寒保暖，避免淋雨受湿，居室要保持清洁卫生和通风。要特别预防感冒。平素有扁桃体肿大、龋齿、副鼻窦炎、鼻粘膜炎症等“隐患”的，要积极治疗，排除隐患。要经常锻炼身体，适当参加体力劳动，增强身体的抵抗力。

风湿性关节炎患者的注意事项

1.宜穿氯纶内衣。氯纶是一种合成纤维，具有较高的电绝缘性，一经摩擦就能产生比其他任何纤维都大得多的电荷。这种电荷逐渐聚积在衣服上，即使空气湿度高达80%，电荷仍不消失。这种电荷有利于风湿性关节炎的治疗。

氯纶的吸湿性低，做成内衣穿，能与皮肤摩擦产生“电疗”的效果。

2.在夏季宜从事游泳锻炼。由于单纯的冷刺激不是造成风湿性关节炎的原因，因此，风湿性关节炎患者在夏季可大胆进行游泳锻炼，以配合治疗。游泳可使每块肌肉得到锻炼，肌肉、筋腱的舒缩可带动骨关节自如活动，动作协调，

节律规整。游泳可加速机体末梢血液循环，促进营养物质代谢，可使病变的细胞恢复正常的活动功能。游泳时自然界的紫外线照射，同样可促进末梢血液的循环，可恢复各关节正常的活动功能。

3.宜控制高脂肪膳食。这是因为，脂肪在体内氧化过程中，能产生一种酮体，过多的酮体，对关节有较强的刺激作用。有人做过实验：让16名关节炎病人，每天吃高脂肪膳食（肥肉、油炸食品等），结果关节炎症状明显加重，有的甚至出现关节肿胀、强直、活动障碍等。当停止吃高脂肪膳食后，症状很快缓解或消失。后来，重复这样的实验，又得出同样的结果。因此，关节炎患者宜控制高脂肪膳食，少吃肥肉和油炸食品等。

4.平时可常吃苡仁、花椒、胡椒粉、生姜等祛风湿食物。附片炖羊肉（或狗肉）也是理想的辅助治疗食品。

5.不宜在饭前服阿斯匹林、去痛片、水杨酸钠等药物，因为可引起胃痛、恶心、呕吐等反应。这些药物如果长期在饭前空腹服用，还会导致胃溃疡或出血。

30. 类风湿性关节炎

类风湿性关节炎，又称萎缩性关节炎，是一种具有关节炎变、慢性全身性疾病。早期有游走性的关节肿痛和运动障碍，晚期则关节僵硬，出现畸形，并有骨和骨骼肌萎缩。

类风湿性关节炎的病因尚未肯定，但寒冷、潮湿等常是重要的诱发因素。

患病以青壮年为多，女性多于男性。这种病起病缓慢，

患者最初起病时只是感到疲倦乏力，低热，手足麻木刺痛，胃纳不佳，体重减轻。继后发生某一关节疼痛、僵硬，当时关节外观并无异常，以后关节逐渐肿大如梭状。关节肿大常从四肢远端的小关节开始，以后再累及其他关节。患病日久，关节附近肌肉的僵硬和萎缩也日益显著，关节周围组织也变得强硬。最后关节变成僵硬和畸形。膝、肘、手指、腕部都固定在屈位，手指常在掌指关节处向外侧成半脱臼，形成特征性的尺侧偏向畸形。此时患者穿衣、吃饭、翻身都需人帮助，非常痛苦。

患者上肢的鹰嘴突、腕部和踝部可出现坚硬如橡皮的皮下小结（直径自数毫米到3~4厘米不等）。

类风湿性关节炎可通过病变关节的X线检查、血液的类风湿因子等检查而确诊。

类风湿性关节炎属于祖国医学的“痹证”范畴，其症状与历节、痛风、骨痹等相似。中医认为其病因由于体虚阳气不足，卫外不固，致风寒湿邪乘虚而入于经络、肌肉、关节，致气血运行不畅，凝滞日久而成痹。

中医治疗类风湿性关节炎一般可分为以下两大类型：

1. 风湿热痹 关节肿大，灼痛胀痛，或局部发红，灼热，舌质较红，苔黄燥，脉细滑数。治宜祛风除湿，清热解毒，佐以益气健脾，活血通络。

处方：黄芪30克，防己12克，土茯苓30克，地骨皮20克，防风12克，白术12克，当归12克，羌活12克，独活12克，桑枝30克，川牛膝10克。水煎服。

加减：风重者加海风藤30克，威灵仙15克，路路通10克，湿重者加苡仁30克，苍术10克；热重者加生石膏30克，地龙

12克。

2. 风寒湿痹 关节肿痛，屈伸不利，畏寒，泄泻，舌淡，苔白，脉弦滑。治宜驱风散寒、除湿通络。

处方：制川乌10克（先熬），制草乌10克（先熬），桂枝20克，羌活30克，独活12克，威灵仙12克，寻骨风30克，乌梢蛇12克，蜈蚣粉0.6克（吞服），牛膝12克。水煎服。

治疗类风湿性关节炎的单方验方：

1. 木瓜、防风、防己、红花各30克，生地、灵仙、当归、土茯苓各60克，泡酒三周后，取滤液。另外用白花蛇一条、蕲蛇30克、乌梢蛇30克，泡酒三周，也取其滤液。两种滤液合并，每次服10~15毫升，每日服三次。高血压及心脏病、肝脏病、肾脏病患者慎用。

2. 桂枝12克，甘草、白芍、知母、白术、麻黄、生姜、防风各10克，附子30克（先熬二小时）。服法：水煎服。每日一剂，30剂为一疗程。症状缓解后，方中加用黄芪30克再服，可巩固疗效。

3. 昆明山海棠片、雷公藤药酒（照说明服用）。

近年来，发现草药雷公藤及其同属植物昆明山海棠对类风湿性关节炎有较好的疗效。湖北省用雷公藤治疗近万例类风湿性关节炎，疗效满意。雷公藤有毒，其药用部分多采用其去二层皮的根部（毒性小，有效成份高）。有的地区已将雷公藤制成糖浆、冲剂、片剂等，用于临床。雷公藤的使用应从小剂量开始，待胃肠道适应后，再加大剂量。

4. 白花蛇150克，地龙150克，地鳖虫30克，蜈蚣30克，僵蚕30克，穿山甲20克。关节剧痛者加全蝎30克，关节变形

重者加虻螂30克。共研细末，分装40包，每日早晚各服1包，服药后疼痛缓解者，可继服2~3料以巩固疗效。

5. 乌鸡（母鸡）1只，麻黄12克，牛蒡子12克。将鸡捏死或吊死，勿见铁器，去毛及内脏，洗净后放入砂锅内，加水，再将麻黄、牛蒡子用纱布包裹，放入锅内共炖煮，不加调味品，可加少量食盐，炖至肉烂为度。去麻黄、牛蒡子，食肉喝汤，早晚各1次。

6. 党参60克，青蒿30克（后下）威灵仙15克，银花藤60克，木瓜30克，白芍60克，丹参30克，川牛膝30克，黄芪60克，当归30克。水煎服，每日一剂。并配合服用成药“昆明山海棠片”（照说明书剂量服用，用量由小到大，与上述汤剂相隔半小时服，每日服3次）。

31. 肢端动脉痉挛病（雷诺氏病）

肢端动脉痉挛病，又称雷诺氏病，是血管神经功能紊乱所引起的肢端小动脉痉挛性疾病。其临床特点是阵发性四肢肢端（主要是手指）对称的间歇发白与紫绀。情绪激动或受寒常可诱发。

这种病比较少见。多发于女性，尤其是神经过敏者。发病年龄多在20~30岁之间。

肢端动脉痉挛病，起病缓慢，冬季多发。发作时手指皮肤颜色先变白，继而紫绀，常在指尖开始，以后波及整个手指，甚至手掌。局部有冷、麻、针刺样疼痛或其他异常感觉。发作数分钟后自行消失，皮肤转为潮红，然后转正常。发病常两手对称。不发病时，除手足有寒冷感外，无其他症状。

病情严重时，持续发作，几乎没有间歇，皮肤萎缩或增厚，指甲畸形，指尖发生溃疡，指甲与甲床分离，疼痛剧烈，还可引起指端坏疽。

肢端动脉痉挛病，属于祖国医学的“寒厥”范畴。《素问·厥论》说：“阳气衰于下，则为寒厥……”，寒厥又可分为内脏虚寒和寒凝血脉两种类型。寒凝血脉，则见四肢厥冷，脉沉细。肢端动脉痉挛病多属寒凝血脉型。治宜温中通阳，散寒通络。

方一：附片30克（先熬二小时），干姜15克，葱白10克。水煎服。

注：本方重用附片，温中散寒力强。实验研究证明，附子煎液能提高大鼠和小鸡在寒冷环境中的抗寒能力，能缓和体温下降，并减低因寒冷所致的死亡率。方中还用了增进血液循环的干姜和散寒通阳的葱白，共奏温中通阳散寒之功，药味虽少，疗效满意。

方二：熟地20克，黄芪30克，丹参30克，麻黄10克，甘草10克，肉桂6克，干姜10克，附片15克（先熬），地龙10克，当归10克。水煎服。

方三：桂枝20克，淮牛膝30克，丹参30克，豨莶草30克，当归12克，红花10克，桃仁12克，木瓜15克，制川乌15克（先熬二小时），制草乌15克（先熬二小时），三七3克，羌活12克。水煎服。

注：本方桂枝、淮牛膝用量虽大，但此二药同用，疗效可明显提高，临床实践中尚未发现有不良的副作用。

32. 慢性肾上腺皮质机能减退症

(阿狄森氏病)

慢性肾上腺皮质机能减退症，又称阿狄森氏病。由于双侧肾上腺皮质结核、萎缩等严重破坏或双侧肾上腺切除而引起。过去认为这种病是罕见的病，近年来因诊断技术提高，故已非罕见。

慢性肾上腺皮质机能减退症的主要症状是：疲乏无力，精神萎靡，食欲减退，体重减轻。这种病的主要特征是色素沉着。如患者有色素沉着，并有结核病史者，即可初步作出诊断。

慢性肾上腺皮质机能减退症除上述主要症状和体征外，病人还可有腰痛、恶心呕吐、腹痛腹泻、头昏失眠、心悸、月经紊乱、性欲减退、毛发脱落、低热盗汗、肝大、低血压等表现（不一定所有症状都具备）。

检查患者的尿，如发现17羟、17酮降低，特别是尿17羟的降低，即可确诊为肾上腺皮质机能减退症。

慢性肾上腺皮质机能减退症，祖国医学称为“黑疸”。其病因病机为肝、脾、肾虚弱，气滞血瘀所致。治宜补虚化瘀。

1. 脾肾阳虚型 口唇、皮肤呈棕褐色，食欲减退，疲乏无力，腰痛，男子阳萎早泄，女子月经不调。舌淡，苔白，脉弱。治宜培补脾肾。

处方：党参60克，黄芪60克，鸡血藤30克，桑寄生30克，菟丝子10克，续断20克，仙灵脾30克，仙茅15克，补骨

脂12克，土鳖虫10克，生蒲黄10克，鸡内金10克，甘草30克。水煎服。

2.肝肾阴虚型 色素沉着，精神萎靡，消瘦，头痛失眠，低热，盗汗，舌红无苔，脉细数。治宜滋补肝肾。

处方：沙参24克，生地24克，枸杞24克，当归15克，白芍24克，女贞子15克，旱莲草15克，琥珀末10克，鸡内金12克，土鳖虫10克，生蒲黄10克，甘草30克。水煎服

3.气滞血瘀型 色素沉着，脸黑如蒙尘，手足心热，口干多梦，腰痛，妇女月经痛，舌质紫暗，脉涩。治宜活血化瘀。

处方：桃仁10克，红花10克，熟地24克，当归12克，赤芍12克，川芎10克，桔梗10克，牛膝12克，柴胡12克，枳壳10克，甘草30克。水煎服。

值得特别提出的是，大剂量甘草（每日用量为15~30克，水煎服，或服甘草浸膏每日15~60毫升，逐日加量，剂量因人而异）治疗肾上腺皮质机能减退症，疗效满意。服后体力进步，食欲增加，血压升高，皮肤色素沉着减退。但有少数病例用大剂量甘草后发生轻度浮肿及血压升高，减量或停药数日后即自行恢复。

实验证明，甘草有类似脱氧皮质酮作用，治疗肾上腺皮质机能减退症疗效确实。助阳补气药也有促进肾上腺皮质功能的作用。临床上治疗肾上腺皮质机能减退症，甘草可以单独用，但最好是在辨证施治的基础上加用大剂量甘草，则疗效更佳。

33. 皮质醇增多症

(柯兴氏综合征)

皮质醇增多症，又称柯兴氏综合征，属于肾上腺皮质机能亢进症的一种。其病因虽未阐明，但目前认为其发病机理是由于肾上腺皮质功能亢进、皮质醇类激素分泌过多所致。

皮质醇增多症多见于女性，男女之比约为1:5左右，病者大多为30~40岁以下的女子。

本病可出现以下三组症候群：

1. 患者呈向心性肥胖，以脸、颈及躯干更为明显，四肢相对瘦小，脸圆如满月，红润多脂，常有粉刺（痤疮），腹大呈球形，上背部多脂肪沉着。皮肤菲薄，呈大理石样花纹，易发生青紫等出血倾向。典例病例下腹部、大腿内外侧、肩、膝等处有粗大紫红色花纹。本病晚期易发生骨质疏松及骨折、背痛、胸痛、佝偻，身长因此减短。严重者可发生精神分裂症。男性多出现阳萎。

2. 患者常有头晕头痛等症状，高血压，心脏肥大，甚至发生心力衰竭，心电图检查提示心肌损害。

3. 女子月经减少，闭经，晚期阴蒂可肥大，不少病例有多毛症，女子更明显，嘴边可长出小胡须，眉毛、头发及阴毛增多，背及前胸亦多毛。早期头发上多油脂，晚期多脱发，有时女性出现男性化。

实验室检查可有嗜酸性粒细胞减少，空腹血糖增高，葡萄糖耐量试验呈糖尿病样曲线，24小时尿17羟、17酮增高。

祖国医学文献虽未见皮质醇增多症的记载，但据八纲辨

证来分析，本病属于里热实证。根据“实则泻之”的治疗原则，治宜清热泻实。

方一：大黄10克，芒硝10克，厚朴10克，枳实10克，生首乌15克，龙胆草15克，黄精15克。

服法：水煎服。每日一剂。每周服5剂，停药2天，连治8周，停药2周为一疗程，一般宜治疗3~6个疗程。

方二：第一阶段：黄精60克，当归15克，水煎服，连服60天。第二阶段：生首乌15克，玉竹15克，龙胆草10克，大黄6克，芒硝6克，枳实10克，厚朴10克，水煎服，连服60天。

注：上述两个处方均为大承气汤加味，治疗皮质醇增多症，疗效较显著，可能对肾上腺皮质代谢有调节作用。

这两个处方服后均有泻下作用，这是治疗的需要，应坚持服药。

34. 癔 症

癔症，又名歇斯底里，是一种常见病，好发于青年女性，是由于精神刺激引起的大脑皮质暂时性功能失调的一种病。惊吓、恐惧、失望、忧虑及思想矛盾等因素是疾病发生的外因，而病人思维上的一些弱点是癔症发生的内在基础。如胸襟狭窄、性格脆弱、依赖、重情感（感情用事）、易受暗示、富于幻想、好表现自己的人，癔症反复发作的倾向较大。

癔症的临床症状复杂而多变，可分为精神障碍和躯体机能障碍两大类。

一、精神障碍

病人大哭大笑，大喊大叫，乱说乱唱，手舞足蹈，常有装模作样的表现。病人可通过夸张的动作和生动的表情，把心中不愉快的事情说唱出来，在人多的场合下往往发作更突出。迷信思想影响较深的人，发病时往往有所谓死去的人附体说话的做作。有的在情感激动时突然倒地呼唤不应，全身僵直，四肢抖动，屏气或作过度喘气。这类瘧症发作通常持续几十分钟或几小时。

有些病人发病时好象变得什么都不懂。称自己年方三岁， $2+2=5$ 等等，看去痴呆很严重，但从其片断的正常活动中，却反映出并非真正缺乏智能。这称为“假性痴呆”。

二、躯体机能障碍

（一）运动障碍

瘧症性瘫痪（单瘫、截瘫）常突然发生，如治疗或暗示不当，症状可固定下来。有的病人有类似癫痫样抽搐、震颤、奇特步态（剪刀状步态）等。详细作体格检查，发现不了有什么病变。

（二）感觉障碍

病人自己说突然失明，但瞳孔反射、眼球活动都是良好的，眼底检查也没有什么病变。病人虽说自己失明，可是在单独行走时却能避开障碍。病人还可出现耳聋、失音等症状，但这种耳聋病人能在睡眠中被叫醒，失音病人能咳出声音。病人还自己觉得下腹部一个气球状物，逐渐上冲，阻塞咽喉，发生呃逆、窒息感（此即“瘧症球”，中医称之为“梅核

气”)

(三) 内脏和植物神经系统机能障碍

常见的有神经性呕吐、神经性厌食、神经性尿频以及假孕等症状。

瘵症属于祖国医学的“脏躁”、“郁冒”、“梅核气”等范畴。中医认为大多由精神过度紧张，意外刺激，或因大病久病之后，体质虚弱，营血暗耗，痰气郁结，以致脏腑阴阳气血功能失调所致。其治疗，宜补气养血，润燥缓急，解郁化痰，顺气降逆。

辨证施治：

1. 心脾受损，阴液不足（脏躁）

悲伤欲哭，频作呵欠，心中烦乱，睡眠不安，饮食无味，舌质淡红，脉细弱。治宜润燥缓急。

处方：浮小麦60克，大枣60克，甘草18克，柏子仁12克，阿胶10克，夜交藤30克，白芍15克，枸杞15克，沙参30克。水煎服。服时加蜂蜜适量。

2. 肝气抑郁，痰气交阻（梅核气）

精神抑郁，胸闷太息，常觉咽中如有物阻塞，吞之不下，吐之不出，舌质淡红，苔薄，脉弦滑。治宜顺气降逆。

方一：法半夏10克，厚朴10克，茯苓15克，生姜10克，紫苏10克，香附10克，代赭石30克。水煎服。

方二：马兜铃12克，水煎，稍凉后慢慢服下，以免引起呕吐。

方三：桃仁10克，红花10克，桔梗10克，牛膝10克，当归10克，川芎10克，熟地12克，赤芍10克，柴胡12克，枳壳10克，甘草6克。水煎服。

治疗癔症的单方验方：

1.生赭石50克，法半夏15克，黄连10克，竹茹10克，枳实10克，干姜6克。

服法：水煎服。（本方适用于癔症患者之神经性呕吐）。

2.针刺内关。饭后即针刺，令患者配合作深呼吸。这个方法治疗癔症患者之神经性呕吐，效果很好，关键是要抓住治疗时机，即饭后作针刺。

3.生龙骨30克，生牡蛎30克，浮小麦30克，大枣30克，甘草10克，葛根15克，党参30克，桂枝10克，首乌60克。

服法：水煎服。（本方适用于治疗癔症患者之精神障碍症状及运动障碍症状）。

4.甘松30克，陈皮30克，水煎服。

注：甘松理气开郁，散寒健胃，有解痉镇静作用，陈皮理气燥湿，健脾化痰，为气分要药。二药合用，治疗癔症患者之精神障碍症状及运动障碍症状，有较好疗效。

35.小脑共济失调症

小脑共济失调症是遗传性共济失调症当中的一种，是中枢神经系统的慢性变性疾病。

人体任何一个简单的运动，必须有主动肌、对抗肌、协同肌及固定肌等四组肌肉共同协调才能完成。这四组肌肉之作用所以能够协调一致，乃由于通过小脑等的参与，以调节运动的协调和平衡，如果小脑等结构有了病变，而使运动缺

乏正确性，就叫做共济失调。

小脑共济失调症通常在30岁左右起病，病程进展缓慢，主要表现为步态不稳（步行摇摆，重心不稳），肢体动作失调，不能作快速交替动作，手中所拿的笔或筷可不自主地落掉。眼球震颤，发音不清，记忆力减退等。

根据小脑共济失调症的表现，属于中医“肾精不足”的范畴。中医认为肾主骨、生髓、通于脑。肾精不足或惊恐伤肾，则眩晕，行走不稳。患者多有肾阴虚或肾阴阳俱虚的见证，如耳鸣，手足麻冷，畏寒，健忘等。治宜补肾益精。

方一：熟地30克，山萸12克，山药30克，淮牛膝15克，巴戟12克，五味子15克，远志10克，菖蒲10克，肉桂6克，附片20克（先熬），党参30克，石斛15克。水煎服。

方二：枸杞30克，五味子30克，复盆子10克，菟丝子10克，巴戟10克，远志10克，酸枣仁15克，沙苑蒺藜12克，生龙骨30克，生牡蛎30克。水煎服。

36. 脑 溢 血

脑血管意外包括脑出血、蛛网膜下腔出血、脑血栓形成、脑栓塞等。

脑溢血又称脑出血，是高血压病病人中常见的严重合并症，也是老年人死亡的主要原因之一。

脑溢血多见于50岁以上的高血压患者，由于动脉变性或破裂，大量血液渗入脑实质内，引起昏迷和瘫痪。

脑溢血最主要的原因因为高血压和动脉硬化，其他如肿瘤、各种血液病和有出血倾向的情况，也可导致脑出血。

脑溢血的发生有时可无明显的诱因。常见的外部诱因主要有情绪波动、大便干燥和过重的体力活动等。

临床表现:

突然发生剧烈头痛、眩晕、呕吐或偏瘫，短时间内意识模糊而进入昏迷状态，病人面色潮红，呼吸深重而带鼾音，颞动脉搏动强烈，周身皮肤湿润，瞳孔不对称（病侧较大）或缩小，口角歪斜，有时头、眼转向一侧。检查时常发现脉搏缓慢有力，血压增高，瘫痪的一侧肌张力减退，对痛觉刺激无反应。病情严重者呈深度昏迷，呼吸不规则，脉搏增快，四肢运动完全丧失，各种反射均不能引出，并可发生消化道出血而呕出咖啡色胃内容物，体温急剧升高。部分病人还有心律紊乱等表现。

脑溢血不严重的病人，昏迷数日至数周后，意识状态逐渐好转，病情稳定而趋向进步，呼吸平稳，能吞咽饮食，偏瘫肢体的运动功能可逐渐恢复。但多数病人可遗留程度不等的肢体瘫痪（并伴有肢体挛缩、疼痛等）和语言障碍、智力减退。

病人的年龄在中年以上，有高血压、动脉硬化史，起病急骤，突然昏迷瘫痪（一侧偏瘫），呼吸有鼾声，瞳孔不对称或缩小，根据以上这些特点，并通过脑脊液检查，可确诊为脑出血。

脑溢血属于祖国医学的“中风”、“中脏证”、“中腑证”等范畴。中医认为脑出血多由心、肝、肾三脏阴阳平衡失调，逼动气血上冲脑部（气血突然上厥）。《素问》说：

“血之与气，并走于上，则为大厥；厥则暴死，气反则生，

脑溢血、蛛网膜下腔出血、脑血栓形成、脑栓塞的鉴别

	脑 溢 血	蛛网膜下腔出血	脑血栓形成	脑 栓 塞
有关病史	高 血 压	无特殊病史	动脉硬化	心脏病
好发年龄	50 岁 以 后	40岁以后	50岁以后	20~40多岁
诱发因素	用力或情绪激动	用力或情绪激动	安静休息时	心房颤动 心力衰竭
起病形式	较急	较急	较慢	急骤
头 痛	常见	剧烈	少见而轻	少见而轻
呕 吐	常见	常见	少见	少见
昏 迷	深而持久	见于严重者	少见	少见
血 压	甚高	一般正常	有的较高	正常
偏 瘫	有	少见	有	有
脑膜刺激征	少见	明显	无	无
脑脊液压力	增高	增高	正常	正常
脑脊液检查	血性	血性	正常	正常

不反则死”。

中医对脑出血的治疗，分为“闭证”和“脱证”两种类型：

一、闭证

突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，两手握固。闭证又分为“阳闭”（热闭）和“阴闭”（寒闭）。

阳闭（热闭）：面赤气粗，二便闭阻，痰声如锯，舌苔黄腻，脉弦滑而数。

阴闭（寒闭）：面白唇紫，痰声壅盛，四肢不温，苔白滑腻，脉沉滑。

治疗闭证宜先开窍，先刺人中、十宣，牙关紧闭不开，可用开关散（成药）以开其紧闭。

阳闭用至宝丹一粒研末，兑生姜汁（或竹沥）灌服。

阴闭用苏合香丸一粒，研末，用温开水兑生姜汁，频频灌服（如不能灌入，可用鼻饲）。

阳闭开后，可用下列处方治之：

淮牛膝15克，生龙骨30克，生牡蛎30克，白芍15克，珍珠母30克，生地15克，生石决明30克，三七6克，菊花15克，夏枯草30克，水煎服。

阴闭开后，可用下列处方治之：

天麻10克，胆南星10克，法半夏10克，钩藤15克（后下），郁金10克，菖蒲10克，川贝10克，三七6克。

二、脱证

两手撒开，张口不闭，两眼紧闭，鼻起鼾声，小便失禁，舌痿，脉细弱。或四肢逆冷，汗出痰壅，面色如妆，脉浮大无根，或沉细欲绝。治宜益气固脱，回阳急救。

方一：红参15克，附片15克（先熬），水煎，鼻饲进药。

方二：熟地30克，麦冬30克，五味子20克，制附片（先熬）15克，巴戟10克，肉苁蓉15克，菖蒲10克，远志10克，山萸12克，肉桂3克，石斛12克，三七6克。

三、后遗症

脑出血的后遗症，多为半身不遂，多由气血两亏，瘀血阻络所致。治宜益气养血，祛瘀通络。

处方：黄芪60克，当归10克，川芎10克，桃仁10克，赤芍10克，红花10克，地龙10克。水煎服。

加減。

口眼歪斜者加全蝎、蝉衣、僵蚕。

言語不利者加生蒲黃、菖蒲、遠志（也可改用治脫証的處方二治療）。

肢體麻木加姜黃、桑枝、雞血藤。

偏頭痛加蔓荊子、鉤藤。

血壓偏高加川牛膝、珍珠母。

失眠加女貞子、旱蓮草、夜交藤。

腰腿無力加千年健、寄生、狗脊。

神志不清加菖蒲、遠志。

腦溢血多見於高血壓病人，因此，積極治療高血壓病，對減少腦溢血的發生具有重要意義。

腦溢血一旦發生，應尽量少搬動，就地作中西醫結合搶救治療，如改善腦缺氧（氧氣吸入），降低顱內壓，保護腦細胞（頭部放冰袋），適當控制血壓（血壓降得太快會導致腦缺氧），使用止血藥可用祛瘀止血的三七粉。

37. 蛛網膜下腔出血

蛛網膜下腔出血是腦血管意外的一種，系因腦部淺表部血管非外傷性破裂，血液流入蛛網膜下腔而引起。常見的原因因為血管畸形、先天性動脈瘤破裂以及高血壓、動脈硬化、血液病等。

40歲以後首次發生蛛網膜下腔出血者，其原因多數為動脈瘤破裂，在破裂前常無任何症狀，一部分病人常有單側頭痛或癲癇樣發作。30歲以前首次發生蛛網膜下腔出血者，其

原因多数为血管畸形，破裂前患者常有癫痫发作的病史。

蛛网膜下腔出血的突出症状是暴发性剧烈头痛和颈部强直，几乎所有的病人都有头痛症状。头痛的程度与发病的速度以及出血量的多少有关。当低头或转颈时头痛加重，头痛严重时往往伴有呕吐。由于血液直接刺激脑膜，后颈部肌肉产生挛缩，致使颈部强直，活动受限。腰椎穿刺脑脊液呈血性，就可以确定诊断。

出血严重者有血压升高，脉搏缓慢，颅内压增高等表现，两周内病死率最高。出血轻者，发病后数日病情即见稳定，症状逐渐减轻，部分病人隔一定时间后可再次出血。有高血压和动脉硬化的人，再次出血的可能性较大。

蛛网膜下腔出血，属于祖国医学的“中风”、“风痰上扰”等范畴。中医认为系阴虚血热，痰热内蕴，风阳内动，上扰清空，风阳挟痰，走窜经络所致。治宜滋阴凉血，潜阳熄风。

处方：羚羊角1.5克，钩藤20克（后下），菊花20克，地龙15克，生地30克，白芍15克，寄生30克，丹皮10克，草决明30克，元参20克，三七6克。水煎服。

昏迷、颈部强直者，急用至宝丹一粒，或紫雪丹1.5克，温开水化服或鼻饲。

蛛网膜下腔出血，发病急骤，同脑出血一样，应就地作中西医结合抢救，病人应绝对卧床休息，保持安静。其注意事项及其后遗症的治疗，与脑出血基本相同（请参阅本书脑溢血一文）。

38. 脑血栓形成

脑血栓形成是在脑动脉粥样硬化、血管内膜有病变的基础上产生的。脑血栓形成后，又可刺激血管壁的感受器使血管痉挛，这样就更促进了血管腔狭窄和闭塞，常导致脑梗塞而出现偏瘫等神经症状。

患者多是50岁以上的患高血压病和动脉粥样硬化的老年人。平时这些病人的脑血管虽因有了病变而管腔狭窄，但由于受机体代偿功能的调节，如侧枝循环的开放和建立，远端血管扩张使血流阻力减小等，足以维持正常或接近于正常的血液供应，可无明显的临床症状。但当机体情况不好时，如血压降低、血液浓缩、血凝加速等（常见于心力衰竭，心律失常、心肌梗塞、休克、脱水、大出血等，或者有脑部感染、脉管炎、头部外伤等），则易诱使脑血栓形成。

脑血栓形成最多见的部位是大脑中动脉、颈内动脉及椎-基底动脉等。遇有发病比较缓慢，在1~2天内逐渐出现偏瘫而又无意识障碍的病人时，就应考虑脑血栓形成的可能（脑脊液检查正常）。

脑血栓形成起病缓慢，男性较多，常于休息静止或睡眠时发生症状（逐渐偏瘫，半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩），通常不出现意识障碍，面色稍苍白，脉搏较快。严重的病人也可以发生昏迷（昏迷较少见）。

脑血栓形成属于祖国医学的“中风”、“在经在络”等范畴，中医认为多由正气不足，气血虚弱，气滞血瘀，痰湿阻滞，内风妄动，挟痰挟瘀上冲，脉络痹阻，脑络失养，清

窍空虚而发病。其治疗，宜平肝熄风，活血通络。

方一：当归12克，川牛膝24克，络石藤30克，桑枝60克，豨筴草30克，地龙15克，红花10克，全蝎6克，僵蚕10克。水煎服。

方二：秦艽15克，当归15克，丹参30克，赤芍12克，川芎15克，地龙15克，生地12克，木瓜15克，白蒺藜12克，白附子10克，茯苓10克，桂枝10克。水煎服。

方三：鸡血藤30克，络石藤30克，红藤30克，海风藤30克，伸筋草15克，桃仁10克，当归15克。水煎服。

方四：黄芪60克，地龙10克，僵蚕10克，川芎10克，赤芍10克，当归10克，桃仁10克，红花10克。水煎服。

方五：毛冬青片（成药，照说明的剂量加大服），或毛冬青根90~120克。水煎服。

附注：

同为脑血管意外（“中风”），脑出血（“中脏中腑”）和蛛网膜下腔出血是属于出血性的急性脑血管疾病，中药治疗应加用止血之品，如三七等。而脑血栓形成（“在经在络”）和脑栓塞（“在经在络”）是缺血性的急性脑血管疾病，中药治疗除平肝、息风、祛痰外，更主要的是用活血逐瘀药（不能用单纯止血药物）。初学者宜注意。

39. 脑栓塞

脑栓塞是由于进入血液循环的栓子将脑动脉堵塞，发生非常突然的偏瘫和意识障碍。

循环着的血液中出现某些异物，顺血流带到各处，这种异物就叫栓子。栓子运行至不能通过处所造成血管阻塞，叫栓塞。

栓子的种类很多，如血栓栓子、空气栓子、脂滴、肿瘤细胞、羊水、细菌和寄生虫栓子。脑栓塞多见于原有心脏病的中年人。脑栓塞发病急骤，常突然发生偏瘫和意识障碍。

栓子的来源是多种多样的。风湿性心脏病人的心内膜发生病变，附壁血栓脱落后即成栓子；细菌性心内膜炎病人的心脏瓣膜，尤其是二尖瓣，常可形成含有大量细菌的赘生物，松脆而易脱落，形成栓子；又如心肌栓塞时，心室肌变性坏死灶（梗死区）的心内膜常产生附壁血栓，也可脱落而成栓子。少见的情况是长骨（股骨、胫骨、肱骨等）骨折时，以及脂肪组织遭受损伤时，脂肪组织进入血液中，形成脂肪栓子。各种栓子运行至脑，都可造成脑栓塞。有时癌细胞性栓子以及寄生虫卵性栓子，也可引起脑栓塞。空气栓子造成的脑栓塞常见于严重创伤、胸部手术、气胸或气腹疗法时。各种原因所致的脑动脉栓塞，使所供应的脑组织血流减少，甚至完全中断，因而产生不同程度、不同范围的变性和坏死。小范围的梗死可以吸收或机化，大范围的则形成液化坏死性囊腔，预后不良。

脑栓塞起病急骤，突然发生偏瘫和意识障碍。多数脑栓塞可引起癫痫持续状态。脂肪栓塞通常先出现胸痛、咳嗽、血色痰、呼吸困难和体温升高，尿中常有脂肪颗粒。空气栓塞常表现为突然的头痛、恶心、呕吐、视力障碍，甚至昏迷、惊厥。细菌性栓子引起脑栓塞时，白细胞可能增多。

患者有心脏病、肺部感染、骨折等病史，如果突然发生

偏瘫和意识障碍，即应考虑有脑栓塞的可能，如果患者身体其他部位有动脉栓塞的表现，而脑脊液检查正常，即可确诊为脑栓塞。

脑栓塞属于祖国医学的“中风”、“在经在络”等范畴。中医的病机、治则、处方用药，均与“脑血栓形成”的治疗完全相同。

脑栓塞是多种疾病的严重并发症，因此，预防脑栓塞的最有效的措施是积极治疗原发疾病。

40. 脑外伤后综合征

脑外伤患者急性期过去以后，可以遗留各种各样的症状，一般统称之为脑外伤后综合征。其中包括各种程度的脑组织损伤和遗留的痴呆、瘫痪、失语、失眠以及癫痫等症状。部分病人在脑外伤后三个月内，即使完全没有神经系统器质性损伤的体征，也常有不少头晕目眩、头痛头沉等症状。如果这种症状持续三个月以上，又无明显器质性病变的体征，即可诊断为脑外伤后综合征。

脑外伤后综合征的临床表现多样复杂，一般说来以植物神经功能失调和癫痫样症状为主。

植物神经功能失调的症状有：头晕目眩，耳鸣心烦，多痰便秘，浮肿便溏，心悸多汗，阳痿尿闭，失眠多梦，怔忡不安等。

癫痫样症状有：痉挛性发作，失音，耳聋，瘫痪等。

此外，患者常有注意力涣散，情绪不稳定，记忆力减退，易激动，易疲倦等症状。

脑外伤后综合征属于中医的“头风”等范畴。本病因脑受外力作用而致损伤。颅脑损伤后因脑窍脉络瘀阻，不通则痛，可出现脉络瘀阻证型。病程延长，损伤气血，亦可出现气血双亏证型。因气血亏损，不养心脾，脾虚不运水谷，肾精不得后天水谷精微充养而告乏，亦可出现肾精亏损证型。又因脾虚不运水湿，也可出现痰湿内阻证型。也有因脑外伤时突然受惊吓，惊则气乱，导致气血逆乱，血不能正常归于肝，肝失所涵，也可出现肝阳上亢，肝风内动的证型。

中医治疗脑外伤后综合症一般可分以下五种类型：

1. 脉络瘀阻型 脑外伤后头痛如刺，痛有定处，眩晕加剧，心烦欲呕，常昏倒跌扑，舌边瘀紫，脉弦涩。治宜活血化瘀。

处方：土鳖虫6克，水蛭3克，丹参30克，生蒲黄10克，五灵脂10克，红花10克，川芎10克，血竭6克，三七3克，菖蒲10克，牛膝10克。水煎服。

2. 气血双亏型 脑外伤后，头昏头痛，面色苍白，气短神疲，嗜睡，心悸易惊，舌质淡，苔白，脉弱。治宜补气益血。

处方：党参30克，黄芪30克，当归12克，白芍15克，熟地12克，阿胶12克（烔化冲服），首乌15克，郁金10克，三七3克，菖蒲10克。水煎服。

3. 肾精亏损型 脑外伤后，头晕头痛，记忆力衰退，耳鸣，失眠，心悸，舌红，无苔，脉细数。治宜补肾填髓。

处方：枸杞30克，熟地15克，首乌15克，胡桃仁30克，菟丝子10克，潼蒺藜15克，淮牛膝15克，补骨脂10克，三七3克，菖蒲10克。水煎服。

4.痰湿内阻型 脑外伤后，头痛，头重如裹，身倦肢重，胸脘满闷，纳少，恶心。舌淡，苔白厚，脉滑。治宜祛除痰湿。

处方：茯苓30克，法半夏12克，陈皮10克，甘草10克，白术15克，苡仁30克，菖蒲10克，天麻10克，全蝎3克，生姜10克。水煎服。

5.肝阳上亢，肝风内动型 脑外伤后，头痛剧烈，眩晕，眼睑及口角振颤不已，恶心，呕吐，健忘，抽搐，谵妄，口眼歪斜等。舌红绛，脉弦。治宜平肝息风。

处方：全蝎6克，僵蚕10克，钩藤15克（后下），羚羊角0.5克，生龙骨30克，生牡蛎30克，石决明30克，珍珠母30克，牛膝12克，寄生30克，菖蒲10克。服法：水煎服。

治疗脑外伤后综合征的单方验方：

1.鸽子炖汤，喝汤吃鸽肉，配合中药内服，能提高疗效。据报道，鸽脑组织中含极丰富的脑磷脂、卵磷脂、谷氨酸等物质，能使人脑受损的脑细胞得到营养和修复。

2.胎盘粉10克，开水送服。

3.胡桃仁30~60克，嚼服（此为一日量）。

4.女贞子30克，枸杞子30克，桑椹30克，菟丝子30克，党参30克，酸枣仁15克，黄芪30克，当归15克，沙苑蒺藜15克，川芎10克，远志10克，牡蛎30克，甘草10克。水煎服，每日一剂。

41. 脑 积 水

脑积水是由先天性原因或多种疾患引起的颅腔内脑积液

量的异常增多。

正常情况下，脑脊液的产生、循行和回流是处于平衡状态之中的，当脑脊液产生过多，或由于其他疾患引起脑脊液循环障碍（循行途径阻塞）或回收过少时，使颅内脑脊液滞留，发生病变。表现为剧烈头痛，恶心，呕吐，视力减退或失明，可伴发癫痫。发于婴儿则头颅迅速增大，颅缝裂开，囟门不闭，患儿额部向前突出，面部呈倒立的三角形，眼睑上缩，眼球下推，而上部眼白外露，头皮静脉怒张，头颅叩诊呈破罐声。甚则四肢活动不灵，肢体瘫痪，智力不足，斜视，最后威胁生命。

脑积水属于祖国医学的“解颅”范畴，病因病机为脾肾不足，脾虚湿困，肾亏于下，肝亢于上。其治疗，宜滋补肾阴，平肝息风，泻水通利。

方一：蒲公英30克，漏芦10克，银花30克，菖蒲10克，路路通10克，丹皮10克，黄芩10克，木通10克，茅根30克。水煎服。

注：本方适用于由耳部感染引起的脑积水。

方二：龙胆草10克，木通10克，滑石30克，花蕊石30克，王不留行10克，草决明30克，土鳖10克。水煎服。

注：本方适用于脑外伤引起的脑积水。

方三：茯苓皮6克，路路通6克，山甲6克，土鳖虫3克，冬瓜皮6克，郁金3克，菖蒲3克，草决明3克，木瓜3克，防己3克，麝香0.1克（冲服），黄芪6克。水煎服（症状好转后，去麝香、土鳖虫、山甲、防己，加当归、仙灵脾）。

注：此方适用于婴幼儿的先天性脑积水。

方四：济生肾气丸（成药），照说明的剂量酌减。

注：此方适用于婴幼儿的先天性脑积水。

治疗脑积水的验方：

①熟地10克，山药10克，鹿角胶10克，淮牛膝10克，茯苓10克，黄精10克，茺蔚子10克，猪苓10克，丹皮10克，车前草10克，肉苁蓉10克，当归12克。共研细末，炼蜜为丸，每丸重1.5克，早晚各服一次，3个月以内每次服1丸，3个月以上每次服2丸。

②山萸肉3克，川断3克，桑寄生3克，首乌3克，泽泻6克，白术3克，黄芪10克，桂枝3克，川牛膝3克。水煎服，每日1剂。

③外洗方：茅根30克，赤茯苓30克，川牛膝15克，苍术10克，独活10克，荆芥10克，防风10克，木通10克，苍耳草10克。水煎，用两条毛巾浸药液，轮流热敷头部，每日2~3次，每次1小时左右，连用10日为1疗程。

42. 脊髓空洞症

脊髓空洞症是一种慢性进行性疾病，由于脊髓中心有空洞形成而引起分离性感觉障碍、肢体瘫痪和营养障碍等症状，多数学者认为与脊髓中央管先天发育异常有关。

脊髓空洞症起病缓慢，多数在30岁以前起病。最早的症状是两侧上肢对称性的节段性痛觉消失（不知疼痛），温觉也消失（手不知烫），而触觉保存（称为分离性感觉障碍），有的患者从胸到脐无痛觉（针刺也不知痛），但触觉存在。病情继续发展，则出现上肢无力，肌肉萎缩，时而颤动（颤

动)，关节屈伸不利，手指伸不开。有的患者还有手部出汗异常、紫绀、水肿、指甲角化过度等症状，严重者指尖可自动脱落。个别患者可出现同侧眼球凹陷，瞳孔缩小，睑裂变小，面部不出汗等症状。有的患者下肢瘫痪，步履艰难，有的患者面部感觉障碍，眼球震颤，舌肌萎缩，言语不清，发音嘶哑，同时还有周身无力，腰酸腿软，手足不温，面色不华等。

脊髓空洞症，作脑脊液检查及X光摄片检查后，可以明确诊断。

脊髓空洞症属于祖国医学的“风痺”范畴。中医认为是由肝、脾、肾三脏损害所致。脾主肌肉，主四肢，脾气虚弱，失于健运则四肢无力、肌肉萎缩。肝主血、主筋，肾主骨、主精，肝肾气血亏损，筋骨失去濡养，便使运动受到影响。《千金方》说“风痺者，身无痛，四肢不收”、“手足不遂而僵直”（“痺”即“废”的意思，指肢体麻木，四肢不利，步履艰难）。刘完素说“风痺，……地黄饮子主之”。

根据脊髓空洞症的临床表现，属于肝肾亏损，气血虚弱。治宜肝肾气血同补。

处方：黄芪30克，党参30克，鸡血藤30克，茯苓15克，肉桂6克，附片15克（先熬），远志10克，菖蒲10克，五味子24克，女贞子30克，枸杞24克，巴戟10克。水煎服。

注：脊髓空洞症疗程较长，患者应长期坚持服药，才能使感觉功能得到不同程度的恢复。

43. 多发性神经炎

多发性神经炎又名周围神经炎，是一种具有对称性的四肢远端感觉障碍，伴弛缓性瘫痪及营养机能障碍等症状的疾病。感染、损伤、中毒、营养不良和代谢障碍等均可引起多发性神经炎。但以感染、中毒（例如铅中毒、砷中毒、二硫化碳中毒及其他有机化合物中毒、药物中毒等）对神经的侵害较为常见。

多发性神经炎开始时手足发胀发麻、疼痛或有蚁行感，随后，这种异常感渐渐向躯干发展。四肢远端的感觉减退甚至消失（四肢远端呈手套型、袜子型感觉障碍），运动无力，肌肉萎缩，出现腕下垂或足下垂，皮肤有冷感，多汗或无汗。这种病的特点是发病两侧对称，肢体远端的症状比近端的症状明显。

多发性神经炎属于祖国医学的“着痹”、“痿证”范畴。中医认为系湿流四肢、经络阻滞，气滞血瘀所致，而且与“脾”有一定关系。脾主四肢，脾失运化则湿浊流入肢体，而使气血运行功能失常而发生本病。

1. 血虚风痹型 手足麻痛，手不能握物，手接触物件即麻木剧痛。足跟着地则痛不可忍。手足运动无力，手大小鱼际肌萎缩，脚趾肿胀苍白，足底肌肉萎缩。此乃血虚不荣四末。治宜养血活血，通络祛风。

方一：桂枝10克，白芍15克，赤芍12克，当归15克，熟地15克，川芎12克，乳香10克，没药10克，川牛膝12克，鸡血藤30克，银花藤30克，木瓜15克，伸筋草30克。水煎服。

方二：黄芪60克，当归10克，川芎10克，桃仁10克，红花10克，川牛膝12克，苡仁30克，苍术12克，黄柏12克。水煎服。

2.脾肾阳虚型 手足麻木，感觉丧失，用热水洗脚不知热，两脚麻木逐渐向上扩展，站立不稳，两脚似捆，听力减退，尿频数，便溏，食少，消瘦。治宜补肾健脾利湿。

处方：熟地15克，山萸12克，茯苓30克，麦冬15克，五味子15克，仙灵脾30克，巴戟12克，山药30克，杜仲15克，白术30克，桂枝10克。水煎服。

针灸治疗多发性神经炎有一定疗效。取穴：肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、阳陵泉、悬钟、三阴交。如能配合理疗及体育疗法，可提高疗效。

多发性神经炎应注意病因治疗，如因感染引起的则应配合应用消炎药物；如系长期接触铅、砷等毒物引起的，应采取职业性预防措施；如因营养不良（如维生素B₁缺乏而致脚气病）引起的神经炎，还必须注意增加营养。这种病疗程较长，病员应坚持服药。

急性感染性多发性神经炎病情变化快，应在严密观察的情况下辨证用药。病情进展迅速者应作中西医结合抢救治疗。抢救治疗时可随证应用芍药甘草附子汤，这个方剂似有阻止呼吸肌麻痹进展的效果和改善心衰的效果。

治疗多发性神经炎的验方：

黄豆1500克，米糠1500克。将黄豆炒焦，磨成细粉，与米糠拌匀，备用。每餐取100克，水调作饼，加食油适量，置于待蒸的饭面上，随饭蒸熟，餐前食服，每日3次，10天

为1疗程。

44. 流行性乙型脑炎

流行性乙型脑炎，简称“乙脑”，是乙型脑炎病毒经蚊子传播而引起的中枢神经系统急性传染病。小儿发病率远较成人为高。这种病起病急，病情重，死亡率高。有的能产生失语、瘫痪等后遗症。

乙脑的主要症状有高烧、头痛、昏迷、抽搐等。乙脑的流行有明显的季节性，大多数病例都在7、8、9这三个月发病。

临床表现：

1. 初热期（发病开始的三天左右） 体温很快升到38~39°C，并有头痛、疲倦，有的有轻度嗜睡、恶心、呕吐及颈部轻度强直。

2. 极期（发病第4~10天） 体温越来越高，可达40°C以上，头痛，疲倦，恶心，呕吐，颈部强直等症状也逐渐加重，有的病人可出现昏迷、全身抽风、强直性抽风或强直性瘫痪，甚至呼吸衰竭（呼吸衰竭表现为呼吸节律不规则，双吸气，叹息样呼吸，呼吸暂停，潮式呼吸，抽泣样呼吸及下颌呼吸等，最后呼吸停止）。体格检查可发现脑膜刺激征，瞳孔对光反应迟钝或消失，瞳孔扩大，腹壁及提睾反射消失等。

3. 恢复期 经过极期后，体温逐渐下降，各种精神神经症状不再加重或逐日趋向好转。严重病人可留有神志迟钝、痴呆、失语、吞咽困难、颜面瘫痪、四肢强直性瘫痪等。这

些症状经积极治疗多数能在半年内恢复。但有的病人失语、瘫痪等症状虽经治疗仍不恢复，则称为后遗症。

乙脑主要依靠流行季节、临床症状和体征以及实验室检查的综合分析而确诊。

乙脑，属于祖国医学的“暑温”、“暑风”、“暑痉”等范畴。中医认为暑邪是乙脑的主要病因。暑邪有以下特点：①其性猛烈，且易伤气，传变迅速，一开始就有明显的里证，表现为卫气同病，有的很快发展为营血证。②暑必挟湿。③暑温为热病，也易伤阴。

其治疗，宜清热解毒，佐以利水消肿，活血化瘀，平肝息风。

方一：大青叶30克，板蓝根30克，鬼针草30克，益母草30克，蚤休15克，猪苓15克。水煎服。

加减：表热者加葛根、柴胡。湿重者加藿香、香薷、佩兰。里热重加生石膏60克（先熬）。抽风加钩藤、地龙、生牡蛎。昏迷者加菖蒲、胆南星。痰多者加三蛇胆陈皮末。

注：本方重用活血化瘀、利水消肿药物，有消除脑水肿作用，疗效较好。

方二：银花60克，连翘30克，生石膏120克，寒水石60克，知母15克，白芍20克，生地30克，芦根30克，桔梗15克，藿香12克，菖蒲10克，苍术12克。水煎服。

加减：一旦有痰，即加用大剂量祛痰药如竹沥、天竺黄等。

注：本方重用清热解毒之品，乙脑患者体温在 39°C 以上，即应投以本方，只要热退得较快，预后即好。方中用生地、白芍、当归是为了预防热极生风（抽风）。

方三：水牛角粉30克，菖蒲10克，郁金12克，蜈蚣2条，僵蚕10克，蝉衣10克，钩藤30克，地龙汁30毫升（兑服，不煎），大青叶60克。水煎服。

注：“乙脑”患者嗜睡加深，常为昏迷的先兆，烦躁不安亦为抽风的先兆，要及早使用开窍息风药。本方及早使用，可避免或减轻昏迷、抽风的发生。过去常用“三宝”（安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹），但药源困难。使用本方，可代替“三宝”。但一定要早期使用。

方四：板蓝根30克，大青叶30克，生石膏60克，大黄15克（后下），厚朴10克，枳实10克，钩藤15克（后下），僵蚕10克，白芍15克。水煎服。

注：“泻下药”过去很少被作为治疗乙脑的主要手段。近年来发现用泻下法治疗乙脑，症状改善快，神志恢复亦快，且无后遗症，为乙脑的治疗提供了新线索。

对于乙脑的后遗症，要争取时间积极治疗，一般在恢复期刚开始一开始，就要及时地、积极地对后遗症进行治疗。

下列治疗后遗症的方剂，可酌情选用。

1. 白芍30克，生牡蛎30克，鳖甲15克，生地30克，生石决明30克，菖蒲12克，麦冬20克，阿胶12克，龟版30克，五味子15克，鸡子黄2枚。

服法：将药煎好过滤，待温后拌鸡子黄顿服。

2. 白附子12克，菖蒲12克，胆南星10克，天麻10克，全蝎6克，羌活10克，远志10克，地龙10克。水煎服。

3. 针刺：大椎、哑门、上廉泉、合谷、曲池，足三里、外关、环跳。

4. 鲜活地龙（淡红色者）适量。以冷水洗净，每100克

加水50毫升，炖汤内服，重复炖2次，30天为1疗程。小儿用量100~200克/次。

45. 精神分裂症

精神分裂症是最常见的一种精神病。发病以青壮年为多。其主要临床特点是：思维、情感、行为与环境之间互不协调（即所谓分裂现象）。

精神分裂症的临床表现多种多样，不同的病人有不同的症状，就是同一病人在不同的时间也可以有不同的症状。临床上可有下列三方面的主要表现。

1.思维破裂 思维破裂是指病人思考问题时没有中心，第一个念头和第二个念头之间缺乏任何联系，讲话时前言不搭后语，颠三倒四，有头无尾，没有条理，有时突然言语中断。有的病人讲话没有中心，别人听不懂他要说明什么问题（写文章也同样没有中心，别人看不懂）。有的病人整日叫喊不停，有的独自对空说话。

2.情感障碍 对亲人疏远、冷淡，甚至敌对。对一切事物表现冷淡，漠不关心，整天闷坐，胡思乱想；不理发，不刮脸，衣服已穿得很脏而病人自己还认为很干净。病人的情感反常，一件无关紧要的小事，可以使他突然暴怒，但对于一件很大的事，却无动于衷。

3.幻觉妄想 幻觉中心以幻听为多，病人听到空中或房上有人对他讲话，或听到一些人议论他。病人的行为常常受到幻觉的影响，甚至服从幻觉的命令做出一些危险的行为来，例如当他听见“声音”在命令他“打碎玻璃窗，跳出

去”，他就可以不加思索，不顾危险地去执行。

妄想的内容各式各样，稀奇古怪。有的病人坚信饭菜内有人放了毒药，或者认为别人咳嗽、吐痰都是某种“特别信号”；有的病人感到“半个脑子坏掉了”，“肠胃被塞住”，“身体受到电波、超声波的控制”等等。

精神分裂症属于祖国医学的“癫、狂、痫”范畴。中医认为多由思虑太过，积忧久郁，损及心脾，气滞津聚，结而成痰，痰气上逆，神志迷蒙，不能自主；或因恼怒愤愤，不得宣泄，郁而化火，肝胆气逆，郁火乘胃，津液被熬，结为痰火，痰火上扰，神志逆乱而发病。其治疗，宜理气解郁，化痰开窍，镇心涤痰，宁心安神。

方一：生地30克，白芍20克，麦冬20克，石斛20克，枣仁20克，菖蒲18克，知母12克，木通30克，大黄18克，生石膏60克，茯神12克，陈皮12克，远志12克。水煎服。

（本方基本上适用于各种类型的精神分裂症患者，只是对形寒畏冷、呆滞嗜卧的精神分裂症患者例外）。

方二：鲜蚯蚓，放冷水中游动2小时，排出腹中泥土，洗净后捞于盆中，每斤蚯蚓加白糖90克，放24小时，使其自动溶化，再加凉开水冲洗，连同蚯蚓液一同过滤，共得滤液1000毫升，放阴凉处，备用。夏天可加防腐剂。每次服100毫升，每日2次（本方适用于面红目赤、举止不安、兴奋叫喊之精神分裂症患者）。

方三：首乌60克，夜交藤60克，大枣20克，五味子30克，磁石30克。水煎服。每日一剂，连服15剂为一疗程。服后大便溏薄，不需处理。本方没有副作用，花钱少，显效快。

（本方适用于不食不眠，大便秘结、心悸易惊、神思恍

惚之精神分裂症患者)。

方四 大黄10克，桃仁10克，红花10克，赤芍12克，郁金12克，菖蒲15克，木通10克，香附12克，三棱10克，莪术10克。水煎服。

(本方适用于幻觉妄想、哭笑无常之精神分裂症患者)。

方五：天冬15克，麦冬15克，生南星3克，远志10克，菖蒲10克，茯神15克，钩藤10克，连翘10克，生铁落120克。

用法：先将生铁落用水800毫升煎取400毫升，去渣，以200毫升煎药（第一煎），再以200毫升煎第二煎，两次药液合并，一日分三次服。如患者大便结燥，先用大黄10克，芒硝10克，厚朴10克，枳实10克，当归15克，煎服，以泻火通便，然后再服本方，并须连服多剂，才有效果。

(本方适用于言语颠倒，打人骂人，毁坏器物之精神分裂症患者)。

方六：仙茅15克，仙灵脾30克，制附片30克（先煎），当归12克。

服法：水煎服。方中附片须先煎，并逐渐加量。附片最大剂量可达每日120克。病人阳气不足之症状，方始改善，疗效日趋明显，未见不良副反应。（但附片必须先煎四小时）。

(本方适用于呆滞、嗜卧、生活懒散、形寒畏冷之精神分裂症患者)。

精神分裂症早期治疗，疗效较好。但不少病人早期症状不明显，病人多半不承认自己有病，不愿就医，病人家属又缺乏精神病方面的知识，对病人的早期症状也不以为然，所以，往往延误治疗。现将精神分裂症的早期症状叙述如下，

希望引起大家的重视，做到早期发现病人，早期治疗。

精神分裂症早期症状的具体表现有：

无原因的头疼，头晕，失眠，多梦，情绪不稳定，脑子迟钝，常出差错。

对亲友逐渐冷淡、疏远，逢喜遇悲是无动于衷，不愿与人来往，对周围事物的兴趣明显减少，胡吃闷睡。

对周围事物多疑。常自言自语或对空说话，或无目的地到处乱走。

无故发脾气，时喜时怒，情绪变幻莫测。

发呆，两眼发直，长时间呆在一处不动。

嗜好突然改变。

爱与人争辩，爱管闲事，爱吹嘘。

以上这些表现，可为早期发现精神分裂症患者提供线索。但不一定都是病态，不要轻易下精神分裂症的结论。

治疗精神分裂症的验方：

1. 活地龙50条，酒洗大黄60克，生韭菜汁250克。将活地龙用纱布包扎煮沸2小时，此时加入酒洗大黄，再煮5分钟，其滤液和生韭菜汁混合顿服，每天1剂，或隔天1剂，10剂为1疗程。服药后有腹泻反应，是正常现象，不必顾虑。有的患者往往随着多次腹泻而症状减轻甚至痊愈。

2. 取适龄健康红牛（黄牛）之角，反复洗净，用木锉锉为粗粉，然后捣碎，经细筛后加入适量白糖即可服用。首次从2~3克开始，每日3次，逐渐加至每日60克。30日为一疗程。一般治疗3个疗程。

3. 地龙（新鲜活地龙）70克，白糖120克，将活地龙反复

洗净，放洁净容器中，加入白糖拌匀，静置12小时，地龙化水，取其汁饮用。

4.明矾120克，冰糖120克，用水600毫升浓煎至200毫升，空腹时1次顿服100~200毫升。

5.大黄30克，芒硝24克（冲），朱砂3克，牛黄0.9克，麝香0.24克。各研细末和匀为1料，干燥瓶贮保存。视患者体质及病情，每次服9~27克。1日2次，有腹泻反应，应坚持服药。一料服完，可停药数天，续服1料。

46. 流行性出血热

流行性出血热是一种自然疫源性传染病，可能由于病毒所引起。这种病毒在很多鼠体内繁殖，并在鼠群中传播。可能通过两种途径传染给人类：（一）叮咬鼠类的小虫（如螨、蜱）又叮咬人体，把病毒带入人体。（二）含出血热病毒的鼠尿污染了人类的破损皮肤，可能得病。

每年的四、五、六、七月份，人类的生产劳动很频繁，与田野里的鼠接触增多，病人也增多。到了冬天，十月到第二年的一月，田野里的鼠类为了觅食，向居民点靠拢，病人再次增多。这就是出血热每年流行的双峰。

出血热病人的病情发展变化很大，概括地说：“病分五期”，“两个转折”。五期即：1.发热期；2.低血压期；3.少尿期；4.多尿期；5.恢复期。两个转折就是：1、2期之间的“热降病加重”和3、4期之间的“尿多病就松”。

现分别谈谈出血热的症状。

1. 发热期

这时期的症状很象感冒，容易误诊。如能经常想到下面四句口诀，可以减少误诊。这四句口诀是：

腋下出血点，球结膜水肿；

烧尿显蛋白，热降病加重。

“腋下出血点”：仔细检查病人腋下前后的皮肤，可以发现针头大小，不高出皮肤的出血点，常常几个出血点排列成线，好象抓痒抓伤似的。不要把蚊子、跳蚤叮咬成的小红点认作出血点，也不要把红痣（血管痣）认作出血点，用手轻轻摸这些小红点，可以感到小红点是高出皮肤的。如果发现病人容易流鼻血，或者在打针的地方出现乌青块（紫癜），或者呕吐血块，解乌黑发亮的大便，病人有这些出血现象，也能帮助诊断。

“球结膜水肿”：白眼仁上盖着一层薄膜，称为球结合膜。出血热病人由于弥漫性血管壁受损，渗透性增加，血管里的水份向外溢出，球结膜下有液体积存。当眼球左右转动时，在内、外眼角可以见到球结膜皱成水波状。严重的球结膜下水肿好象一粒大水珠堵在眼角里。

“烧尿显蛋白”：出血热病人的肾脏受损伤，尿里出现蛋白。这种蛋白可用煮沸的方法使它显出来。取1~2毫升尿液放在玻璃管内（可以用废安瓿代替），将尿液上层加热到沸腾，如果出现白色云雾状沉淀，加2~3滴6%醋酸液（可以用食醋代替）仍不消失，表示尿内有蛋白。

“热降病加重”：发热期大约持续5~6天。生病后4~6天体温往往下降。如果是感冒或其他热病，体温下降，症状减轻。但是在出血热，体温下降是病程进入第二期（低血压期），病情更严重了。这种“热降病加重”的特点可以帮助

诊断。

2. 低血压期

轻病人只是血压轻度向下波动，时间短，很快进入少尿期。重病人的血压常降到零，持续时间长，病情危重，容易死亡。这个时期常持续1~3天。

3. 少尿期

这时血压往往回升到正常，有时血压过高。主要症状是少尿（每天尿量在400毫升以内）或无尿（每天尿量在50毫升以内）和出血（鼻出血、呕血、便血、脑溢血），有时出现心力衰竭、肺水肿，有时发生肾功能衰竭尿毒症。病情凶险。这个时期常持续1~5天。

以上两期常常互相重叠，不少症状是两期共有的，也可用四句口诀帮助记忆。

出血却脸红，三痛腰叩痛；

呕吐又呃逆，尿多病就松。

“出血却脸红”：在发热期就有出血现象，到低血压期和少尿期（尤其是少尿期）更为突出，吐血和便血常是主要矛盾。颅内出血常常是死亡的原因。一般出血的病人常见脸色苍白，出血热病人发生出血时却常脸色潮红，象喝醉酒一样，医学上称为酒醉貌。眼结合膜充血，满布红筋却少眼屎，球结膜下水肿更为明显。

“三痛腰叩痛”：三痛就是头痛、眼眶痛和腰痛。发热期就有三痛，到这时就更痛了（热降病加重）。腰痛是双侧腰痛，并且有明显的叩击痛。

出血热的腰部叩击痛，酒醉貌，出血点和球结膜下水肿是诊断出血热的四个重要体征。

“呕吐又呃逆”：呕吐很常见，也常有腹痛，加以白血球增多，常被误诊为外科急腹症（阑尾炎、肠梗阻等）。呃逆也常有，往往很顽固。

“尿多病就松”：尿多表示病程脱离危重的少尿期，进入好转的多尿期。

从发热期进入低血压期，病情由轻转重，就是“热降病加重”，这是第一个转折点，“尿多病就松”是第二个转折点。

4. 多尿期

每天尿量在2500毫升（夏天）~3000毫升（冬天）以上称为多尿。一出现多尿，症状很快改善。这个时期约持续3~5天后尿量又降至正常。

5. 恢复期

一般情况好转，病人自觉软弱无力，一般需要10~20天才能完全恢复健康。

流行性出血热的分期治疗：

1. 发热期：发冷，寒战，高热，头痛，腰痛，眼眶痛，羞明，视力模糊，口渴，恶心，呕吐，腹痛，腹泻，颜面眼眶明显充血，状如醉酒，球结膜水肿、充血，有出血点或血斑。软颚、腋下可见散在针尖大小的出血点。发热期的治疗原则为清热解毒，或清营解毒，养阴生津。

基本处方：银花30克，大青叶30克，板蓝根30克，生石膏30克，蚤休30克，生地15克，丹皮12克，竹叶12克，知母12克，水煎服。

2. 低血压期：轻者血压波动，重者血压骤降或不能测出。此期出汗多，口渴，呕吐加重，尿量开始减少，烦躁，

谵妄，狂躁，脉数而弱。治宜补气生津。

基本处方：人参10克，麦冬30克，五味子15克，丹皮12克，桑叶12克，银花12克，煅龙骨30克，煅牡蛎30克，水煎服。

3.少尿期：此期肠胃道症状、精神症状和出血现象显著，明显少尿或尿闭。治宜凉血解毒，活血化瘀，养阴利水。

基本处方：桃仁10克，生大黄10克，芒硝10克，桂枝10克，白芍15克，丹皮10克，银花15克，山梔10克，泽泻12克，竹叶10克，木通10克，茅根30克。水煎服。

缩短少尿期是治疗出血热的中心环节。

4.多尿期：尿量增多，夜尿。

此期治疗应以育阴潜阳为主，而不宜使用收涩药。

基本处方：山药30克，山萸12克，熟地15克，丹皮10克，茯苓30克，泽泻12克。

总的说来，发热期的治疗至关重要，治疗得当，大量排除毒素，则可使低血压期、少尿期很快渡过。

出血热各期有神昏、谵语、烦躁等，均可投以“三宝”（紫雪丹、至宝丹、安宫牛黄丸）。

47. 白细胞减少症

周围血液白细胞计数持续低于4000/立方毫米，称为白细胞减少症。引起白细胞减少的因素大致有：

- 1.化学物质如苯、抗肿瘤的化学药物；
- 2.物理因素如X线及放射性物质；

3. 药物过敏或药物毒性引起白细胞减少，例如，氨基比林、保泰松、安乃近、眠尔通、氯丙嗪、苯妥英钠、三甲双酮、磺胺类、氯霉素、合霉素、新生霉素、异烟肼、对氨水杨酸钠、奎宁、有机砷、铊剂、汞剂等，均可引起白细胞减少；

4. 感染：某些细菌性、病毒性、立克次体性和原虫性感染，败血症或其他严重的感染，特别是老年或衰弱病员，均可引起白细胞减少；

5. 继发于其他疾病：如脾功能亢进、系统性红斑狼疮、再生障碍性贫血、白血病、恶性肿瘤转移等，均可引起白细胞减少。

白细胞减少症的临床表现：有轻度乏力，头昏，低热，盗汗，恶心，失眠等一般症状。患者即使患白细胞减少症多年，也大多无明显恶化现象。白细胞计数多在2000~4000/立方毫米之间。

白细胞减少症，属于祖国医学的“虚劳”范畴，属于气血虚弱、脾肾两虚的病变。脾为后天之本，主运化，输布水谷精微，司升降清浊，为人体气血生化之源，五脏六腑四肢百骸皆赖以所养。若脾失健运，水谷精微不能正常输布，人体气血不足，则易发生白细胞减少症。

肾为先天之本，主骨生髓，肾精充足，则髓海充盈，精能生血，与现代医学骨髓造血的论点颇相近似。若肾精不足，髓海空虚，会影响造血功能，而导致白细胞减少症的发生。

补益气血、温养脾肾是治疗白细胞减少症的有效方法。脾健则生化有源，肾健则根本坚固，白细胞即可上升。

方一：鸡血藤30克，黄芪30克，大枣30克，补骨脂12克，炙甘草10克。水煎服。

方二：人参叶30克，太子参30克，白术15克，女贞子30克，旱莲草30克。水煎服。

方三：石苇30克，虎杖30克，五灵脂10克，乳香10克，没药10克，山甲15克。水煎服。

方四：菌灵芝30克（先熬），枸杞30克，丹参30克，当归15克，首乌15克，紫河车粉10克（吞服），阿胶12克。水煎服。

针灸疗法对白细胞减少症也有较好疗效。

穴位：大椎、内关、曲池、足三里、肾俞、先针刺，后艾灸，灸至皮肤潮红为度。每日针灸一次。穴位可交替选用。

治疗白细胞减少症的单方验方：

1. 鹅血，干燥制成鹅血粉或糖衣片，每次服1.5克。特别是癌症病人的白细胞减少，用鹅血治疗，效果满意，不仅能升白细胞，而且对癌细胞有抑制作用。其服法，可将鹅杀死，乘热饮鹅血。

2. 蜂王浆，每日2支，早晚空腹服。

3. 八珍丸或十全大补丸（均为成药），照说明的剂量加倍服用。

4. 金匱肾气丸（成药），照说明的剂量服用。

5. 补骨脂适量，微炒，研为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每次服2丸，每日服3次，盐开水送服。每服4周为1疗程。

6.丹参30克,女贞子30克,黄精30克,熟地30克,当归30克,黄芪60克,人参叶30克。水煎服,每日一剂。

7.刺五加片,每次服4片,每日服3次,连服1~3个月。

48. 过敏性紫癜

过敏性紫癜又称出血性毛细血管中毒症,是一种免疫反应性疾病,主要累及毛细血管壁而发生出血症状。除了皮肤紫癜(皮下有瘀点、瘀斑)以外,常有不同程度的胃肠道、关节及肾脏方面的症状。血液检查可无异常发现。

与过敏性紫癜发病直接有关的因素包括细菌感染、寄生虫感染,食物或药物过敏。

过敏性紫癜多见于儿童和青年。起病前可有全身不适、发热、食欲不振,少数病例先出现胃肠症状或关节症状,往往被误诊为其他疾病。

过敏性紫癜的皮肤病变最多见于下肢及臀部,常对称分布,分批出现,紫癜大小不等,可高出皮面,有时伴有荨麻疹或手足水肿。较严重的紫癜可融合成大疱。胃肠道症状有恶心、呕吐、便血、吐血等,但以突然发作的腹绞痛为常见,脐周及下腹部绞痛,并可反复发作,如不伴有皮肤紫癜,常可误诊为急腹症。

过敏性紫癜若伴有低热,易被误诊为风湿病。

过敏性紫癜的关节症状多为膝、踝、腕关节的肿胀和疼痛。肾脏病变可表现为蛋白尿、血尿或管型尿。

过敏性紫癜属于祖国医学的“发斑”、“肌衄”、“葡萄疫”等范畴,其病机多属气火逆乱,血不循经,脉络损

伤，血溢于外所致。《外科正宗》说：“葡萄疫多生于小儿，感受四时不正之气，郁于皮肤不散，结成大小青紫色斑点，色若葡萄……”。《医宗金鉴》说：“状若葡萄，发于遍体，惟腿胫居多”。其治疗，宜凉血祛瘀，疏风清热。

中医治疗过敏性紫癜一般可分为以下三种类型：

1. 血热妄行 皮肤瘀点或瘀斑，弥漫成片，伴腹痛，身热，鼻衄，溲赤淋痛，舌质红或有瘀点，苔黄脉数。治宜清热凉血，活血祛瘀。

处方：水牛角30克，丹皮12克，赤芍12克，生地30克，山梔10克，紫草30克，连翘12克，大小蓟各12克，防风10克。水煎服。

2. 湿热交阻 皮肤紫斑，伴关节疼痛，肿胀灼热，四肢沉重，偶见腹痛、尿血。治宜清热利湿，化瘀通络。

处方：牛膝12克，苡仁30克，苍术12克，黄柏12克，防己10克，茵陈30克，玄参20克，白茅根30克，山梔10克，槐花10克，仙鹤草30克，侧柏叶12克。水煎服。

3. 脾不统血：皮肤紫斑，面色㿔白，纳差，恶心，呕吐，便溏或黑，肢倦乏力。治宜健脾摄血。

处方：党参30克，黄芪20克，鸡血藤30克，白术12克，鸡内金12克，木香12克，茯苓30克，陈棕炭12克，小蓟12克，大枣30克，仙鹤草30克，茜草10克。水煎服。

治疗过敏性紫癜的单方验方：

1. 甘草30克，黄芪30克，桂枝12克，白芍12克，大枣30克。水煎服。

注：本方中甘草、黄芪、桂枝等均有抗过敏作用。

2. 乌梅30克，槟榔12克，鹤虱10克，川楝皮10克，雷丸

10克，紫草12克，生地30克，茜草10克，地榆12克，水煎服（本方适用于蛔虫等寄生虫引起的过敏性紫癜）。

3.蒲黄炭10克，五灵脂10克，生地30克，赤芍10克，丹皮12克，紫草30克，侧柏叶20克。水煎服。

4.生大黄12克，加水略煎，放冷，加新鲜童便30~60毫升，一次或分次服之（一日量）。

注：童便为滋阴清热良药。朱丹溪指出：“降火最速，莫过于童便，其味咸而走血，治诸血证必不可缺，……血逆者加童便，其效更速”。蒲辅周说：“阴虚火动，热蒸如燎，服药无益者，用童便滋阴清热，效更佳”。

对过敏性紫癜的治疗，要积极寻找并消除致敏因素。如系寄生虫病引起者要予以驱虫治疗，扁桃体炎或其他感染病灶如结核病等应及时处理。某些过敏药物（如水杨酸类、阿托品、奎宁、碘类、青霉素、链霉素、氯霉素、异烟肼等等）或过敏食物（鸡蛋、牛奶、鱼、虾等等）应予避免。

49. 脂 膜 炎

脂膜又称回归发热性结节性非化脓性脂膜炎，是一种临床上少见的疾病。现代医学尚无特效疗法。其主要临床表现为反复发作的皮下脂肪层的炎性结节或片块，同时伴有发热，部分病例可有肝脾肿大。

脂膜炎的病因尚不十分明了，目前多认为可能是溴化物、碘化物和感染病灶诱发的一种变态反应。

临床表现：患者以20~40岁女性最多见。皮损好发于四肢和躯干，但最多累及臀部和股部。患处出现成批的色红质

硬的皮下结节或片块，大小不一，或如指头大，或如鸡蛋大，边缘清楚，推之不移动，结节与表皮粘连，有轻度压痛。少数结节中心可坏死破溃，流出脂状物质，但不化脓。经数日或数周后，结节逐渐消失，患处皮面可有褐色色素沉着，或轻度凹陷。

患者可伴有发热，乏力，食欲不振，恶心呕吐等症状。有的患者肝脾肿大，每次发病可持续一月到数月，经间歇后再呈回归型发作。

通过活体组织病理切片检查，可以确诊。

脂膜炎类似于祖国医学的“梅核丹”，中医认为脂膜炎系热毒内蕴，外受寒湿，以致经络受阻，气血凝滞，营卫失调所致。治宜活血化瘀，化湿通络，清热解毒。

方一：银花30克，紫花地丁15克，黄柏10克，山梔10克，土茯苓30克，五灵脂10克，莪术15克，炮甲珠15克。水煎服。

方二：丹参30克，川芎10克，赤芍10克，秦艽10克，海桐皮10克，地骨皮10克，牛膝12克，茯苓30克，泽泻12克，鸡血藤30克。水煎服。

方三：泽兰10克，赤芍10克，当归12克，桂枝10克，青皮10克，红花10克，香附12克，牛膝12克，山甲15克，地龙10克，三七6克，威灵仙10克，鸡血藤30克，丹参30克。水煎服。

总的说来，活血化瘀治法能使脂膜炎的红斑结节消退。唐容川说：“既已成瘀，不论初起、已久，总宜散血；血散瘀去，则寒热、风湿均无遗留之迹点”。

妇 产 科

50. 经前期紧张综合征

经前期紧张综合征是指月经前一周或半月出现头痛、倦怠、头晕、乳房胀痛、尿频、浮肿、抑郁、神经过敏、易激动、胃肠功能紊乱等一些症状，月经结束后，这些症状自然消失。

经前期紧张综合征可能与月经前期雌激素、黄体素分泌旺盛，以及肾上腺机能亢进有关。在此期间往往引起水盐代谢失调而形成水肿。

祖国医学无经前期紧张综合征的病名，根据其临床表现，类似于“肝郁气滞”、“脾肾阳虚”、“心脾两虚”等证候。

1. 肝郁气滞 经前乳房胀痛，小腹胀满，经期提前或延后，经量或多或少，舌质暗红，脉弦细。治宜疏肝理气。

处方：柴胡12克，当归12克，白术12克，白芍12克，茯苓15克，郁金10克，川楝子10克，甘草6克。水煎服。

2. 脾肾阳虚 月经前一周，出现浮肿、头晕、体倦、纳少、腹胀满、便溏甚至泄泻、腰膝酸软，舌胖嫩，苔白，脉细弱。治宜温肾健脾。

处方：党参30克，白术15克，茯苓20克，巴戟天10克，

仙灵脾30克，山药30克，黄芪30克，麦冬15克，五味子10克。水煎服。

3. 心脾两虚：月经来潮前，心悸，失眠，健忘，面色萎黄，神疲乏力，纳少，舌质淡红，苔白，脉弱。治宜补养心脾。

处方：酸枣仁12克，远志10克，大枣30克，木香10克，茯神15克，当归12克，白术12克，黄芪30克，党参30克，五味子15克，刺五加30克。水煎服。

51. 妊娠水肿

妊娠水肿是妊娠中毒症当中的一种，属于轻度的妊娠中毒症。妊娠水肿是指妊娠24周以后，仅有踝部向上发展的水肿，而无高血压或蛋白尿，经休息，水肿仍不消退。

如果皮肤浮肿不明显，但体重每周增加一市斤以上者，称为隐性水肿，也属妊娠水肿范围。

临床上，浮肿的程度不等，轻者，小腿以下有明显的指压性（凹陷性）浮肿；较严重者，大腿以下有浮肿，皮肤肿得发亮；严重者，浮肿可涉及腹壁与外阴。

妊娠水肿属于祖国医学的“子肿”范畴。中医认为妊娠后，脾肾之气较弱，肾阳不足，不能温煦脾阳，运化与蒸腾之功能失常，水湿停聚，溢而为肿。或因胎体渐大，导致气机不畅，肺气亦失宣达，通调水道之功能失调，而致肿胀。治宜健脾利水，补肾安胎。

方一：黄芪30克，白术30克，党参20克，当归10克，茯苓20克，防己10克，柴胡10克，升麻6克。水煎服。

方二：寄生30克，白术20克，连皮茯苓20克，陈皮10克，大腹皮10克，生姜皮10克，黑豆衣6克。水煎服。

妊娠水肿治疗不难，但若治之失误，则可导致先兆子痫。对妊娠水肿的治疗，既要补肾保胎，又要健脾利水，寓消于补，才能收到良好疗效。

治疗妊娠水肿的单方验方：

1. 冬瓜皮30克，赤小豆30克，砂仁6克，炒扁豆10克，炒苡仁12克，水煎服。

2. 鲤鱼1条，白术15克，生姜15克，白芍10克，茯苓30克，炖服。

3. 甘松100~300克，加水适量，煮沸数分钟，去渣，待药液温度降到40℃时，擦洗患处，每天1~2次，每剂可洗4次。

52. 妊娠高血压

妊娠高血压是妊娠中毒症当中的一种，属于轻度妊娠中毒症。孕妇在怀孕前无高血压史，在妊娠24周以后，出现血压增高，而无水肿及蛋白尿，称为妊娠高血压。其病理变化为中小动脉痉挛，周围血管阻力增加而引起血压升高。肾小动脉痉挛，肾血流量减少，肾组织缺氧，使增压分泌物增多，以致血压波动在较高的水平。

患者几次测量血压（每次相隔六小时以上）均超过130/90毫米汞柱，或收缩压与舒张压分别比基础血压（孕前或妊娠早期的血压）高出30/15毫米汞柱以上，但无其他症状者，

应诊断为妊娠高血压。

如果孕妇过去从未检查过血压，而于怀孕24周以后，第一次检查发现有高血压时，若能排除慢性高血压，则应考虑为妊娠高血压；如果个别病例不易确诊，则须待产后一个较长时间观察，才能断定。如果孕妇原有慢性高血压史，在怀孕24周以后，发现在较恒定的高血压的基础上，血压又急剧上升或继续上升，应考虑为慢性高血压合并妊娠高血压。

妊娠高血压属于祖国医学的“阴虚阳亢”范畴。中医认为妊娠期血聚养胎，胎前多热，阳盛于阴，阴气不足，导致肝肾阴虚，肝阳上亢，而出现妊娠高血压。治宜养阴平肝，清热降逆。

方一：生地30克，菊花15克，白芍30克，女贞子30克，旱莲草30克，黄芩12克，寄生30克，珍珠母30克。水煎服。

方二：麦冬30克，夜交藤30克，石决明30克，杜仲15克，菌灵芝30克（先熬），玉米须30克。水煎服。

注：妊娠高血压的治疗，既要降压，又要安胎，上述两方的组成即符合降压保胎的原则。方中白芍、黄芩、寄生、杜仲、菌灵芝均为安胎之常用药，又具有降压作用。用于妊娠高血压患者，甚为合适。

53. 妊娠呕吐

有不少孕妇在妊娠5~6周至三个月之间这段时间里，有轻度恶心、呕吐、厌食、偏食等现象，称为妊娠反应，不算病态。但有少数孕妇，恶心呕吐症状一开始就严重，或逐渐加重，以致不能进食，影响身体健康，这就是病态了。这种

病症称为妊娠呕吐，属于早期妊娠中毒症的一种。

妊娠呕吐及由此引起的全身障碍，可分为以下三个阶段。

1.轻度呕吐 呕吐常在饭后加重，伴有失眠或嗜睡，便秘，乏力等，但一般健康状况尚好。

2.中度呕吐 呕吐更加频繁，甚至整日呕吐，唾液增多，出现脱水及营养不良现象，眼球下陷，体重减轻，口渴，口臭，皮肤干燥，尿少，尿中可查出酮体，表现酸中毒症状。

3.重度呕吐 呕吐持续不止，且继续发展，出现严重的中毒现象，体温升高，脉细弱，血压下降，出现黄疸，尿少，甚至无尿，尿内出现管型、蛋白，发生衰竭，陷于昏迷。

祖国医学称妊娠呕吐为“妊娠恶阻”，认为由于胎气上逆、胃失和降所致。治宜调气和胃，降逆止呕（忌用升散之品）。

方一：竹茹10克，姜半夏10克，陈皮10克，苏叶3克，黄连3克。水煎服。

方二：砂仁6克，陈皮10克，白术10克，茯苓15克，党参15克，旋覆花10克，姜半夏10克。

服法：水煎服，每次服药一匙，24小时服完一剂。甜梨一个为引。

注：半夏本为妊娠禁忌药，但治妊娠呕吐则例外，实践证明，姜半夏对孕妇及胎儿毫无损害。

治疗妊娠呕吐的单方验方：

1.黄连1.5克，苏叶3克，泡开水，频频饮服。

2.法夏、生姜、茯苓各10克，水煎服。

3.青蒿10克，旋覆花10克，竹茹10克，麦冬15克，芦根30克，砂仁6克。水煎服。

4.法半夏10克，青黛10克，赤石脂30克，加水煎浓，调入蜂蜜60克，徐徐温服。一次只饮一口，半天之内服完一剂。

5.灶心土60克，水煎过滤，当茶饮（徐徐饮服）。

中医中药治疗妊娠呕吐疗效确实，奏效迅速。药液应徐徐服下，一次只饮一口。及时服药，常可避免脱水或酸中毒。即使已发生脱水、酸中毒，若同时应用中药治疗，也可减少输液的数量，缩短疗程。若配合针灸治疗（针刺内关，足三里等穴位，饭后即进针），疗效更佳。

6.砂仁3克（后入），鸡内金3克，陈皮3克，黄连3克，苏梗3克，生姜6克，炒白术10克，党参10克。水煎，频频饮服，不可服多量，多量易呕吐。每日1剂。

7.厚朴3克，生麦芽10克，苍术10克，陈皮6克，黄芩10克，炒枳壳6克，炒山楂炭10克，生姜10克。水煎，频频饮服，每日1剂。

8.黄连0.3克，苏叶0.9克。泡水代茶饮，频频饮服。

9.芦根30克，生姜15~25克。水煎3次，药液合并，频频饮服，每日1剂。

54. 产后尿潴留

产后尿潴留是产妇的一种常见病。

产妇在分娩后8~12小时内就会自解小便，要是产后不能自解小便，称为产后尿潴留。造成尿潴留的主要原因有：

1. 产妇不习惯睡在床上解小便。

2. 分娩过程中会阴撕裂，或有伤口，肿痛得厉害，反射性地引起尿道括约肌痉挛，因而造成排尿困难。

3. 产程比较长，膀胱受胎头压迫比较久，膀胱颈部受压水肿，阻碍排尿。

4. 腹压骤降，腹壁松弛，膀胱张力减低，没有尿意。或虽有尿意，但排不出小便来。或者尿量很少，排尿困难。

产后尿潴留属于祖国医学的“癃闭”范畴。《内经》说：“膀胱不利为癃，……”。产妇分娩后由于正气亏虚，胞脉受损，肾气不固，膀胱气化不利，开阖功能失职，导致小便异常。

中医治疗产后尿潴留一般分为气虚、肾虚、气滞三种类型。

1. 气虚型 产后排尿无力，小便不通，小腹胀急，精神萎靡，言语无力，舌淡苔薄，脉缓弱。

治宜益气，补虚，利水。

处方：黄芪30克，车前草30克，通草10克，党参30克，白术20克，茯苓30克，麦冬30克。水煎服。

2. 肾虚型 产后小便不通，膀胱胀满而痛，腰部酸胀，坐卧不宁，面色暗晦，精神疲倦，舌淡苔白，脉沉迟。

处方：熟地15克，山药30克，女贞子30克，泽泻10克，丹皮10克，茯苓15克，肉桂6克，制附片20克（先熬）。水煎服。

3. 气滞型 产后小便不通，膀胱胀痛，精神抑郁，两胁胀痛，烦闷不安，舌苔正常，脉弦。

处方：当归10克，枳壳10克，木通6克，木香10克，滑石

15克，冬葵子12克，槟榔10克。水煎服。

针灸治疗产后尿潴留有很好的疗效。

取穴：气海透曲骨，左归来透右归来，足三里，阴陵泉，三阴交。针后加灸。

治疗产后尿潴留的单方验方：

1.葱白，切碎，加入炒热的盐中，用纱布包好，在脐部及其周围热熨，可通小便。

2.当归12克，川芎10克，牛膝12克，木通10克，桃仁10克，车前草30克，肉桂6克，制附片20克（先熬），炮姜炭10克，木香10克。水煎服（本方适用于产后尿潴留而屡用补气、温阳药无效者）。

治疗产后尿潴留的验方：

①磁石5克，商陆5克，麝香0.1克。先将磁石、商陆研成极细末，再加麝香研匀，分为2份，分别摊放于脐眼、关元穴，覆盖胶布固定。

②高丽参5~10克，黄芪30克，白术15克，当归15克，陈皮6克，柴胡6克，升麻6克，茯苓30克，车前草30克。水煎服。（无高丽参可改用红参或人参叶，人参叶用量30~40克，党参无效）。

③蝉蜕（去头足）9克。加水500~600毫升，煎至400毫升，去渣加红糖适量，一次服完。服后5小时仍不排尿，可再服1剂。

④沉香3克，肉桂3克，黄芪30克，茯苓30克，白术15克，小茴香15克，泽泻30克，大黄10克。水煎服，每日一

剂。服后有轻泻反应，排尿后则停服。

55. 产褥感染

产褥感染又称产褥热，系产褥期中，因细菌侵入生殖器官，引起局部或周身感染。

产褥感染大多发生于产后24小时至10日内。感染来源有：接生时消毒不严，将细菌带入阴道；妊娠末期性交，盆浴或临产时产妇自己用手指到阴道里试探，以致污染；产后用不干净的东西垫外阴；产程过长，阴道检查的次数过多；自体感染，如阴道内有致病菌，或身体其他部位有发炎的病灶，经血液或淋巴循环侵入产道。

产褥感染的临床表现：

当会阴、阴道局部创面发生感染时，伤口局部红肿热痛，伤口发硬，创面不愈合而引起溃疡、局部疼痛，有脓性分泌物。可伴发小便疼痛或小便困难。也可有全身症状，如畏寒，发烧等。

当发生子宫内膜炎及子宫肌炎时，可出现头痛、发烧、下腹痛、恶露量多且有臭味，体温在 $38\sim 39^{\circ}\text{C}$ 之间，子宫复旧不良，有明显压痛。

当炎症蔓延至输卵管、卵巢、宫旁组织或盆腔腹膜时，可突然寒战、发烧，体温可达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，全身症状明显，下腹痛显著，可有包块形成，有明显压痛，白细胞增高，病程较长。

当炎症蔓延至腹膜时，则出现腹膜炎症状，发冷，持续

高热，脉速而弱，腹胀，腹痛，压痛，反跳痛明显，但腹肌紧张不显著（因腹壁松弛）。

当感染累及静脉，发生血栓性静脉炎时，下肢可有严重水肿，发烧时轻时重，主要以血栓形成部位疼痛及下肢疼痛为主。

产褥感染，与祖国医学之“产后发热”相似。“邪之所凑，其气必虚”。产妇在分娩时的创伤和出血，元气受损，营卫失调，抗病力差，易致毒邪感染。治宜清热解毒，凉血化瘀。

方一：马齿苋120克，蒲公英60克，银花30克，皂刺1²克。水煎服。

方二：丹皮12克，赤芍12克，生蒲黄10克，五灵脂10克，野菊花30克，紫花地丁30克，紫背天葵15克，鱼腥草30克（后下）。水煎服。

方三：鸭跖草30克，半枝莲30克，连翘15克，银花30克，益母草30克，丹参30克，黄连10克，犀角3克（水牛角30克代），赤芍12克，丹皮12克。水煎服。

产褥感染的预防：

孕期服用钙剂，防治呼吸道感染，防治滴虫性或霉菌性阴道炎。

临产一个月內不性交，不盆浴，不作不必要的阴道检查，接生注意消毒。产程延长，阴道检查次数较多者，也可选服以上方剂，以加强预防。

儿 科

56. 鹅 口 疮

鹅口疮是由白色念珠菌引起的一种感染性口腔疾病，是儿科的一种常见病。口舌内满布白屑为其主要特征。

白色念珠菌平素寄生在健康人的皮肤和粘膜，并不造成病变，当身体抵抗力减弱或口腔不清洁时，则容易发病。

近年来由于抗菌素的使用范围日益扩大，鹅口疮更为增多。长期应用广谱抗菌素，消化道的常住细菌减少，体内菌群失调，有利于霉菌生长繁殖。白色念珠菌的菌丝体，生长于口腔粘膜的上皮细胞内，因而形成白色片状物。

鹅口疮，一般全身症状甚少，只是食欲不振，哺乳时啼哭。本病初起时，先在舌边、颊粘膜可见白色小块，严重的可蔓延至整个口腔粘膜，满口出现很多象豆腐渣的白膜，融合成片，形似雪花，状如鹅口，白膜不易剥离，兼见发热烦躁，流涎等症状，但局部淋巴结不因此而增大。诊断可取白色块状物少许，放玻片上，加10%氢氧化钠一滴，显微镜下可见霉菌菌丝体及芽胞。

鹅口疮，祖国医学亦称鹅口，又称雪口病。中医把本病分为虚证和实证两大类型。虚证是由于胎禀不足，后天乳食、药物、护理失当，致脾肾不足，水不制火，虚火上浮而

发病。实证是因心脾（胃）积热所致。

辨证施治：

1.虚火上浮 患儿形体瘦弱，面白颧红，口干不渴，舌淡，指纹淡红。治宜壮水制火。

方一：熟地6克，山萸6克，山药6克，泽泻3克，茯苓3克，丹皮3克，肉桂1.5克。水煎服。

方二：板蓝根12克，吴萸3克。

服法：水煎服。

2.心脾积热 患儿烦躁不宁，叫扰啼哭，舌尖红赤，便干而结，小便短黄，指纹紫滞。治宜清心泻脾。

方一：黄连1.5克，黄芩3克，栀子3克，生石膏10克，蒲公英10克。水煎服。

方二：青黛3克，儿茶1.5克，茯苓6克，灯心3克，地龙3克。水煎服。

治疗鹅口疮的单方验方：

1.五倍子30克，枯矾24克，白糖24克，先将五倍子炒黄加入白糖，稍炒片刻，待白糖熔化，倒出凉干，加枯矾共研细末备用。用时将香油和药末调成糊状，抹于患处，每日2~3次，抹药后，白膜即脱落。

2.生半夏6克，黄连3克，栀子3克，共研细末，陈醋调成糊状（一次量），睡前涂患儿两足涌泉穴，纱布包扎，重者可连敷2~4次。

3.生石膏24克，乳香10克，没药10克，冰片3克，黄连10克，青黛10克，共研细末，抹患处，每日3~5次。

3.板蓝根30克，千里光30克，加水浓煎，涂患处，每日

5次，亦可少量内服。

5. 蚯蚓二条洗净，放杯中，加白糖，静置，即有渗出液，将此液涂于患处，每日3~5次。

6. 成药冰硼散或锡类散涂患处。

7. 人中白30克，白矾30克，活蜘蛛5个，冰片3克。人中白用清水反复漂洗至无特殊气味，晾干研细。白矾置锅中溶化后，放入蜘蛛、人中白，全部炼成枯矾为止。冷后与冰片共研为极细末，贮瓶闭密备用。用时用小竹管吹入口内，每日2次。

8. 五倍子、白矾各等份，冰片少许。将五倍子、白矾分别捣碎如米粒，和匀放于砂锅内用文火炙炒，并以竹筷不停搅拌，炒至枯矾状，离火冷固取出，研极细粉末。另研冰片少许加入拌匀，贮瓶备用。用时以净指蘸冷开水粘药粉少许涂患处，每日1~3次。

9. 莱菔子10克，白芥子10克，地肤子10克，食醋适量。上药用砂锅文火炒至微黄，共研细末，将食醋煮沸，放置冷却，再倒入药末，调成膏状，把药膏分次涂于2厘米见方的纱布或白布上，药膏厚2厘米，分别贴于两足涌泉穴，胶布固定，每日换药1次。

10. 寒水石10克，黄连15克，青黛15克，乳香15克，生石膏15克，冰片6克，硼砂6克。共研细末，密闭贮存，用时，以纸筒将此药少许吹入患处。

57. 蚕 豆 黄

蚕豆黄，又称胡豆黄，是一种以先天性的红细胞内6-磷

酸葡萄糖脱氢酶缺陷为基础的疾病。常由于吃生的或熟的鲜蚕豆（胡豆）而引起急性溶血性贫血。农村发病高于城市。也有的婴儿可因吃了吃过蚕豆的母亲的奶汁而发病。也有的因接触蚕豆的花粉而发病。现代医学认为，具有6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺陷的人，不仅可由吃蚕豆引起溶血性黄疸，而且某些药物如伯氨喹啉、阿的平、非那西汀、阿斯匹林、磺胺、氯霉素等也可诱发溶血性黄疸。

约有40%的患者有家族史，故发病与遗传有关（发病与进食蚕豆的多少无关）。

发病的绝大多数是男孩，年龄多在五岁以下。发病常在吃新鲜胡豆后数小时到数天。其表现轻重不一。轻者仅有轻度贫血，而无血红蛋白尿，稍有乏力及食欲不振。这种病孩往往不易被发觉，多不经治疗而自然痊愈。病重者突然畏寒发热，可有呕吐，面色突然苍白，小便呈樱桃红色或酱油色，继后皮肤巩膜出现黄疸，肝脾肿大。严重者由于短时间内溶血过多，贫血严重，出现烦躁甚至惊厥而昏迷，并可产生循环衰竭及急性肾功能衰竭（大量血红蛋白酸性物质在肾小管内沉淀）。若不立即抢救，可有生命危险。

在蚕豆成熟季节，患者有食蚕豆史（部分患者有家族史），并出现贫血、黄疸、血红蛋白尿等蚕豆黄的特征，通过查血、查尿后即可确诊。

蚕豆黄属于祖国医学的“黄疸”范畴。中医认为多由湿热蕴蒸所致。正如《临证指南医案》所说：“阳黄之作，湿从火化，瘀热在里，胆热液泄，……熏蒸遏郁，身目俱黄”；

“阴黄之作，湿从寒水，……浸淫肌肉，溢于皮肤，色如熏黄”。治疗宜凉血退黄，佐以补血止血。

方一：生地30克，当归6克，茵陈30克，白芍6克，藕节10克，白茅根30克，仙鹤草10克，大枣15克，茜草3克。水煎频服。每日一剂。

本方不仅能控制溶血，而且能加速红血球的生成，对于蚕豆黄的治疗，极为有利。

方二：黄芩6克，黄连6克，黄柏6克，大黄6克，栀子6克，茵陈30克，生地30克。水煎频服。

治疗蚕豆黄的单方验方：

1. 清明菜（又名田艾、鼠曲草、佛耳草、酒曲绒、黄花鞠草）60克、茵陈30克，车前草30克，凤尾草30克，加水浓煎，加白糖当饮料服。

2. 南通蛇药：首剂：1岁2片（每片含主药0.3克），2~3岁4片，4~5岁6片，6~8岁8片，9~10岁10片，11~15岁12片，16岁以上15~20片。以后每隔4小时服一次，剂量减半，连服3~5天。

58. 佝 偻 病

佝偻病是由于维生素D不足，而使磷钙的代谢失常所致的全身性慢性营养不良疾病，以骨骼系统生长发育障碍为主要特征。多见于三岁以内的小儿，早产儿尤易发生。居住环境不良、营养缺乏是佝偻病发病的主要原因。

小儿维生素D缺乏的原因有：日光照射不足；饮食中维生素D含量不足；早产儿肠道发育不成熟，对维生素D和磷、钙的吸收不好；患其他疾病影响了维生素D和磷、钙的

吸收和利用。

佝偻病的临床表现：初期的症状是：易兴奋、哭吵、烦躁、睡眠不安、夜啼、易惊、食欲减退、多汗（头部尤其多汗），患儿头部常在枕头上摇擦，常发生枕部一圈脱发。颅骨软化，呈方颅，骨缝、囟门过期不合，出牙较迟，鸡胸，膝外翻（O型腿）或膝内翻（X型腿），脊柱后弯或侧弯。

佝偻病类似于祖国医学的五迟、五软、疳疾、解颅、鸡胸、龟背等病证。中医认为其发病原理主要由于脾肾不足所致。小儿处在生长发育阶段，生长机能相当旺盛，体内所需水谷精气的供养，相对比成人更为迫切，显出“脾常不足”的生理特点。脾胃为后天之本，若饮食失节，调护不当，易致脾胃受病。脾虚则气血生化无源，无以濡养肌肉，使形羸体弱，痿软乏力；心失所养，而致心气虚，则多汗，夜啼易惊。脾胃受病。诸脏失养，尤易及肾。小儿肾气未充，若脾胃虚损，生化之源枯竭，则肾气更虚。肾主骨，生髓，肾气不足，则筋骨不健，常致行迟、齿迟、解颅、鸡胸、龟背等骨骼发育不良之证。总之，佝偻病多属脾肾不足之证，治宜健脾补肾。

中医治疗佝偻病一般可分以下两个阶段：

1. 早期 肌肉松软，虚胖或消瘦，生长发育迟缓，纳呆或腹泻，神疲无力，多汗夜惊，烦躁不安，脉沉缓无力，舌质淡，苔白，指纹淡。治宜健脾补气，佐以消导。

党参6克，白术6克，扁豆6克，苡仁6克，砂仁1.5克，龙骨6克，牡蛎6克，山药6克，陈皮3克，麦芽3克，谷芽3克。服法：水煎服。

2. 晚期 胸廓畸形（鸡胸），脊柱偏曲，下肢呈O形或

X形，方颅，囟门逾期不合，牙齿逾期不出，或出不整齐，或夜间盗汗，肌肉松弛，毛发稀疏，有时出现抽搐，生长发育障碍。脉沉细无力，舌质红，苔白或无苔，指纹淡。治宜培元补肾、健脾益气。

方一：熟地6克，山萸6克，茯苓6克，丹皮3克，泽泻3克，淮牛膝3克，山药6克，鹿角霜6克，生龙骨10克，生牡蛎10克，水煎服。

方二：党参10克，黄芪10克，炒麦芽6克，山楂10克，山药10克，生龙骨10克，生牡蛎10克，鸡内金6克，鹿角霜6克。水煎服（适用于佝偻病脾胃虚弱，食纳差的患者）。

方三：琥珀抱龙丸（成药，用于佝偻病出现神经系统症状，如抽搐等）。

治疗佝偻病的单方验方：

1. 六味地黄丸，，每次服1.5~3克，每日服2次。

2. 龙骨，牡蛎各10克，水煎服。配用针灸，主穴：大椎、内关、足三里。

3. 炙黄精10克，龙骨10克，牡蛎10克，白术10，茯苓10克，山药10克，浮小麦10克，黄芪10克，鹿角霜10克，当归6克，桂枝6克，白芍6克，炙甘草3克，大枣3枚。上药煮沸过滤浓缩成浸膏粉，加蜜为丸，每丸重5克，1岁以下每次服1丸，2~7岁每次服2~3丸。每日服3次，需长期服才能见效。

4. 苡仁10克，芡实10克，莲米10克，淮山10克，茯苓10克，砂仁3克，甘草3克，白术6克，党参10克，陈皮6克，银紫胡6克，台乌6克。上方制成糖浆100毫升，每日服3次，1岁

以下分3日服完，1~3岁分2日服完。3~7岁1日服完。应长期服用。

佝偻病的预防：

做好孕妇及乳母的保健，注意小儿体格锻炼，逐步适当地到户外晒太阳，加强婴幼儿的护理与合理喂养，并及时添加辅食，如健补饼干之类（健补饼干成份：面粉、奶粉、钙粉、黄豆粉、炒山药、炒麦芽、党参、白糖等）。

59. 小儿屏气发作综合征

小儿屏气发作综合征，又称幼婴吞气症，多发生于出生后20天至一周岁左右的乳幼儿，是由啼哭、吃奶、咳嗽、惊恐等原因所引起的短暂性晕厥和伴发面唇肢端青紫或手足搐搦等症。患儿在吮乳中，突然中断吮乳，躁动不安，以后可发展成为阵发性两手握拳，两臂屈曲（或伸直），两腿伸直，角弓反张，全身用力，面红耳赤，或躁动不安，哭闹不停，或出现短暂的晕厥，或在睡中突然尖叫，头向后仰，转辗不安，面色苍白或青紫，满额大汗，手脚发凉，吐奶不止，腹鸣响亮，放屁频频，放屁后腹痛稍缓解，但不久症状又可复发。患儿大便多为正常，但亦有硬便或水渣分开之大便，放屁时可排出少量粪便，因放屁不停，故一日排便多次，但不是腹泻。检查只见腹部轻度膨胀，无肿块，无压痛，听诊肠鸣音亢进，少数病人可见腹静脉显露，或频频呕吐，脱水，甚至休克。

现代医学对本病的发病机理尚不清楚。

小儿屏气发作综合征，根据其临床表现，似属祖国医学的“薄厥”或“气厥”范畴。阳气卒亢，血随气逆，郁积于头部而发生短暂的卒然昏厥。属气滞血瘀，治宜活血行气，滋阴柔肝，安神。

方一：陈皮3克，桔梗6克，生姜3克，砂仁1.5克，木香3克，甘草1.5克。水煎服。

方二：丹参6克，赤芍3克，川芎3克，菖蒲3克，地龙3克，珍珠母10克。水煎服。

方三：合欢皮10克，陈皮3克，瓦楞子6克，焦山楂6克，鸡内金3克，丹参6克，香附3克。水煎服。

小儿屏气发作综合征的预防：竖抱小儿吸乳，平时也竖抱小儿。

60. 女童性早熟症

女童性早熟是指女孩在10岁以前出现性早熟现象，这种病往往找不到原因，许多患儿脑电图有异常，提示中枢神经系统特别是下丘脑功能障碍，使垂体提前活动，卵泡提早成熟。此病往往给家长及患儿带来不良的心理影响。患儿后期生长发育常落后于正常人。

女童性早熟症的表现：女孩在10岁以前，出现双侧乳房增大，外阴有分泌物，有的月经来潮，有的阴唇肥大，色素沉着。患儿夜寐不安，易怒，自感乳房发胀，触痛，扪之有硬结。阴道涂片角化细胞及伊红指数明显增高，24小时尿雌激素高于正常幼女水平。

祖国医学无“女童性早熟症”的病名。中医认为肾的精

气对人体生长、发育、生殖等方面均有重要作用，小儿“稚阴稚阳之体”，易出现阴阳平衡失调。肾阴亏损所致的相火偏旺，可表现为性机能亢进。又因乳房及外阴部与足厥阴肝经有关，故治宜疏肝解郁，滋阴泻火。

处方：龙胆草4.5克，知母10克，黄柏10克，生地10克，茯苓10克，泽泻10克，丹皮10克，夏枯草10克，炙龟版10克。水煎服。

加减：乳房压痛加没药、柴胡各10克，阴道流血加旱莲草15克，阴道有分泌物可将龙胆草加至10克。

外科·皮肤科

61. 急性腰扭伤

急性腰扭伤是常见的软组织损伤。软组织可因活动时姿势不正，用力不当，如过度负重、剧烈运动、弯腰取物等或外力撞击而损伤。腰肌扭伤后一侧或两侧当即发生疼痛，有的也可以在受伤后半天或隔夜才出现疼痛，腰部活动受限，静止时疼痛较轻，活动或咳嗽、喷嚏时掣痛较甚。检查时局部肌肉紧张，压痛及牵伸痛明显，但多无瘀肿现象。若为挫伤，则局部可见青紫肿胀的瘀肿。

急性腰扭伤，中医称“闪腰岔气”。中医认为“腰者，一身之要，俯仰转侧无不由之”。若劳动用力不当，拾物过重，或因撞击、坠下、重压等原因，伤及腰脊，以致经络受阻，气血不运，而成闪腰。治宜行气活血，祛瘀通络。

方一：鲜土鳖虫8~15只（大的8只，小的15只），用温开水洗净，在小碗内捣烂，绞汁去渣，取汁用白酒冲服，每日1~2次，一般服1~3次见效。无鲜土鳖虫，可用干土鳖虫，用量减半，研粉冲酒服亦可。

方二：取新鲜生姜，将生姜内层挖空，把研细的雄黄放入生姜内，上面用生姜片盖紧，放瓦上焙干，把生姜焙成老黄色，放冷，研细末，即成“姜黄散”，贮于玻璃管内，用

时把“姜黄散”撒在普通黑膏药上或伤湿止痛膏上，贴患处。

方三：川椒、食盐各30克，泡入白酒250毫升中（泡愈久愈好），擦腰部，再用掌根揉擦腰部。并对昆仑、复溜、承山、委中，腰俞、命门、肾俞等穴位作由上而下、再由下而上的顺序按摩。

方四：生大黄60克，葱白头5根，生姜适量。将大黄研成细粉，调入生姜汁半小杯，加开水适量，使成糊状备用。用时，将葱白头捣烂炒热，用布包好，在痛处揉擦至局部皮肤发红，觉烧灼感为止，然后以上药1/4敷患处，盖以纱布或厚纸，每日1次。

方五：川芎18克，制乳香18克，制没药18克，桃仁18克，红花18克，土鳖虫18克，公丁香18克，当归24克，肉桂24克，血竭24克，广木香24克，制川乌30克，制草乌30克。共研细末，水泛为丸，成人每次服3~6克，15岁以下每次服1.5克~3克，每日服2次。

方六：栀子4份，乳香2份，黄连1份，细辛1份，三七1份，樟脑1份。将上药分别碾细后混合，装瓶密封。用时，洗净患部，药粉加食醋调成糊状，敷于患处，盖上油纸，纱布包裹，胶布固定。药干后再换。或将干药块取下再用醋调，重新敷上。

方七：生川乌15克，生草乌15克，生南星15克，生半夏15克，红花10克，土鳖10克，大黄10克，栀子10克，姜黄10克，乳香10克，没药10克。共研成粗末，用时将白酒拌药末，共入瓦锅炒至微黄，用布包好乘热熨患处，熨至药凉后再放回锅内加白酒少许炒热布包外熨，反复应用，每日数次。

至数十次，以不烫伤皮肤为度。1小包药末可用2天。

方八：红花15克，赤芍15克，白芷15克，栀子15克，桃仁15克，乳香15克，没药15克，大黄30克，共研细末，用酒调成糊状，外敷患处。如干后，可取下再加酒调敷，连续敷用4次去除。若尚未治愈，可用第二剂重新调敷。皮肤有破损者勿用。

方九：取天柱穴。患者端坐垂首，医生用左手拇食二指在双侧天柱穴上稍作点按，常规消毒后，右手将针迅速刺进两穴各0.5~1.0寸深，不做提插、捻转手法，留针10~15分钟。

62. 慢性腰背痛

慢性腰背痛是劳动人民的常见病。慢性腰背痛的原因很多，多由于腰背部软组织慢性劳损而引起，如急性腰扭伤未完全治愈，反复受伤，肌肉长期受牵伸紧张等，肥大性脊柱炎、脊椎移位、隐性脊柱裂等病变以及风湿病等，都常有慢性腰背痛。

临床表现：腰部经常酸痛，时轻时重，有时可扩散到整个腰背部或臀部、大腿部。疼痛常在受冷、阴雨时加重，活动后可减轻，静止较久自觉僵硬，但疲劳后又复加重。检查时，局部腰肌可有痉挛，并有压痛。如属脊椎骨骼病变，通过X线照片可以确诊，如属风湿性者，血沉可加快，抗“O”可增高。

祖国医学认为“腰为肾之府”，大多数慢性腰痛患者都与肾虚有关。由于肾虚，寒湿之邪亦每易乘隙入侵，痹阻经

络，以致气血运行失调。治宜补肾活络，理气止痛。

方一：络石藤30克，鸡血藤30克，寄生30克，补骨脂12克，狗脊20克，续断20克，巴戟12克，菟丝子12克，仙灵脾30克，乳香10克，没药10克（本方适用于慢性腰肌劳损）。水煎服。

方二：羌活12克，独活12克，海风藤30克，桑枝30克，川牛膝12克，当归12克，杜仲15克，黄芪30克，续断20克，制川乌10克（先熬），制草乌10克（先熬），千年健30克（本方适用于风湿腰痛）。水煎服。

慢性腰背痛患者，平时要加强腰部的功能活动，从事适当的体育锻炼，补肾药物亦可常服。

治疗慢性腰背痛的验方：

①苡仁120克，制首乌180克。共浸于白酒中，蜡封瓶口，置阴凉处15天。去渣备用。每日早晚各服一次，每次服20毫升。

②地龙10克，苏木10克，桃仁10克，麻黄6克，肉桂6克，黄柏6克，当归12克，甘草6克。水煎服，每日1剂，饭前服。

③补骨脂12克，骨碎补12克，续断30克，寄生30克，狗脊30克，茜草12克，赤芍30克。水煎服，每日1剂。

④葛根60克，川牛膝30克，杜仲30克，茯苓30克，肉桂6克，陈皮10克。续断30克，狗脊30克。水煎服，每日1剂。

⑤骨碎补50克，威灵仙20克，杜仲20克，鸡血藤50克，红花20克，当归20克，白芷20克，共研细末，用酒调敷患处，外盖纱布，再在纱布上加热水袋热熨，每次2小时，每日1次。

⑥干姜10克，川牛膝30克，白芷12克，台乌12克，陈皮10克，麻黄10克，僵蚕10克，甘草6克，葱白3枚，乳香10克，没药10克，水煎服，每日1剂。腰痛剧者加续断30克，补骨脂15克，杜仲15克。遇冷痛剧者加肉桂5克，下肢疼痛兼麻木者加桂枝15克，丝瓜络15克。湿重加威灵仙10克，木瓜30克，苡仁30克。

63. 化脓性指头炎

化脓性指头炎是手指的急性化脓性感染的一种。它的起因往往是指尖部的一些轻微损伤，如针、木刺的刺伤，割伤，擦伤等。

手指末节与中节之间有一层纤维组织所形成的间隔，两者互不交通，因此末节手指成为一个密闭的空隙。在这空隙中有很多致密的纤维组织和脂肪组织。这一空隙不能忍受大容积的改变，因此当指端发生炎症且肿胀时，密闭腔隙内的压力增高而发生剧烈的疼痛，犹如鸡啄，常使病人整夜不能入睡。除了肿痛以外，指尖部还有红、热等表现，病人还可有发热等全身症状。

化脓性指头炎，中医称之为“蛇头疔”，由外感火毒所致。治宜清火，解毒，拔脓。

方一：蚤休30克，紫花地丁30克，蒲公英30克，野菊花20克，银花20克，连翘20克，赤芍13克。水煎服。

方二：蜈蚣一条，焙干研末，松香18克，研末，混匀，倒入盛有开水的缸中，粉末在热水中即自然溶成胶状，粘结成团。从水中取出胶状粘团，趁热用手捏塑成指套的形状，

套在患指上，冷却后固定成型，即为“蜈蚣套”。指套的长短粗细依患指而定。蜈蚣及松香的用量，可依患指大小，按比例增减。已形成脓肿尚未破溃者，套上蜈蚣套后少则三天，多则六天，可自行破溃，拔出脓汁。破溃前，每日取下指套一次，将患指用温开水洗净。脓肿破溃或已切开引流者，以及早期化脓性骨髓炎，每日早晚两次取下指套，用温开水或生理盐水将患指及指套内的脓液洗净，10~20日可愈。

方三：新鲜猪胆套敷患指。

64. 甲沟炎

甲沟炎是手指甲周围组织的化脓性炎症。发病原因往往是指甲附近组织的轻微损伤，如刺伤，撕剥肉刺、剪指甲时损伤软组织等等。初起时，自觉症状往往只是指甲的一侧有轻度疼痛、红肿和发热。如不及时治疗，可蔓延到指甲的周围（指甲周围炎）和甲下（甲下脓肿）。

甲沟炎，中医称之为“沿爪疔”、“蛇眼疔”，由外感火毒所致。治宜清火解毒。

方一：蜈蚣一条，雄黄1.5克，枯矾1.5克，共研成极细粉末，取一个新鲜鸡蛋，将蛋的一端打破，约如患指的大小，然后将破碎的蛋壳适当的剥掉，从鸡蛋的破孔处倾出一部分蛋液（蛋内容），其量以放入药后，患指插入蛋壳内，蛋内容不致溢出为度。将药粉从蛋孔倒入蛋内，将药粉与蛋内容搅拌均匀，然后将患指插入蛋内，用小火焰沿着蛋壳围烘一小时以上。烘烤以患指有温热感为度，轮转烘烤。以上的操作方法，可根据患指损害的轻重，每日进行1~2次。烘治

完后，用干净纱布包扎即可。

方二：鲜半枝莲、血当归（又名菊叶三七、土三七）、土牛膝、五爪龙各适量，加甜酒药曲一粒，混合捣碎外敷患处，每日早晚各换药一次。

方三：六月雪（茜草科六月雪属植物，又名白马骨、满天星）25~50克，斑蝥5克，水煎，待温外洗患处，日洗4~6次，重用时加温即可。每日一剂。已化脓者，应切开引流后再用此药。

此药外用无副作用。

65. 化脓性骨髓炎

化脓性骨髓炎是指一些化脓性细菌侵入骨髓而引起的炎症反应（化脓性细菌常见的有金黄色葡萄球菌、链球菌和大肠杆菌等）。但骨髓炎不是单纯的骨髓腔发炎，而是包括骨和骨膜整个骨组织发炎。

化脓性骨髓炎的发生，一方面由于病菌侵入机体，而更重要的一方面是人体全身或局部骨组织抗病力降低，使入侵的病菌得以生存繁殖，而引起骨组织发炎。如病人患有扁桃腺炎、中耳炎、疖、痈等疾病，而又身体衰弱、营养较差、过度疲劳时，则感染性病灶内的细菌可进入血液，经血流侵入骨内，引起骨脓肿。象其他软组织脓肿一样，骨脓肿也要向外扩展，所以很快蔓延到骨外和骨里（骨髓腔），结果骨的里里外外都是脓。骨的血管如果发生栓塞，骨质营养断绝就逐渐变成“死骨”。骨里外的脓越积越多，终于穿破皮肤而形成不容易收口的瘘管。此外，死骨的外面会产生许多新

骨，把死骨包围起来，这层新骨叫做“包壳”，包壳又为细菌侵袭破坏而形成许多洞孔，瘻管里的脓就是从这些洞孔里流出来的。因为洞孔小，里面的脓不容易流尽，所以疮口经常流脓。有时脓少暂不外流，于是疮口就暂时收口，但不多几天脓又积聚起来，原疮口又破溃流脓，这样反复发作，可多年不愈。少数病人的疮口中会落出象被虫蛀过的死骨片来，如果死骨小而少，随脓液逐渐排尽，那末疮口就有永久收口的希望，但是大死骨很难自动排出，疮口也就不可能自然闭合。

在死骨未形成的阶段，通常称为急性期；死骨形成以后，则称为慢性期。

急性期病人往往有寒战怕冷，接着就发高热（ $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ ），起病后24小时，有病部位（上肢或下肢）开始疼痛，不愿别人碰摸患处。检查时可发现有病部位的骨骼有明显的压痛。靠近关节的骨髓常先起病。

慢性期的主要表现是瘻管流脓，经久不愈。

化脓性骨髓炎属于祖国医学的“附骨疽”范畴。中医认为多因疔、疖、痈之热毒未清，或跌打损伤感受毒邪，“火毒”侵入营血，深窜入里，留滞筋骨所致。火毒入骨，壅遏不行，热胜则肉腐，肉腐则为脓，蕴脓腐骨，其余毒潜伏，虽疮已敛，但仍反复发作。“火毒”始终是“附骨疽”的主要矛盾。其治疗，宜清热，泻火，解毒，活血，托脓。

一、急性期治疗

处方：银花30克，蒲公英30克，紫花地丁30克，野菊花20克，半边莲30克，蚤休30克，生地30克，当归13克，赤芍12克，黄连10克，山栀10克。水煎服。

加減：熱甚者加生石膏30克、知母10克、大青葉30克、白花蛇舌草30克。口渴加花粉30克。便秘加生大黃10克（后下）。痛甚加乳香10克、沒藥10克。化膿時加炮甲珠15克、皂刺10克、黃芪30克。

急性期的治療，劑量要大，每日一劑，堅持服藥，力求在短期內控制病變的進展，必要時作中西醫結合治療，以免演變成慢性骨髓炎。

二、慢性期治療

方一：黃芪30克，黨參30克，熟地20克，黃精20克，當歸15克，銀花30克，蒲公英30克，紫花地丁30克，白芷10克，炮甲珠15克，桔梗10克。水煎服。

方二：銀柴胡12克，青蒿12克，秦艽15克，鱉甲30克，地骨皮15克，當歸15克，三七6克，人參葉30克，紅花10克，全蝎6克，蜈蚣2條。水煎服。

方三：白毛夏枯草（鮮草）、天名精（鮮草）各60克，以一半煎水內服，一半搗敷患處（鶴虱為天名精的果實，天名精為鶴虱的全草）。

方四（外用）：白砒45克，明礬90克，雄黃7.5克，焙干蜚蠊6克。

制法：先將白砒、明礬共研細末，放入小瓦罐內，加炭火煅紅，待青煙已盡，迭起白煙時（上下紅透），停火，取罐放地上一夜，取出砒礬末（約有30~50克），再將雄黃、蜚蠊細末放入，共研成極細粉末，加適量面粉和水搓成細條，陰干貯存備用。

用法：將藥條插入瘻管，管口外貼玉紅膏（成藥）。此藥條插入瘻管后，能腐蝕肉芽，使瘻管孔道變大而光滑，便

于死骨排出。放药条前，应先用镊子探查死骨的纵行方向，如发现死骨与痿管孔道的方向不一致时，插药条应插在有阻力的地方，将其腐蚀，逐渐使死骨纵行方向与痿管孔道方向一致，以利于死骨自然排出（或用钳子取出）。

方五（外用）：儿茶15克，乳香10克，没药10克，血竭10克，三七15克，冰片3克，珍珠粉15克，共研成极细粉末，撒敷痿管内。此方用于死骨排出后，有生肌收口之功，在死骨未排出前，不可应用。

慢性骨髓炎的治疗，内治法与外治法必须同时应用，才能取得疗效。

66. 肛 裂

肛裂是肛管皮肤受损破裂，发生感染形成的慢性溃疡，反复发作，疼痛剧烈。肛管皮肤的破裂往往因粪便干硬所造成，开始时伤面浅而小，因肛管皮肤愈合的能力较强，一般尚可自愈。但有的病人，大便经常干硬，伤面得不到愈合，反复发生感染，形成肛裂。

肛裂的临床特点是：

1. 大便时感到肛门区如刀割样的剧烈疼痛，并在大便后持续数小时疼痛不止。因此，病员害怕解大便，而减少排便次数，于是粪便更为干结，大便时的疼痛也就进一步加剧。

2. 粪便上沾有血迹或有小量鲜血滴出。

3. 检查肛门区可见到肛门后方正中部有一个皮肤突出块物（由于肛裂伤面经常有炎性渗出物刺激皮肤所引起），叫做“前哨痔”，是肛裂的特有体征。

4.分开肛门可见到肛管后方正中有一个放射状的慢性溃疡。但这个检查方法会引起病人的剧痛，故在检查时要动作轻柔以减少病人的痛苦。一般不作肛门手指检查和肛门镜检查。

根据大便时和大便后的剧烈疼痛、出血，肛门区有“前哨痔”这些特点，诊断肛裂不难，并可与内痔或外痔相区别（内痔一般仅有出血而无疼痛，外痔一般不出血也不疼痛）。血栓性外痔虽也有皮肤肿块和疼痛，但无出血。肿块的形状也与“前哨痔”不同。

祖国医学认为，肛裂的病因病机多因血热肠燥，大便秘结，排便努挣，肛门损伤，引起破裂、疼痛、溃疡。《医宗金鉴》说：“肛门围绕，折纹破裂，便结者，火燥也”。肛裂初期，创口小，色鲜红，一般内治多用泻火、清热、滋阴通便等法，较易治愈。如病程延长，血热瘀滞加重，创面深大，则治宜清热、凉血、利湿。

方一：败酱草30克，槐花30克，车前草30克，半枝莲30克，首乌45克，侧柏叶15克，旱莲草30克。水煎服。每日一剂。

方二：白芨、煅石膏，比例为2:1，共研极细粉末，用凡士林、植物油调敷患处，每日一次，直至创面愈合。

方三：冰片、煅龙骨粉、朱砂各6克，煅石膏120克，煅炉甘石60克，共研极细粉末，用凡士林200克、植物油适量调成软膏，用探针挑软膏涂满肛裂面，然后用干棉球覆盖表面，借探针把部分干棉球推入肛内，最后用纱布盖于肛门口，胶布固定，上药后12小时暂不大便，次日排便后用败酱草、车前草各30克煎汤坐浴，再换药（敷软膏）。

肛裂的预防:

养成定时排便的良好习惯，多吃蔬菜，不使大便秘结。陈旧性肛裂患者，可作“摆长强”的体育疗法，配合治疗。具体方法是：两足站开，膝微屈，两手放在同侧的大腿上，指尖向内，将尾骶骨有节奏地向左、中、右来回摆动1~5分钟，每天早、中、晚各做一次。做此运动有肛门自动收缩和向上提的感觉。

67. 接触性皮炎

接触性皮炎是由于患者身体接触药物、塑料、橡胶、农药、煤馏油、原油等化学性物质，或电镀、日光，或漆、苎麻、花草的茎叶、昆虫、动物皮毛等生物性物质而发生的一种急性皮炎。

接触性皮炎也包括接触强酸、强碱或腐蚀性药物（水杨酸、石炭酸、碘、甲醛），直接损害人体的皮肤组织而发生。但是，这里所指的（也是临床上所常见到的）接触性皮炎主要是变态反应性皮炎，也就是由于人体对某些物质具有特殊的敏感性，当接触到这些刺激因子后，就在接触部位出现皮炎。例如有人在肩部贴了某种膏药如伤湿止痛膏，马上在肩部出现与伤湿止痛膏大小形状一致的、境界鲜明的水肿性红斑，间以丘疹、丘疱疹。这就是“接触性皮炎”。

接触性皮炎的特征是，在接触过敏性物质的部位出现边界清楚的皮损，表现为红肿、红斑、丘疹、水疱、大疱等，并伴有瘙痒或烧灼感。皮损的形态、范围和严重程度与刺激

物的性质、浓度、作用时间长短和机体的反应性等有密切的关系。如刺激物致敏性很强或患者处于高度的敏感状态，则皮炎可由局部扩散到身体其他部位，甚至泛发全身。接触性皮炎有的病变复杂，可演变成慢性，皮肤粗厚，有人叫湿疹样皮炎，应注意与湿疹鉴别。

接触性皮炎，分别类似于中医的“漆疮”、“日晒疮”、“药毒”、“膏药风”、“马桶癣”等，认为是由风热或湿热毒邪侵犯肌肤，导致血热所致。接触性皮炎的治疗，首先要寻找病因，并设法及早去除刺激因素。中药的治疗原则是清热解毒、凉血消风。

方一：蒲公英30克，黄芩10克，银花15克，连翘12克，车前草30克，苡仁30克，茯苓皮20克，生地12克，丹皮12克。水煎服。

方二：荆芥12克，防风12克，紫草30克，菊花20克，苦参30克，山栀10克，牛蒡子15克。水煎服。

方三：升麻30克，牛蒡子15克，黄连10克，生石膏30克，知母10克，玄参20克，地肤子15克，蝉衣10克，丹皮12克，生地30克。水煎服。

方四：麻黄20克，紫花地丁20克，甘草20克。

用法：煎水外洗患处。适用于漆性皮炎。

接触性皮炎的预防：

加强皮肤的保护和锻炼，以增强皮肤对外界刺激的抵抗力。

68. 尿布皮炎

尿布皮炎是婴儿在尿布遮盖部位发生的潮红和湿烂现象，俗称“红屁股”，又叫做“婴儿臀部红斑”。

婴儿的皮肤既薄又嫩，如不及时的更换被尿、粪浸湿了的尿布，湿热的尿、粪以及粪中的细菌将尿中的尿素分解而产生的氨类就可刺激和淹渍皮肤，引起皮炎。如在尿布外面再裹上一层塑料布，更不透气，更容易发生皮炎。尿布太粗糙，尿布上的涂料，残留在尿布上的没有漂洗干净的肥皂，潮湿结了块的爽身粉等均可促使尿布皮炎的发生。

尿布皮炎仅见于婴儿，在尿布覆盖部位如下腹、股内侧、外生殖器（女婴大阴唇有时有明显水肿）、会阴及臀部等发生大片红斑，其大小与尿布遮盖的皮肤是一致的，边缘清楚，用手指按压，红色易于消退。有时表面有少许丘疹；严重时可发展成为水疱，水疱擦破后形成糜烂面；也有形成浅溃疡或继发感染而发生脓疱者，此时患儿有吵闹不安及发热等全身症状。

中医称尿布皮炎为“湮尻疮”、“猴子疳”，认为是由于婴儿皮肤娇嫩，湿热蕴结皮肤所致。治宜清热燥湿。

方一：芙蓉叶30克，黄连10克，滑石粉30克，共研细粉，扑撒患处（适用于未溃烂者）。

方二：生地榆10克，紫草10克，冰片1克，共入植物油中炸黄，去渣，冷却后涂患处（适用于已溃烂者）。

尿布皮炎的预防：

- 1.勤换尿布，保持臀部清洁干燥。
- 2.尿布最好用薄而软的白色旧布做，不要用新布，新布不吸水，而且没有旧布柔软。
- 3.尿布不需要用消毒药水或药皂洗，用点肥皂就可以了。洗时要用清水将肥皂水和污物漂洗干净。
- 4.尿布外面不要再裹塑料布，尿布湿了就要及时更换。

69. 脓 疱 疮

脓疱疮，俗称黄水疮，是一种由于化脓细菌感染所引起的急性化脓性皮肤病。

脓疱疮多见于夏秋多雨季节，儿童特别是学龄前儿童很容易得这种病。特别是当病人体质较差，机体抵抗力减低或患有痱子、湿疹、荨麻疹等瘙痒性皮肤病，或皮肤破损时，金黄色葡萄球菌或溶血性链球菌容易侵入皮肤引起感染而发生脓疱疮。

这种病的潜伏期短，发病快。最初可见于皮肤的外露部位，如口的四周及面颊部，其次是耳前后、手、脚等处。开始时局部皮肤微红呈小片红斑，不久于其上出现浅而内容充盈的小水疱，清澈透明，有如荷叶上的小水珠一样。但很快变为浑浊或成为脓疱，四周绕以红色晕环。脓疱可迅速扩大，可达一厘米左右。躯干部散在的脓疱，疱壁薄而松弛，脓液呈半月状沉积。脓疱常因搔抓而使附近及其他部位的皮肤被感染而生新水疱。脓疱糜烂面的渗液1~2天后会逐渐减少，可结成蜜黄色痂或黄绿色的脓痂，因搔抓出血也可结成含有血液的混合痂，数日后脱痂而愈，不留瘢痕。脓疱常数

个或数十个散在或成堆分布，常此愈彼出，迁延数周或更久。

这种病的主要感觉是瘙痒，如果皮疹数目较多或致病菌毒力较强时，也可有疲倦无力、食欲不振或低烧等不适。假如发生局部淋巴结炎、淋巴管炎或软组织感染时，也可有局部红肿及发烧等情况。有一部分迁延日久未能治愈的患儿也可并发急性肾炎。

脓疱疮，祖国医学称为“天疱疮”、“脓窝疮”、“黄水疱”。认为由于湿热毒邪蕴结肌肤而成，治宜清热，解毒，燥湿。

脓疱疮皮疹较少的可采用药物局部治疗。

方一：新鲜丝瓜叶捣汁外敷。

方二：青黛、黄柏、黄连各15克，研细粉，调植物油外涂患处。

病情较重、脓疱疮泛发全身，或此愈彼出，必须内服中药治疗。

内服药处方：野菊花20克，紫花地丁20克，蒲公英20克，银花藤20克，夏枯草20克，赤芍10克，黄芩10克，丹皮10克，水煎服，每日一剂。

本病具有传染性，病人应隔离。

治疗脓疱疮的验方：

①大黄、生甘草、枯矾各适量，分别研成细末。再按3:1:1比例用植物油调成糊状，敷于患处。敷药前必须用淡盐水将患处洗净。每日换药1次。

②薄荷15克，青黛10克，黄柏12克，冰片3克，人中白10克，黄连10克，硼砂10克。分别研成细末，混匀。用时，

把药粉用植物油调成糊状，患处先用75%酒精消毒，再敷药，外盖消毒纱布，每日换药1次。

③青黛15克，生大黄15克，枯矾12克，冰片2克。分别研成极细末，混匀，加麻油调成糊状，外敷患处。敷药前必须先用消毒注射器抽出黄水，使黄水流尽，再用消毒棉球将周围皮肤消毒，然后再涂药膏，每日3次。

④松香6克，白矾6克，铜绿6克。将上药装入葱叶内扎口，水煎待药溶化，取出葱叶晒干（瓦上文火焙干亦可），加冰片少许共研细末，疮未溃者，麻油调涂患处。疮已溃破流脓水者，药粉干撒，每日1次。

⑤苦参30克，蛇床子30克，苍术15克，黄柏15克，川椒15克，轻粉0.5克。红疹期加蝉衣10克。水煎3次，趁热熏洗患处，每次洗10分钟，每日熏洗3次。

⑥枯矾、白芷、蛇床子各等量。先将蛇床子、白芷用文火炒黄，再加枯矾共研成细末。如见黄水糜烂者，直接用此药撒于疮面。结痂者用药末调麻油敷患处，每日涂1~2次。

⑦黄柏、枯矾、百草霜各等量。分别研末，混匀。先将患处用淡盐水洗净，用麻油将药末调成糊状，涂患处。每日涂3~4次。

脓疱疮的预防：

首要的是注意卫生，勤洗澡，勤换衣，常剪指甲，经常保持皮肤清洁，特别要避免与患者接触。一旦染上脓疱疮，要内治（内服方见上，剂量宜大）外治并重，收效较快。单纯外治不能根治。

70. 硬 皮 病

硬皮病是一种比较难治的皮下组织发炎、纤维组织增生的结缔组织疾病，是一种慢性病（只有少数病人是急性发病）。病变分为浮肿期、硬化期及萎缩期三个阶段，临床上分为系统性硬皮病及局限性硬皮病两种。系统性硬皮病除皮损外，还可以累及内脏器官。目前多认为硬皮病是感染诱发的一种自体免疫病。有一部分硬皮病往往发生在咽峡炎、猩红热和肺炎以后，有些病例常伴有感染病灶，如扁桃体炎等。

局限性硬皮病的临床表现，除皮肤硬化之外，没有全身症状，治疗比较容易，但亦可由局限性硬皮病转化为系统性硬皮病，因此不可大意，要抓紧治疗。

系统性硬皮病，在起病前多有指端动脉痉挛现象，表现为间歇性指（趾）苍白、青紫，常伴有疼痛。皮损常先发于四肢远端和面部。

系统性硬皮病的病变往往侵犯全身，皮肤纤维组织、肺脏、消化道等都可以发生硬皮病，同时伴有不同程度中毒症状，如低烧、全身乏力、纳呆、咳嗽、气短、恶心、呕吐、便秘等，血沉增快，皮肤呈褐色或黑白相间。肾硬变时可发生尿毒症，心脏受损可出现心力衰竭。硬皮病急性发病者多累及脏腑，预后较差。慢性病人多表现为皮肤症状，虽迁延难愈，但预后较好。

祖国医学无硬皮病的名称，中医文献中关于“人发寒热不止，经数日后，四肢坚如石，以物击之似钟磬，日渐瘦

恶，……”的记载，颇与现代医学硬皮病的症状相似。

中医认为硬皮病的病因与肾阳虚有关，患者常有腰酸，足跟痛，脱发，齿松动，耳鸣，畏寒，肢冷，自汗，便溏，性机能障碍，女性月经紊乱等见证。由于肾阳虚弱，卫外不固，腠理不密，寒邪乘虚外侵，凝结于腠理，进而阻滞经络，痹阻不通，导致营卫不和、腠理失养而发生本病。病情迁延日久，累及诸脏，致使脏腑功能失调，加重皮肤病变。

中医治疗硬皮病，以活血化瘀、温补肾阳为主要治疗原则。

1. 浮肿期 皮肤呈实质性水肿，颜色为正常皮色或苍白色。此期约为时数周。患者多有腰酸、畏寒、肢冷等肾阳虚的表现，舌淡，脉细缓。治宜温补肾阳。

处方：制附片20克（先熬），太子参15克，鹿角霜10克，威灵仙10克，仙灵脾30克，寄生30克，丝瓜络10克，当归10克，鸡血藤30克，桂枝10克，苡仁30克。水煎服。

2. 硬化期 皮肤发硬光滑，呈蜡样，颜色亦随即加深，呈棕色或棕褐色，有时夹杂减色斑点。发硬的皮肤不易折皱或捏起。严重时，皮下组织及肌肉均发生萎缩及硬化，紧贴于骨骼，形成木板样硬片。因而患者活动大受限制，如面部缺乏表情、开口困难、胸廓运动受限制、关节强直等。有时指（趾）端由于皮肤硬化、血液供应减少而产生营养性溃疡。硬化期可迁延数月甚至数年，然后逐步过渡到萎缩期。

硬化期治宜解肌化瘀，活血养血。

方一：丹参30克，鸡血藤30克，当归15克，郁金15克，生地30克，熟地30克，黄芪30克，桂枝10克，赤芍12克，红花10克，川芎10克，莪术15克。水煎服。

方二：荆芥10克，防风10克，柴胡10克，羌活12克，独活10克，乌梢蛇10克，地龙10克，全蝎6克，当归12克，黄芪30克，党参30克。水煎服。

方三：苡仁60克，当归12克，桂枝10克，昆布30克，海藻30克，红花10克，鳖甲15克，王不留行10克，赤芍10克。

服法：水煎服。同时用桑枝、桂枝、松节、赤芍各30克煎水热浸患处，每次浸泡20分钟，每日二次。

3. 萎缩期 皮肤变薄如羊皮纸样，并有出汗减少和毛发脱落现象。萎缩期治宜滋阴清热，活血化瘀。

处方：当归30克，元参30克，银花30克，郁金10克，泽兰10克，夏枯草30克，赤芍12克，紫草30克。水煎服。

除上述分期治疗外，对虚证明显者，可用十全大补丸（成药），瘀血证明显者可用桂枝茯苓丸加苡仁。阳虚证明显者用薏苡附子败酱散。肢冷明显者用当归四逆加吴茱萸生姜汤治疗。

治疗硬皮病的单方验方：

1. 黄药子半斤，加水煎熬，趁热熏洗患处。

2. 苦参30克，艾叶30克，蛇床子30克，地肤子60克，苍耳子30克，商陆30克，加水煎熬，洗患处，或蘸药液湿敷，每剂用2~3日。

3. 桃树枝、柳枝、桑枝、槐树枝、榆树枝各60克，乳香、没药、羌活、三七、千年健各15克，植物油750毫升烧热，入以上诸药，炸至焦黄，去药渣，趁热加入黄丹240克，冷却即成膏药，烤热后贴患处。

71. 眼、口、生殖器三联综合征

眼、口、生殖器三联综合征，又称白塞氏综合征。是以虹膜睫状体、口腔、生殖器部位反复发生疼痛性溃疡为特征的疾病。常伴有皮肤丘疹、坏死性结核样疹、结节性红斑、非特异性过敏反应，针刺后皮肤可出现丘疹或小脓疱。本病多见于皮肤科、口腔科、眼科、内科，而妇科多以女阴溃疡而就医。本病在临床上并非少见。本病反复发作小阴唇、阴道壁、子宫颈溃疡（男性患者可发生阴囊、龟头溃疡）。本病可反复发生口腔粘膜、舌、牙龈浅在溃疡或反复发作性的口腔口疮性口炎。反复发生眼部虹膜睫状体炎、角膜炎、疱性结膜炎。病情严重者，可引起青光眼、失明。本病多发生于青年妇女。发病原因不明。有人认为是某些因素诱发的一种自体免疫病。

本病还可侵犯关节及消化、神经、心血管系统，引起复杂的病情，容易误诊或漏诊。

眼、口、生殖器三联综合征与祖国医学的“狐惑病”相类似。《金匱要略》说：“蚀于喉为惑，蚀于阴为狐”。《医宗金鉴》说：“狐惑，牙疳下疳等疮之古名也”。下疳即狐也，蚀烂肛阴。《千金方》指出：“狐惑由温毒使然也”。综上所述，可见此病是热病后伤阴耗液，邪热内郁，瘀热久不去，上熏上注而为患。治宜滋阴清火，益胃生津，清热利湿。

方一：生石膏30克，山梔10克，胡黄连10克，银柴胡10克，羚羊角1.5克，牛蒡子15克，生地15克，麦冬15克，太

子参30克，山药30克，莪术15克，山甲15克，当归12克。水煎服。

方二：赤小豆30克，当归12克，升麻30克，土茯苓30克，犀角1.5克(可用水牛角30克代)，生地30克，白芍15克，丹皮10克，黄连10克。水煎服。

方三：百合50克，生地30克，石斛30克，沙参15克，黄连15克，细辛15克，玄参15克，银花30克，蒲公英30克。水煎服。

注：本方细辛与黄连同用，并重用细辛，治口舌生疮，疗效满意。

外用方：

1. 锡类散适量加珍珠粉或生肌散，调敷患处。
2. 外搽冰硼散油膏。
3. 青黛10克，冰片5克，共研极细粉末，撒敷外阴破溃处，每日一次（禁用于眼内）。

五官科

72. 急性结膜炎

结膜为一透明薄粘膜，附着于眼睑板后面的称睑结膜，覆盖于眼球前部的一段称球结膜，就是我们日常说的“白眼球”或“白睛”。

急性结膜炎是细菌性感染所引起的一种常见的急性流行性疾病，以结膜发红充血或粘液脓性分泌物（眼屎）增多为其特征，俗称“红眼”或“火眼”，儿童较成人多见，很容易传染，在春夏暖和的季节，托儿所、幼儿园和小学校等集体生活单位，如不注意卫生，共用洗脸盆、洗脸帕，或经常用手擦眼，使细菌有机会侵犯结膜，就会引起急性结膜炎的流行。

本病早期自觉眼内有异物感，不同程度地伴烧灼感，红肿，怕光流泪，不能睁眼，或有轻度疼痛等症状，以后逐渐出现球结膜浅层血管充血，肉眼可见血管增多而明显，为鲜红色或火红色，翻过眼皮看睑结膜也充血发红。小儿还可以见到眼泪或分泌物中有血水。早晨起床时分泌物常使上下眼皮和睫毛粘集在一起，严重的时候结膜水肿，球结膜可象水泡样隆起。

祖国医学称急性结膜炎为“暴风客热”或称“天行赤眼”，是感受风热邪毒所致。治宜疏风清热。

处方：连翘12克，牛蒡子12克，羌活10克，薄荷6克，酒大黄10克，赤芍12克，防风12克，当归尾10克，甘草6克，山梔仁10克，川芎6克。水煎服。

加减：湿偏重、眼睑缘湿烂者加苦参、白藓皮；热偏重、结膜充血较剧烈、眵多泪少、口苦、舌红苔黄的可用：天花粉10克，野菊花10克，黄芩10克，山梔10克，连翘10克，黄连6克，川芎6克，黄柏10克，薄荷3克。水煎服。

治疗急性结膜炎的单方验方：

1. 桑叶或菊花加水煎后倒入杯中或碗中，将患眼接近热气熏眼。冷却后将此水洗眼。
2. 蒲公英30克，加水煎，头汁服用，二汁熏洗患眼。
3. 龙胆草18克，研末分二天吞服，每次3克，每日三次。
4. 黄连上清丸（成药）成人每日服10~20克。

此外，有些患者，因为有怕光的症状，把患眼包扎起来，这样既使分泌物堆积，又影响眼球表面的蒸发作用，使结膜囊内的温度增高，有利于病菌的繁殖和生长，只能加重病情，因此，急性结膜炎是禁止包扎的。正确的方法是使患眼充分暴露，让分泌物排出通畅，白天可戴有色眼镜，以减少光线的刺激，睡前，眼睑涂上眼膏，防止眼屎封固影响蒸发作用。

预防：本病主要是通过接触传染的，因此，毛巾、手帕、洗脸盆不能共用，在急性结膜炎流行期间，每次洗脸以后，必须把毛巾、洗脸盆等用肥皂擦洗干净，托儿所、幼儿园等单位特别要注意做好卫生宣传，避免用手擦眼，发现“红眼”病人及时隔离。在症状完全消失后，还要用药治疗

几天，以防复发和再次传染给别人。

73. 麦粒肿

眼睑腺组织的一种急性化脓性炎症，通常称为麦粒肿，俗名“偷针眼”。根据被感染的腺组织的不同部位，有内外之分，如系睫毛毛囊所属的皮脂腺发生感染，称为外麦粒肿；如系睑板腺受累，则叫内麦粒肿。

外麦粒肿初起时作痒，睑局部呈现水肿和充血现象，有胀痛和压痛感，在近睑缘部位可触到硬结。以后硬结逐渐软化，在睫毛根部形成黄色脓疱。如果积脓穿破皮肤，向外溢出，红肿就迅速消退，疼痛也随之减轻。本病诊断不困难，一般说来，如用手指触按患区，只要发现局限的、范围清晰的痛觉敏感点或坚硬结节则肯定是麦粒肿。如炎症系由一个局限的腺组织扩展到其他腺组织时，则可形成多个脓点，除局部急剧的炎症反应外，还常伴有畏寒、发热等全身症状。

内麦粒肿：又名睑板腺炎，临床症状与外麦粒肿基本相同，惟疼痛较剧，但发展缓慢，不如外麦粒肿来得猛烈。在脓肿尚未穿破之前，睑结膜表面，常隐约露出黄色脓头，可能自行穿破。如睑板未能突破，细菌的毒素又较强烈，则炎症可以扩展，形成眼睑脓肿。

麦粒肿属于祖国医学的“土疳”、“土疡”范畴，病因多由风热相搏影响胞睑，或过食肥腻辛辣之品，脾胃蕴积热毒上攻，气血瘀滞所致。治宜疏风、清热、解毒。

方一：黄芩12克，白芷12克，当归12克，赤芍12克，栀子12克，桑白皮12，木通12克，桔梗12克，连翘12克。水煎

饭后服（本方适用于风热型麦粒肿患者）。

方二：薄荷叶、升麻、藿香叶、广陈皮、枳壳、炒山栀仁、黄芩、防风、生石膏各12克，甘草6克。水煎服（用于脾胃积热型）。

方三：黄芩、黄柏、金银花、生大黄、知母各等分。

用法：上药研成细末，用时加温水调成糊状，涂一层在纸上，贴于患处，有退肿消炎之功。

治疗麦粒肿的单方验方：

①蒲公英60克，野菊花15克，水煎服，每日一剂，头煎内服，二煎熏洗患处，每天数次。

②蛇蜕，放陈醋内泡数日，取出，剪成5×8毫米的块状，贴在麦粒肿病灶突出的中央部位，上盖浸有醋的棉片，外用胶布固定。24小时换一次，至痊愈为止。

③鸭跖草（又名竹节草、竹叶草、寒竹菜、水竹草）茎一枝（或一段）洗净，手持斜度为45°；放酒精灯上燃烧一端，即见下端有水泡沫液流出，随即将流出的液体滴涂于睑结膜及睑缘（麦粒肿之局部肿胀处及周围）、眼皮表面，反复数次滴入。每日滴2~3次。

如麦粒肿的脓尚未成熟时，一面服药，一面用热毛巾温敷患处，每次15分钟，每日3次，可促使其成熟。

74. 白 内 障

正常的晶体是透明的，如果它变成混浊而影响视力，就称为白内障。白内障又称内障，常见有三种，即老年性、先

天性及并发性白内障。

对白内障形成的机理，还不完全清楚，目前所了解的有硬化脱水学说、营养代谢学说、内分泌学说、紫外线与红外线的作用和遗传因素等几种说法。

白内障的诊断必须注意自觉和他觉两方面的症状，自觉症状有：早期眼前可出现固定不动的黑点，特别在光亮的背景下更为显著。此外还有视物弯曲、复视或单眼多视现象（可见二个甚至多个月亮），最后，眼睛只能辨别明暗，仅剩下有光的感觉。他觉症状：必须在暗室内使用直接灯光、放大镜、眼底镜聚光透照或裂隙灯进行检查。

1. 老年性白内障 年龄多在45岁以上，年龄愈大，发病率愈高。开始时视力逐渐减退，发展缓慢，用电筒照射瞳孔内有灰白色的混浊。

2. 先天性白内障 见于婴儿，生下来瞳孔内就有灰白色的混浊，一般不会继续发展。

3. 并发性白内障 广义的并发性白内障包括全身或眼部其它病变所引起的白内障。如虹膜睫状体炎、青光眼、糖尿病、眼外伤等，均常引起白内障。

白内障如已成熟，主要采用手术治疗，早期或某种原因不能手术者，可试用中医中药治疗，效果也比较好。

白内障属于祖国医学的“圆翳内障”、“银内障”等范畴，外伤性白内障叫“惊震内障”。历代文献根据其形态不同有冰翳、滑翳、浮翳、沉翳、枣花翳、黄心白翳等之称，其病机多是：肝肾两亏，脾胃虚弱或肝经风热上攻，以及神水受伤，睛珠混浊而致。

方一：菟丝子240克，楮实子240克，茺蔚子180克，枸

杞60克，前仁60克，木瓜6克，寒水石90克，河车粉90克，生三七15克，五味子60克。研末炼蜜为丸。

服法：每日空心服30克，温开水送下，此方减轻剂量水煎，冲服三七粉、河车粉亦可。

方二：石决明30克，草决明30克，赤芍15克，青箱子15克，羌活3克，山梔子15克，木贼15克，大黄6克，荆芥6克。

服法：为末服，每服10克，麦冬15克煎汤下。

方三：苍术15克，海藻15克，昆布15克，土茯苓15克。

服法：水煎服。加白糖适量，一剂分三次服，连服40天为一疗程。

方四：黑芝麻15克，桑叶10克，白芨12克，旱莲草12克，首乌12克，蒺藜18克，神曲12克，石决明12克。水煎服。

加减法：肝肾阴虚加女贞子30克、淮山12克；阴虚火旺去蒺藜加黄柏10克、知母12克、磁石30克；肝经风热去蒺藜加防风12克、玄参12克、黄芩12克；脾气虚弱去旱莲草、蒺藜加山药30克、党参15克、茯苓15克、白术12克。（本方用于老年性白内障）。

方五：黄芩10克，赤芍12克，当归10克，大血藤30克，白芨12克，麦冬12克，木通10克，珍珠母30克，蒺藜18克。水煎服，用于外伤性白内障，如属慢性期去黄芩，加红花10克、昆布10克、海藻10克。

中成药磁朱丸、珍珠层粉、石斛夜光丸和金匱肾气丸常服可以巩固疗效。

75. 急性化脓性中耳炎

急性化脓性中耳炎是中耳粘膜的急性化脓性疾病，好发于婴幼儿，常见致病菌有链球菌、葡萄球菌和肺炎球菌等。

导致本病的原因大致如下：

1. 上呼吸道急性炎症的蔓延扩散。
2. 某些急性传染病如猩红热、麻疹常可伴发本病。
3. 哺乳位置不对，如横抱婴儿哺乳，或平卧吸吮奶瓶，乳汁易经咽鼓管进入中耳。
4. 过度用力擤鼻，在不清洁的水中游泳或跳水，感染物经咽鼓管进入中耳。

急性化脓性中耳炎的临床表现一般可分为三期：

1. 初期 全身不适，恶寒发热，食欲减退，小儿可高烧，呕吐腹泻。耳痛剧烈，呈搏动性跳痛，听力明显减退。

2. 化脓期 在鼓膜穿孔前，发烧持续不退，耳聋或耳鸣，耳深部疼痛如刺似钻，甚至可引起半侧头痛，每在打喷嚏、吞咽、咳嗽时疼痛加重，婴幼儿则表现哭闹不安，或在吸奶时惊叫拒食；一旦鼓膜穿孔，即见脓液外流，体温多很快下降，耳痛也随之减轻或消失，全身情况明显好转，婴儿能安然入睡。如已见脓液外流仍高烧不退，耳痛不减，则有乳突炎的可能，必须提高警惕。

3. 恢复期 在化脓期如给予积极而适当的治疗，一般流脓可在7~10天内停止，鼓膜充血逐渐消退，穿孔愈合，听力也恢复正常。

祖国医学称急性化脓性中耳炎为“耳脓”，俗名“灌耳

聤” 。中医认为常因风火热毒上乘或肝胆湿热所致。治宜清热、除湿、解毒。

方一：柴胡15克，山梔子12克，牛蒡子10克，龙胆草30克，苦丁茶30克，黄芩12克，银花30克，薄荷10克（后下）。水煎服，每日一剂。

加减：流脓夹血者加鲜生地30克，丹皮12克。

方二：土茯苓15克，苡仁15克，龙胆草30克，梔子12克，柴胡12克，泽泻12克，木通12克，当归10克，生地30克，车前草15克，蒲公英20克，紫花地丁15克。水煎服，每日一剂。

治疗化脓性中耳炎的单方验方：

1.活田螺一个，洗净，清水静置2天后，挖开盖头，加入冰片少许，取水滴入耳内，一日三次，有止痛作用。

2.核桃适量熬油，将黄芩15克，黄柏15克，梔子15克入核桃油中炸焦，去渣，待冷，取油滴耳，一日三次，每次1~2滴。

3.鲜生地、鲜败酱草各等份。用清水反复洗净后捣烂取汁，装瓶备用。先将双氧水洗净耳内分泌物，然后滴入药液，每次2~3滴，每日2~3次。

4.大黄20，黄芩20克，黄连20克，黄柏20克，苦参30克。冰片末6克。麻油500毫升，先将前五味药泡入麻油中，浸泡24小时，然后加热将药炸成黑色，滤净药渣，放入冰片细末，搅匀，过滤，分装于眼药水瓶内（必须洗净）备用。每次滴1~2滴于耳内，每日1次。

5.蜈蚣一条，冰片3克，麻油30克。先将冰片研极细备

用。麻油放铁锅内烧开，把蜈蚣折成3段放油内炸至微黑色取出蜈蚣不用，将麻油放至温热未凉时投入冰片细末摇匀，使冰片粉溶解。装瓶备用。用时先将耳内脓液洗净，然后滴入药液，每次滴1~2滴，每日滴1~2次。

注意：治疗化脓性中耳炎，不能使用干药粉喷入耳内，这样不利于脓液引流，切切注意。

76. 慢性化脓性中耳炎

慢性化脓性中耳炎是中耳粘膜、骨膜甚至骨质的慢性化脓性炎症，是一种最常见而有时能危及生命的疾病。急性化脓性中耳炎如果发病后超过6个月仍持续流脓者，即已转为慢性。

慢性化脓性中耳炎的主要病因如下：

1. 急性化脓性中耳炎未得到适当而彻底的治疗，以致迁延成为慢性，这种原因，比较多见。

2. 为急性坏死性中耳炎的延续，多见于小儿猩红热、麻疹等传染病之后。

3. 上鼓室胆脂瘤，有时可不通过急性中耳炎阶段而进入慢性炎症阶段。

此外，鼻和咽部慢性病变的存在，也是一种致病因素。

慢性化脓性中耳炎的临床表现可分为三型：

1. 单纯型 此型最常见。特点是：分泌物呈粘液性或粘液性，一般无臭味，流脓多为持续性，脓量多少不一，常在上呼吸道感染时流脓增多。

2. 骨疡型 组织破坏较广泛，可累及骨质和听骨。其特

点是：分泌物呈脓性常有臭味，量一般较少。有时有头痛、眩晕等症状。

3.胆脂瘤型：分泌物较少，有特异恶臭。检查时可发现骨质破坏，如影响颅内则伴发危重症。

如有眩晕、呕吐、面瘫、剧烈头痛、寒战高烧等症状出现，则多为已有并发症。

骨疡型和胆脂瘤型病情危重，一般药物无效，必须争取早期手术清除病变，以防发生并发症。对于单纯型和轻度骨疡型病变者，可用中医药治疗。中医认为其病机多属肝肾阴虚，虚火上炎，气血郁滞。治则以滋阴降火，利湿排脓为主。

方一：熟地24克，山萸肉12克，山药12克，茯苓12克，丹皮10克，泽泻10克。水煎服，每日一剂。

加减法：虚火甚者加黄柏12克、知母12克；脓水多加花粉10克、旱莲草30克。如果长期流脓不止，精神倦怠者，可用托里排脓法：党参30克，黄芪30克，银花15克，当归10克，赤芍10克，玄参10克，车前仁10克，黄柏10克，知母10克，甘草3克，水煎服，每日一剂。

方二：诃子15克，白头翁15克，白芷15克，秦艽15克，穿山龙15克，生石膏30克，苡仁30克，银花10克，连翘10克，菊花10克，川连10克，甘草6克。水煎服，每日一剂。

77. 慢性单纯性鼻炎

慢性鼻炎是一种常见的鼻腔粘膜和粘膜下层的慢性炎症。通常包括慢性单纯性鼻炎和慢性肥厚性鼻炎两种。

慢性鼻炎是因为急性鼻炎反复发作，治疗不彻底，或因邻近扁桃体、鼻窦等器官的慢性炎症影响所致。许多全身性慢性疾病如贫血、糖尿病、风湿病、结核、慢性便秘等使鼻腔血管长期瘀血，或者长期滴用滴鼻净一类收缩血管的药液，均可导致本病。此外，慢性鼻炎的发生还与长期吸入被水泥、烟草、煤炭、化学因子污染的空气有一定关系，并与嗜好烟酒有关。

本病主要临床表现是鼻塞。如果白天、天热、劳动或运动时鼻塞减轻，而夜间、静坐或寒冷时鼻塞加重的称为间歇性鼻塞；有的鼻塞在侧卧时下侧鼻塞而上侧鼻通气好，当卧向另一侧时，鼻塞又出现在另一鼻腔，这就称为交替性鼻塞，慢性鼻炎具有以上两种鼻塞的特点。少数患者可因鼻塞而出现头痛头昏，说话时可呈闭塞性鼻音，或有嗅觉减退等症状，除鼻塞之外还有脓稠的鼻涕，脓液流入咽喉，往往表现为咳嗽痰多。如果是慢性肥厚性鼻炎，上述症状都比较明显而重，可见持续性的鼻塞不通，还伴有耳鸣、头昏痛、失眠、咽喉干燥等症状。

慢性鼻炎祖国医学称为“鼻塞”。由于外感风寒或风热，使肺气失宣，鼻窍不能通利所致。多以辛温宣肺或疏风清热、开鼻窍的方法治疗，常用方剂如下：

方一：苍耳子12克，辛荑12克，白芷12克，薄荷10克，（后下），桔梗10克，生甘草6克，夏枯草30克，枇杷叶15克。水煎服。

加减：鼻流黄涕属风热者加黄芩12克、桑白皮12克。

方二：苍耳子10克，辛荑10克，白芷10，藁本10克，藿香10克，淡竹叶10克，细辛6克，川芎10克，桔梗10克，黄芩

10克，连翘10克，生石膏30克，甘草6克。水煎服。

方三：苍耳子、辛荑花、黄柏等量捣碎。加植物油蒸熟，取油滴鼻。

方四：黄芩10克，苍耳子10克，鹅不食草10克，白芷10克，辛荑10克，薄荷6克，麻黄6克。

煎服法：加水煎成100毫升为一日量，分三次服用，小儿减半。

方五：薄荷10克，硼砂6克，檀香3克，冰片1.5克，研末吹入患侧鼻孔内，一日三次，此方对鼻涕多者效果较好。

预防慢性鼻炎的积极办法是锻炼身体，提高机体的抵抗能力，应注意饮食和生活环境的卫生，戒烟酒，如果患了急性鼻炎，要尽快根治，以免迁延日久成慢性。

78. 萎缩性鼻炎

萎缩性鼻炎是一种发展缓慢的常见鼻病，以鼻腔粘膜、骨膜甚至骨质发生萎缩及鼻内有脓痂形成为特点。

萎缩性鼻炎的病因还不十分清楚，一般认为本病分原发性和继发性两种。

原发性：可能为营养不良和全身疾病的一种局部表现，维生素A、B₂、E缺乏，钙代谢紊乱，内分泌失调均可引起本病，胶原性疾病也可伴发本病。随着人们生活条件与卫生习惯的改善，发病逐渐减少，病变程度也比较轻。

继发性：慢性化脓性鼻炎时脓性分泌物的长期刺激，以及高浓度粉尘和有害的化学气体经常刺激鼻粘膜，可引起萎缩性鼻炎。

临床表现：肉眼可见鼻腔宽大，粘膜干燥萎缩，病人经常感到鼻腔、鼻咽及口咽干燥不适。鼻塞或者嗅觉减退，闻不到香臭，鼻腔内结黄绿色脓痂，具特臭味，在脓痂脱落时，常可引起鼻出血和头痛头昏。如幼年发病者可见马鞍鼻或宽平鼻梁。

祖国医学称萎缩性鼻炎为“鼻藁”，俗名“臭鼻子”，是肺经有火或肺阴不足，阴虚火旺，鼻失濡养，血络受损所致。治宜清肺、养阴、润燥。

方一：麦冬15克，沙参15克，知母15克，生地30克，玉竹15克，丹皮10克，枇杷叶12克，生甘草6克。水煎服。

加减法：气血亏虚者加当归10克、党参20克、熟地30克、制首乌30克；鼻易出血者加栀子10克、侧柏炭10克；鼻臭严重者加鱼腥草30克、黄芩12克、生石膏30克。

方二：桑叶15克，沙参30克，生石膏30克，麦冬12克，石斛12克，阿胶（冲）12克，杏仁10克，麻仁15克，黄芩10克。水煎服，每日一剂。

治疗萎缩性鼻炎的单方验方：

1. 蜂蜜用棉花签蘸涂患侧鼻孔内，一日三次。
2. 麻油用平火熬炼，沸后15分钟，待冷却后装入清洁滴眼瓶内，滴患侧鼻孔内。
3. 菌灵芝30克，浓煎滴鼻。

预防：

积极治疗鼻窦炎，对儿童的鼻窦炎更应重视，注意锻炼身体，增强体质，改善环境及个人卫生。

79. 过敏性鼻炎

过敏性鼻炎是身体对某些过敏原敏感性增高而呈现以鼻粘膜病变为主的一种异常反应，临床症状以流清水样的鼻涕为主，可发生于任何年龄，但以青年人最多见。

过敏性鼻炎的病因有下列两类：

1. 过敏体质

病人可能有支气管哮喘、荨麻疹、血管神经性水肿等过敏性疾病病史，或有家族过敏史。

2. 接触过敏原

(1) 吸入物：如尘埃、花粉、动物羽毛或皮屑、真菌等，以及某些工、农业性粉尘如面粉、棉花、亚麻子、蓖麻子和谷粒所散发的细微粉尘被人们吸入而发生过敏。

(2) 食入物：一般儿童食物过敏比成人多见，生食物比熟食物更富于致敏性。如牛奶、鸡蛋、鱼虾、面粉、豆类。药物如磺胺、奎宁、抗菌素、阿斯匹林等皆可引致本病。

(3) 注射物：如血清、青霉素、链霉素。

(4) 接触物：如化妆品、肥皂粉、汽油、新鲜油漆、皮毛、氨水、酒精、碘酒、红汞等。

此外，本病还与内分泌失调或感染等因素有一定关系。

临床表现：

过敏性鼻炎发病之初即见阵发性鼻内奇痒，或伴有眼、咽喉、软腭、硬腭、面部、颈部等发痒，接着就连续打喷嚏。

嚏，多的时候可以一连打几十个喷嚏，同时流出大量水样的清鼻涕，有的患者也可能出现鼻塞、头痛、耳鸣、流泪、声嘶、咳嗽等症状。

中医称过敏性鼻炎为“鼻鼽”，由于肺虚卫气失固，抗御外邪的能力减弱，风寒乘虚侵入所致。常用治法是补肺固表、祛风散寒。

方一：生黄芪60克，防风12克，白术20克，桂枝10克，炒白芍15克，炙甘草3克，红枣15克，生姜三片。服法：水煎。每日一剂。

加减：初起风寒重加麻黄6克或北细辛3克；病久气虚甚，加党参30克，人参叶30克，诃子10克。

方二：辛夷、白芷、百部、牛蒡子、蒺藜、鱼腥草、地肤子、鹅不食草各160克，荆芥120克。

煎制法：加清水7000毫升，浸泡4~6小时，煮沸后文火煎1.5~2小时，加入薄荷70克，再煎半小时，过滤去渣，冷却，用生硼砂粉调节pH至8，加3%苯甲酸钠防腐，静置2~3天，取澄清液备用。每日滴鼻4~5次，每次2~3滴。

治疗过敏性鼻炎的单方验方：

1. 鹅不食草研末，用凡士林调匀，涂在纱布上塞进鼻内，每次放1小时半取出，亦可将药末作嗅剂用。

2. 蝉衣30克，研极细末，于发作后每次取1~1.5克，开水冲服，连服20天，有效可稍停再服。

80. 副鼻窦炎

副鼻窦包括上颌窦、筛窦、额窦和蝶窦，是鼻腔周围面

颅骨的含气空腔。副鼻窦炎是一种鼻窦粘膜炎症，分急性和慢性两类，病因基本相似，由于各窦解剖位置的关系，其中尤以上颌窦炎的发病率最高，而且慢性较急性多见。

副鼻窦炎的病因有：

1. 过度疲劳，受凉受湿，营养不良，维生素缺乏，生活环境不卫生，变态反应体质和内分泌失调等原因，使机体的抵抗能力下降而发病。

2. 某些急性传染病如上呼吸道感染、流行性感冒、麻疹、猩红热、白喉等均可诱发本病。

3. 鼻中隔偏曲，中鼻甲肥大，鼻息肉，变态反应性鼻炎，鼻中异物，肿瘤等鼻腔疾病，阻塞鼻道，妨碍鼻窦的通气引流所致。

4. 扁桃体炎，腺样体肥大，上颌等二双尖牙及第一、第二磨牙根部的感染，拔牙时损伤窦壁或龋齿残根坠入窦内，可引起上颌窦炎。

5. 鼻窦外伤骨折，异物穿入鼻窦，游泳跳水或潜水姿势不当，或游泳后用力擤鼻将污水挤入窦内，引起感染。

6. 鼻腔内填塞物留置时间过久，刺激、污染和通气不好而致本病。

7. 高空飞行迅速下降时，气压改变，窦腔形成相对负压，鼻腔炎性分泌物因此可被吸入鼻窦。

副鼻窦炎有些什么症状呢？

不论慢性或急性副鼻窦炎，鼻道积脓是重要体征之一。急性期常见的症状有：周身不适，精神不振或烦躁，食欲不振，畏寒发热，持续性鼻塞，大量粘性脓涕不易擤尽，头痛及局部疼痛。就头痛而言，一般急性上颌窦炎前额部疼痛，

早晨轻、午后重；急性筛窦炎头痛较轻；急性额窦炎，前额痛为主，晨起即感头痛逐渐加重，午后减轻，至夜间全部消失，次日又作；急性蝶窦炎，眼球深处疼痛，可放射至头顶、枕部疼痛，早上轻，午后重。头痛往往因咳嗽、擤鼻、弯腰、低头、用力大便、摇头及身体突然震动时头痛明显加重。

慢性副鼻窦炎的临床症状与急性型相似但较轻，头痛一般不明显，而且头痛多有沉重、压迫和闷痛等感觉。

祖国医学称副鼻窦炎为“鼻渊”，是外感风火热毒阻于鼻窦所致，治法应以清肺、泄热、解毒为主。

方一：辛荑12克，黄芩12克，生山栀12克，知母12克，麦冬12克，白芷12克，苍耳子12克，生石膏30克，银花30克，鱼腥草30克（后下），水煎服。

方二：鱼腥草2000克，葛根1500克，黄芩1500克，花粉1500克，大贝1500克，苍耳子1500克，胆草100克，薄荷750克。研末加蜜为丸，每丸10克。每次一丸，每日三次，小儿酌减。

方三：防风10克，荆芥10克，柴胡10克，香附12克，川芎12克，细辛6克，白芷10克，薄荷10克（后下），僵蚕10克，羌活10克，甘草6克。

服法，水煎服，每日一剂，早晚各一次，可连服20~30剂。

治疗副鼻窦炎的单方验方：

1. 丝瓜藤取近根处，焙干研末，每次服6克，每日2次，适用慢性鼻窦炎。

2.鲜大蓟根60克，鸡蛋2~3个，共煮，吃蛋喝汤。忌吃辛辣等刺激性食物。

81. 急性咽炎

急性咽炎在秋冬及冬春季之交比较常见，是咽粘膜、粘膜下组织和淋巴组织的急性炎症。本病属上呼吸道感染的一部分，常由于急性鼻炎发展所致。

急性咽炎的病因主要有两种。

一是病毒传染。在冬春季，气候比较寒冷，人们常在公共场所人群集中的地方出没，病毒就可能通过飞沫和密切接触引起传染。二是细菌感染。以链球菌、葡萄球菌和肺炎双球菌为主，其中溶血性链球菌引起的最严重，有时可能化脓，称为急性脓毒性咽炎。

临床表现：

一般起病较急，初起病人不同程度地感到发热恶寒，头痛，食欲不振，四肢酸痛，咽部干燥发胀、灼热及粗糙感等，进而咽部疼痛，吞咽唾液时咽痛最明显，唾液增多，或有咳嗽痰黄和声音嘶哑，大便秘结，重症患者可见寒战高热，头痛，甚至恶心呕吐等。

检查：口咽及鼻咽粘膜充血肿胀，腭弓、悬雍垂水肿，咽后壁淋巴滤泡和咽侧索亦可红肿，下颌角淋巴肿大压痛。

急性咽炎可伴发中耳炎、鼻窦炎、喉炎、气管炎及肺炎。急性脓毒性咽炎还可能并发急性肾炎，风湿热和败血症

等。

本病属于祖国医学的“喉痹”范畴，常因为气候急剧变化，起居不慎，肺卫失固，邪热壅结于咽所致。中医治疗本病一般分为风热、风寒两型。

1.风热型（较多见） 恶寒轻，发热重，咽部干燥、灼热、疼痛，声音嘶哑，咳痰黄稠，舌红苔黄，脉数，治宜疏风清热。

处方：荆芥10克，防风10克，牛蒡子15克，银花15克，连翘15克，桑白皮10克，赤芍10克，黄芩12克，花粉10克，玄参12克，浙贝12克，桔梗10克，甘草3克。水煎服。

2.风寒型（较少见） 恶寒重，发热轻，咽部疼痛，头痛，一身酸痛，声嘶，咳痰清稀，舌淡红，苔白，脉浮。治宜疏风散寒。

处方：桔梗12克，羌活12克，柴胡12克，前胡12克，枳壳12克，茯苓20克，川芎10克，甘草6克。水煎服。

此外，还可服用六神丸（成药）、牛黄解毒丸（成药），并用银花漱口液（用银花30克，生甘草10克，薄荷10克，硼砂6克，土牛膝根30克，加水浓煎而成）含漱。

82. 慢性咽炎

慢性咽炎病程较长，症状顽固而不易治愈。为咽部粘膜、粘膜下及淋巴组织的弥漫性炎症，从病理分类可分为慢性单纯性咽炎、慢性肥厚性咽炎，萎缩性或干燥性咽炎，多发生于中年人。

慢性咽炎主要是急性咽炎治疗不彻底而反复发作转为慢

性的，或者是因为患各种鼻病，鼻窦阻塞，长期张口呼吸，以及物理、化学因素，颈部放射治疗等经常刺激咽部所致。全身性各种慢性疾病，如贫血、便秘、下呼吸道慢性炎症，心血管疾病等也可继发本病。

慢性咽炎有些什么常见的临床表现呢？

病人咽部可有各种不适的感觉，尤以咽部异物感最明显。常主诉咽中似有物，吞之不下，咯之不出，咽部或有发痒、灼热、干燥、微痛等感觉，有的患者可因咽中粘痰咯不出来，而引起短促、频繁的咳嗽干呕，无痰或仅有颗粒状如藕粉样痰咯出。上述诸症一般在说话稍多时加重。

中医认为慢性咽炎多属肾阴虚，津液不足，或者是痰热蕴积，肺阴受损所致。治宜滋阴补肾，清热利咽。

方一：北沙参30克，麦冬30克，黄芩15克，桑皮12克，花粉12克，桔梗10克，生甘草6克。水煎服，每日一剂。

加减：异物感严重时加射干12克、山慈菇15克。咽干甚加石斛15克、玄参20克。痰粘咯不出加海浮石10克、瓜蒌皮15克。

方二：女贞子30克，蒲公英30克，合欢皮15克，旱莲草30克，陈皮10克，元胡10克。水煎频服。

此外，麦门冬汤、百合固金汤、知柏地黄汤、养阴清肺汤均可随证选用。对于久病的患者，一般宜在养阴药中加入肉桂2克、红花2克，并须注意守方，坚持服用，才能取得较好疗效。

肿 瘤 科

83. 鼻 咽 癌

鼻咽癌在我国发病率较高，尤以南方为多见，发病年龄大多在30~50岁之间，男多于女。发病与遗传、病毒、环境三因素有关。临床主要症状有鼻塞、鼻腔出血（鼻涕中带有血丝），常以颈部淋巴结转移而就诊。作鼻咽部或转移淋巴结活组织病理切片检查可以确诊。治疗以放射疗法为主，加用中药治疗，则可提高疗效。

鼻咽癌类似于中医的“瘰癧”、“恶核肿”、“失荣”等病证，中医认为多由风邪挟毒形成。《内经》说：“邪之所凑，其气必虚”，七情损伤、正气不足是患鼻咽癌的内因。正虚之体，再遇风邪挟毒的侵袭，沉积于鼻腔，气血运行受阻，瘀积而成肿块。

早期鼻咽癌患者，除少数有耳鸣、鼻塞、鼻涕中带血丝外，一般没有什么自觉症状。除防癌普查中发现的以外，往往以颈侧淋巴结肿大而被发现。肿块不红不痛，质硬而固定，进行性增大。伴有听力下降，耳痛等症状。早期没有头痛的症状。病情继续发展可有咳嗽、声嘶、舌歪斜等表现。晚期有颅内转移时则头痛剧烈（固定的区域疼痛），并有呕吐，眼球内斜固定，突眼，复视等症状。亦可造成肝及脊髓等远处转移而出现相应的病变。

中医治疗鼻咽癌一般可参考以下三种证型，但中医药治疗尚无理想的根治方药，故应配合其它方法治疗。

一、风毒凝聚型

病变初起，鼻塞流涕，鼻涕中偶带血丝，饮食及大小便均正常，舌苔薄白，脉浮。治宜疏散风邪，解毒开窍。

处方：苍耳子10克，辛荑12克，薄荷10克（后下），白芷10克，茜草15克，山豆根12克，板蓝根30克，荆芥10克，防风10克，半枝莲30克，百花舌草蛇30克。

二、气滞血瘀型

除局部肿块增大外，病变可向一侧或双侧颈部转移，在耳下及颈部出现包块，质硬，固定，不痒不痛，或转移到颅内，出现固定性头痛，伴有呕吐。若肿瘤压迫第Ⅱ、Ⅳ对脑神经，可出现眼球内斜固定，外展受限，复视，耳鸣，耳聋，体质逐渐衰弱，饮食减少，消瘦，舌边及舌尖有瘀斑，脉细涩。治宜理气活血逐瘀，软坚散结。

处方：苍耳子12克，辛荑12克，薄荷10克（后下），白芷10克，茜草15克，莪术15克，当归12克，川芎10克，赤芍12克，甲珠15克，蚤休24克，夏枯草30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。

加减：若头痛剧烈加蔓荆子12克；若颈部包块明显肿大者加昆布24克，海藻24克，浙贝12克，若兼痰湿重者加茯苓24克，半夏12克；听力、视力障碍者加用杞菊地黄丸（成药）。

三、燥热伤阴型

鼻咽癌晚期热毒伤阴，或经放射治疗后出现鼻咽部干燥，饮多不解渴，大便干结，小便黄少，舌红无津，或苔厚

腻，脉细数。治宜清热养阴。

处方：北沙参30克，麦冬15克，知母12克，玄参12克，银花12克，连翘12克，生石膏30克，花粉20克，芦根30克。

加减：苔黄厚腻者加用藿香、佩兰、苡仁；若热伤血络衄血多者加三七粉、蒲黄炭、小蓟等。

对鼻咽癌的治疗，一方面作放射治疗，一方面吃中药，二者结合，效果较好。放射治疗有引起白血球下降等副作用，可服中药女贞子、补骨脂（兼有抗癌作用），以升高白血球。

蜂乳既有升白血球及滋补强壮的作用，又有抗癌作用，可作为辅助治疗药品常服，必要时可加大剂量服用（即按说明书上规定的剂量加倍服用）。

鼻咽癌的中药治疗，除上面介绍的分三型治疗以外，也可用大蒜注射液作静脉滴注，每日一次。同时服下列处方：

山慈菇15克，肿节风30克，蜈蚣2条，全蝎6克，苍耳子12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，黄芪30克。水煎服，每日一剂。

药理研究证明，山慈菇、肿节风、蜈蚣、全蝎、苍耳子、半枝莲、白花蛇舌草、黄芪均有抗肿瘤作用。黄芪、白花蛇舌草兼有扶正培本，增强机体免疫功能的作用。据国内报道，山慈菇、肿节风、蜈蚣、全蝎、苍耳子、半枝莲单用或入复方治疗鼻咽癌均有较好疗效。故将这些药物组合在一个处方内联合使用，可望提高疗效。

84. 食道癌

食道癌多见于三十五岁以上的男性，以吞咽梗阻，进行性加剧为主要特征。食道吞钡检查可见食管管腔局限性狭窄，钡流不畅或梗阻，上段扩张。食道拉网检查见癌细胞即可确诊。食道癌早期作手术切除效果较好。

食道癌与中医的“噎膈”相类似，噎是吞咽之时梗噎不顺，膈是胸膈阻塞，饮食不得下。《内经》说：“三阳结谓之膈”，“膈塞闭绝，上下不通，暴忧之病也”。张景岳认为“噎膈一证，必以忧愁、思虑、积郁而成”。《诸病源候论》说：“忧恚则气结，气结则津液不宣流使噎”。

饮酒过多或过食辛香燥热之品亦可致积热伤阴，津伤血燥，日久瘀热停留，阻于食道成噎膈。《医学统旨》说：“酒肉炙煿，粘涩难化之物，滞于中宫，损伤肠胃，渐成痞满吞酸，甚至为噎膈反胃”。

食道癌早期可无症状，偶觉进食梗阻，可自行缓解，数月后病情加重，出现吞咽困难，尤其是固体食物更是难以吞咽，只能进软食或流汁食物，最后连水也咽不下去，即使勉强咽下也随即吐出，逐渐发展到胸骨后疼痛，并有烧灼感，吐涎较多，全身消瘦，大便秘结，甚则吐下如赤豆汁，晚期可向颈部和肺脏、肝脏转移，在颈部淋巴结可摸到肿块。

中医治疗食道癌目前尚无理想的根治方药，可参考以下证型辨证施治：

一、肝郁气滞型

偶感进食梗阻，停食后可自行缓解，苔薄脉稍弦。治宜

理气降逆。

处方：柴胡15克，白芍30克，香附12克，旋覆花12克，丹参30克，核桃树枝30克，瓜蒌30。水煎服。

二、痰气交阻型

吞咽困难，呕吐痰涎较多，胸膈痞满隐痛，大便干涩，口干咽燥，身体逐渐消瘦，舌红，苔黄腻，脉弦滑。治宜开郁降逆，豁痰润燥。

处方：郁金12克，砂仁壳10克，南沙参18克，浙贝12克，丹参15克，茯苓15克，法半夏10克，瓜蒌30克，天南星10克，黄药子30克。水煎服。

三、瘀血内结型

吞咽梗阻加剧，食入复吐出，甚则水饮难下，胸骨区疼痛，或有烧灼感，大便坚如羊屎，或吐下如赤豆汁，形体更渐消瘦，肌肤枯燥，舌红少津，舌边有瘀斑，脉细涩。治宜滋阴养血，破结行瘀。

处方：莪术12克，当归15克，昆布30克，海藻30克，瓜蒌30克，蜣螂10克，土鳖虫10克，生地30克，女贞子15克，麦冬15克。如服药即吐，可先服玉枢丹（成药）。

四、气虚阳微型

吞咽不下，饮水亦难，形体消瘦，面色晄白，形寒肢冷，气短乏力，泛吐清涎，面浮足肿，舌淡苔薄，脉细弱。治宜补气健脾，温中回阳降逆。

处方：党参30克，黄芪30克，白术15克，茯苓12克，旋覆花12克，代赭石30克，干姜9克，附片12克（先熬）。

注：本病至此，多属难治。

在食道癌初起阶段，虽有饮食梗噎症状，但癌症尚未转

移，颈部淋巴结摸不到肿块，此时选用下列方剂治疗，收效较为满意。

方一：党参60克，丹参60克，硼砂6克，硃砂3克，莪术15克，石打穿30克，黄药子15克，甲珠12克，蜈蚣2条，全蝎3克，乌梅12克，僵蚕12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每次含化1~2丸，每日含服3次。

方二：猪苓30克，龙葵15克，半枝莲30克，水蛭6克，肿节风30克，石见穿15克，山慈菇15克，山豆根15克，水煎服。每日一剂。

方三：鸦胆子3克，天龙（壁虎）3克，水蛭3克，蜈蚣1条，上药共研细粉，装入胶囊（一日量），开水吞服。

方四：蜣螂3~5克，研末，用大枣60克煎水送服。

药理研究证明，猪苓、龙葵、半枝莲、水蛭、黄药子、肿节风、石见穿、山慈菇、山豆根、蜈蚣、鸦胆子、蜣螂、天龙均有抗肿瘤作用。据国内报道，这些药物单用或入复方治疗食道癌均有较好疗效。

民间用核桃树枝或核桃树叶或青核桃（未成熟果实）煮鸡蛋治疗食道癌，有一定疗效，而且药理研究也证明青核桃和核桃树枝均有抗肿瘤作用。这个方法简、便、验、廉，没有副作用，值得推广。

民间还有用鹅血治疗食道癌的经验，药理研究也证实鹅血有抗肿瘤作用，且能升高白血球。服法是：鹅血热饮。如能坚持鹅血治疗、化学疗法、中药治疗等综合方法治疗食道癌，可提高疗效。

猴菇菌（猴头菌）是一种滋补食品，药理研究证明有抗

肿瘤作用，市上有猴菇菌片（成药）出售，可作为食道癌的辅助治疗，长期服用。

85. 喉 癌

喉癌以声音嘶哑、进行性加重为主要临床表现。患者多因喉部不适、吞咽困难或颈部出现肿块而就诊。用喉头镜检查并取患处的活体组织作病理切片检查可以确诊。早期可用手术切除，并加用放射治疗和中草药治疗。

喉癌类似于中医的“喉瘤”、“喉菌”、“喉百叶”、“喉疳”等，中医认为多因忧思郁怒，气血流行不畅，经络阻塞，加受外邪所致。

本病初起症状不明显，精神稍差，饮食和大小便均正常，感冒后咽喉部可有异物感、紧迫感及吞咽不适。或干咳，痰中带血丝，进而声音嘶哑，或患侧头痛、耳痛。多被当作普通感冒而延误治疗。晚期可出现喉部阻塞症状，如呼吸困难或喉部出现肿块（颈淋巴结转移）。本病病程较长，发展缓慢，若能积极治疗，争取时间，预后尚好。

中医治疗喉癌目前尚无疗效理想的根治方药，可参考以下证型辨证施治：

一、风热阻滞型（早期）

鼻塞，干咳无痰，咽干口燥，声音嘶哑，饮水不多，苔薄黄，脉浮数。

治宜疏风清热利咽，佐以解毒散结。

处方：玄参12克，天冬15克，麦冬15克，山豆根12克，马勃10克，僵蚕12克。露蜂房15克，银花15克，半枝莲30

克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、气血瘀滞型（中、晚期）

声音嘶哑进行性加剧，咽喉有异物感、紧迫感，甚则吞咽困难，晚期包块阻塞气道，呼吸困难，或颈部出现肿块，形体消瘦，饮食少思，舌有瘀斑，苔薄，脉细涩。

治宜活血化瘀，佐以清热解毒散结。

处方：玄参12克，浙贝12克，马勃10克，莪术15克，甲珠15克，硼砂6克，硃砂3克，蚤休24克，全蝎3克，蜈蚣2条，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

三、气阴两伤型（晚期）

病程已进入晚期，声哑更甚，包块溃烂，口干引饮，干咳痰少，气短无力，饮食少思，小便黄，大便结燥，舌红无苔，脉细无力。

治宜益气养阴，佐以活血化瘀。

处方：玄参12克，天冬15克，麦冬15克，玉竹18克，莪术15克，甲珠15克，黄芪30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

86. 甲状腺癌

甲状腺癌多发生于40岁以下的女性。多为一侧甲状腺出现单个结节或肿块，质硬，不规则，边界不清，活动度差。亦有双侧甲状腺出现多个结节和肿块的，但较少见。肿块生长较缓慢，多无自觉症状。患者常在淋巴结转移后始来就诊。用放射性同位素扫描检查出现“冷结节”、活体组织病理切片检查找到癌细胞即可确诊。本病早期治疗可作手术切

除，并配合用放射治疗和中草药治疗。

甲状腺癌类似于中医的“瘰瘤”。中医认为多因气郁不舒，气血运行失调，气滞血瘀痰凝而成。如《外科正宗》说：“夫人生瘰瘤之症，非阴阳正气结肿，乃五脏瘀血、浊气、痰滞而成”。

本病临床最常见的症状是情绪不稳定，易急易怒，继之颈部出现包块，多为单发，小者质较硬，不规则，边界不清，活动度差，大者似囊性肿块。病情发展缓慢，可十数年发展不明显。晚期可向周围蔓延，形成“串疔”（淋巴结转移），或影响咽喉而出现声音嘶哑，病灶局部和“串疔”均可溃烂，流血水不止，疼痛，食少，形体消瘦。

中医治疗甲状腺癌目前尚无疗效理想的根治方药，可参考以下证型辨证施治：

一、肝郁气结型

急躁易怒，甲状腺局部出现包块，肿块较软，边界不清，活动度差，苔薄脉弦。治宜舒肝解郁，养血舒筋，佐以活血化瘀，软坚散结。

处方：当归12克，黄芪30克，白芍15克，生地12克，青皮12克，芦荟9克，昆布30克，海藻30克，天南星9克，夏枯草30克，龙胆草9克，甲珠15克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、气血瘀结型

肿块坚硬如石，固定不移，或向周围蔓延，出现“串疔”，或声音嘶哑，形体消瘦，病灶局部溃烂绵绵，出血不止，饮食少思，气短乏力，苔薄，舌质紫暗，舌有瘀斑，脉细涩。治宜活血逐瘀，佐以扶正。

处方：红参6克（嚼服），黄芪30克，白花蛇舌草30克，

半枝莲30克，夏枯草30克，山豆根12克，甲珠15克，莪术12克，昆布30克，海藻30克，天冬15克，土鳖虫9克。水煎服。

甲状腺癌的中药治疗，除上述分型治疗外，尚可用下列方剂常服：

山慈菇30克，肿节风30克，黄药子15克，核桃树枝30克。水煎服。

据国内报道，山慈菇、肿节风、黄药子、核桃树枝单用或入复方治疗甲状腺癌，均有较好疗效。

87. 肺 癌

肺癌是常见的恶性肿瘤之一，发病率有逐年增高的趋势，病因尚未完全清楚，与机体内在因素和周围环境因素的关系较为密切。肺癌以长期干咳少痰或痰中带血丝为特征。经X线检查可发现肺部包块，经支气管镜取活体组织作病理检查，或晨痰查见癌细胞，即可确诊。由于肺癌的早期诊断比较困难，病程进展快，允许彻底治疗的时间短暂，稍一迟缓，就错过时机，故治愈率较低，如能早期手术切除，并配合用放射疗法、化学疗法、免疫疗法及中草药治疗，部分病例可取得良好效果。

肺癌类似于中医的“肺积”、“息贲”等病证。中医认为多因忧思郁怒，脏腑失调，正气不足，反复感受外邪、风寒与痰饮、瘀血积聚而成。

肺癌病人早期除全身乏力外，可无症状，偶因感冒后咳嗽痰少，有时可见痰中带血丝，经久不愈。经X线检查发现

肺部有包块始引起重视。

病程发展至晚期，肺部包块增大，出现严重肺部感染症状，如咳嗽、胸痛。如肺功能损害严重时，咳嗽更剧，心累气喘，不能平卧，甚至彻夜不能眠，痰血增多。损及胸膜时可出现剧烈胸痛。颈淋巴结转移，可出现肩颈部疼痛，上肢肿胀，活动受限。远处骨转移，可出现该部的疼痛及活动受限。头部转移，可出现剧烈头痛等等。此时全身功能皆受影响，食少无力，消瘦，可因大出血而抢救不及，少数病例也可因脱落组织（癌栓）阻塞重要部位而致死。

中医治疗肺癌目前尚无疗效理想的方药，可参考以下证型辨证施治：

一、风热犯肺型

感冒后咳嗽痰少，偶见痰中有血丝，久久不愈，肺部包块很小，口干舌燥，小便黄，大便干，苔薄黄，脉浮数。治宜疏风清热，佐以软坚散结。

处方：银花12克，荆芥12克，大力子12克，蚤休24克，猪苓24克，败酱草30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，芦荟9克。水煎服。

二、痰涎阻肺，肺失清肃型

肺部包块增大，咳嗽痰多，痰中带血丝或吐血，心累气喘，甚至不能平卧，口干不思饮，苔黄厚腻，脉弦滑。治宜豁痰肃肺，佐以活血化痰。

处方：苇茎30克，桃仁12克，冬瓜仁30克，苡仁30克，法夏12克，茯苓15克，山慈菇24克，败酱草30克，猪苓24克，白英30克，瓜蒌15克，莪术15克。水煎服。

三、瘀血阻滞，热毒内蕴型

肺部肿块增大，并有转移，痰涎较多，发热不退，胸膈疼痛，心累气喘，甚者形体消瘦，苔黄厚腻，舌边有瘀斑，脉弦数。治宜活血祛瘀，清热解毒，软坚散结。

处方：莪术12克，黄药子20克，甲珠15克，瓜蒌24克，天南星9克，山慈菇24克，夏枯草30克，败酱草30克，猪苓24克，丹参30克，昆布30克，海藻30克。水煎服。

加减：痛甚加乳香、没药、郁金；出血多加三七粉、炒蒲黄、仙鹤草；苔厚腻不退加苡仁、白蔻、藿香；体虚加人参。

四、肺脾两虚型

经治疗后肺部肿块有所缩小，仍久咳痰少，气促浮肿，腹胀便溏，四肢无力，舌淡苔薄，脉细濡无力，舌边有齿印。治宜益气健脾，佐以祛邪。

处方：北沙参24克，白术12克，茯苓15克，陈皮10克，法夏12克，虫草15克，五味子12克，猪苓24克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，山慈菇15克。水煎服。

加减：若气虚较甚，加人参6克，黄芪30克，若兼肾阳不足，肢冷不温，加干姜10克、附片15克（先熬）。

五、气血双亏型

喘促气短，少气懒言，咳嗽痰稀，面色㿔白，心悸头晕，畏寒自汗，小便清，大便数日不解而无所苦，舌淡苔薄，脉沉细无力。治宜补气养血，佐以祛邪。

处方：人参6克（嚼服），白术17克，茯苓15克，当归12克，熟地12克，猪苓30克，天冬15克，菌灵芝30克，黄芪30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

肺癌的中药治疗，除上述分型治疗外，尚可同时用黄药

于甘油滴入疗法。具体方法是：用黄药子乙醇提取物制成2~5%黄药子甘油注射液，作气管注射或气管滴入，每次2~4毫升。

还可配合用鸦胆子15~25粒，用龙眼肉或胶囊包裹，饭后吞服。

也可用下列方剂常服：

半枝莲30克，白英30克，肿节风30克，核桃树枝30克，猪苓30克，僵蚕10克，天龙6克，干蟾皮6克，水煎服。

药理研究证明，上述药物均有抗肿瘤作用。据报道，上述各药单用或入复方治疗肺癌均有一定疗效。

88. 胃 癌

胃癌早期可无症状，以后逐渐出现上腹痛或饱胀不适，消瘦，食欲减退，呕吐，便血，上腹部出现包块。胃癌的病因尚不清楚。X线检查发现胃部肿块或伴有溃疡。光导纤维胃镜摄影及高压冲洗、吸引、刷子刷洗涂抹作脱落细胞检查或钳取活体组织作病理切片检查即可确诊。治疗应从整体观念出发，采取中西医结合的综合治疗。早期以手术治疗为主（Ⅰ、Ⅱ期），术后以健脾和胃、疏肝理气的中药调理，以改善胃肠功能。Ⅱ期以上手术后应配合中药及化学疗法。Ⅲ期以上只能作姑息切除，并辅以中草药治疗及化学疗法。胃癌类似于祖国医学的“反胃”、“胃反”、“胃脘痛”、“膈气”等。《内经·邪气脏腑病形篇》有“胃病者，腹胀，胃脘当心而痛，……膈咽不通，饮食不下”的记载，《金匱要略》也有“朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名曰胃反”的

描述。这些描述即包括胃癌在内。其病多为忧思郁怒，寒凝气滞血瘀而成。治以温中散寒行瘀止痛为法。唯此病早期诊断比较困难，多数病人在确诊时已属晚期。晚期治疗效果都不理想。

胃癌的早期症状不明显，有的病人只觉得上腹痛或饱胀不适，饮食减少，精神不振。继之逐渐出现胃脘痛，饮食不消化，表现为“朝食暮吐，暮食朝吐”，上腹部出现包块，消瘦，甚则吐血、便血（黑大便），大便结燥，疲乏无力，疼痛逐渐加剧，甚至难以忍受。

中医治疗胃癌目前尚无疗效理想的根治方药，可参考以下证型，辨证施治：

一、肝胃不和型

胃脘胀满，有时隐痛，连及两胁，气急不舒则疼痛加重，嗳气反酸或呃逆呕吐，苔薄或薄黄，脉弦细。治宜舒肝和胃，佐以降逆止痛。

处方：柴胡12克，白芍15克，枳壳12克，旋覆花12克，丹参30克，石见穿30克，黄药子15克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、脾胃虚寒型

胃脘隐痛，喜按喜温，或朝食暮吐，暮食朝吐，时吐清水，面色晄白无华，食少便溏，精神疲乏，舌淡而胖，苔薄润，脉沉缓弱。治宜温中散寒，佐以活血止痛。

处方：黄芪30克，肉桂6克，白芍20克，干姜6克，大枣30克，石见穿30克，黄药子15克，藤梨根30克，肿节风30克，喜树果30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

三、痰湿凝结型

胃脘胀痛，胸闷不舒，呕吐痰涎，或吐痰较多，面黄体胖，大便溏，小便正常，苔白厚腻，脉濡滑或缓。治宜温胃散寒，祛痰散结。

处方：干姜9克，茯苓20克，陈皮10克，法夏10克，生南星24克（先熬），黄药子15克，肿节风30克，海藻30克，夏枯草30克，吴萸3克，广香12克。水煎服。

四、瘀毒内阻型

胃脘刺痛，心下肿块拒按，固定不移，消瘦，食少，食入良久复吐出，呕血，便血，大便干结，肌肤甲错，舌质紫暗，脉沉细涩。治宜解毒祛瘀，活血止痛。

处方：五灵脂12克，生蒲黄12克，莪术15克，鳖甲30克，甲珠15克，蚤休24克，石见穿30克，土鳖虫10克，赤芍12克。水煎服。

加减：疼痛剧烈加乳香、没药、玄胡、九香虫。

五、胃热伤阴型

胃脘灼热，口干饮冷，食后痛剧，五心烦热，大便干结，舌红绛少苔，脉细滑数。治宜清热解毒养阴，佐以活血。

处方：北沙参24克，麦冬15克，知母12克，生石膏30克，花粉12克，生大黄6克，芦荟10克，蚤休24克，败酱草30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

六、气血双亏型

包块增大，疼痛，形体瘦削，神疲乏力，心悸气短，自汗盗汗，舌淡少苔，脉沉细无力。治宜补气养血，佐以活血。

处方：人参10克（嚼服），黄芪30克，当归12克，白术

15克，白芍15克，熟地20克，莪术15克，石见穿30克，水煎服。

中医药治疗胃癌，除上述分型治疗外，可用蚤休（又名七叶一枝花，重楼，草河车，金线重楼）50~100克煎水服，每日一剂。剂量宜大。动物实验和临床实践都证明，大剂量连续服用（连服50~80天）未见不良反应。药理研究证明，蚤休有抗肿瘤作用。据报道，用蚤休治疗晚期胃癌15例，全部病例手术时已见广泛转移，5例做了胃大部切除，4例做了胃次全切除，全部病例用蚤休治疗（单用蚤休100克煎水服，或随证加入常规剂量的人参、茯苓、山慈菇等抗肿瘤药物）。连服5~8个疗程（十天为一疗程），有5例肿块缩小或症状减轻，有10例延长了生命（均为广泛转移患者）。证明蚤休用于治疗恶性肿瘤有可喜苗头。

胃癌也可用下列方剂治疗：

白英（又名蜀羊泉、排风藤、白毛藤）30克，肿节风30克，猪苓30克，石见穿30克，莪术15克，黄药子15克，干蟾皮6克，蜈蚣2条，苡仁30克，水煎服。

上述各药均有抗肿瘤作用。据国内报道，上述各药单用或入复方治疗胃癌均有一定疗效。

蜂乳、猴菇菌片、核桃树枝煮鸡蛋，均可作为胃癌的辅助治疗，有利无害。

89. 结 肠 癌

结肠癌以腹痛，腹泻和便秘交替出现为特征，作一般内科治疗往往效果不明显。反复发作，后期则消瘦、贫血及局

部出现肿块，癌细胞进而向腹腔淋巴结及附近脏器转移。作X线钡餐检查，结肠镜检查，活体组织病理切片检查可以确诊。早期治疗以手术切除为首选，配合用中草药治疗及化学疗法则效果更满意。

结肠癌类似于中医的“脾积”，“肠风下血”等病证。《诸病源候论》有这样一段描述：“诊得脾积，脉浮大而长，……累累如桃李，起见于外，腹满呕泄，肠鸣，四肢重，足胫肿厥，不能卧”。这和现代的晚期结肠癌的表现很相类似。中医认为结肠癌多因情志不舒，忧思郁怒损伤脾胃，再感受湿热邪毒而成。

结肠癌的早期多无特殊症状，偶有隐隐的腹痛，劳动或行走后腹痛加剧，疼痛的部位固定不移，疲倦乏力，食欲不振，腹胀不舒，以后就腹泻与便秘交替出现，有时大便中还带有粘液脓血。渐渐地面色苍白，形体消瘦。稍晚期可在腹部扪到包块，质地坚硬，表面不平，并有轻微压痛，包块不随肠蠕动而变形。若腹中包块梗阻加剧可产生肠梗阻（不大便、呕吐、腹痛）。到了晚期，癌细胞可向腹腔淋巴结、肝脏、盆腔、子宫等处转移，则出现相应的脏器病变，可有腹水，疼痛加剧，特别是在大便之前会产生剧烈的腹痛。

中医治疗结肠癌目前尚无疗效理想的根治方药，可参考以下证型，辨证施治：

一、肝郁脾虚型

病变初期，小腹隐痛，劳累，行走或精神刺激可使腹痛加重，痛点固定不移，甚则腹泻与便秘交替出现，苔薄，脉细弦。治宜疏肝理脾。

处方：柴胡15克，白芍12克，枳实12克，白术15克，茯

苓24克，香附12克，半枝莲30克，败酱草30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

加减：腹泻时加用黄连10克、苦参15克；便秘时加用芦荟10克、大黄10克。

二、湿热蕴结型

腹痛腹胀，食欲不振，疲乏无力，大便频频，粘液脓血杂下，腹泻与便秘交替出现，这种交替的间隔日渐缩短，苔黄腻，脉濡数。治宜清热利湿，解毒行滞。

处方：柴胡12克，白芍12克，枳实12克，白头翁15克，败酱草30克，黄连9克，黄柏12克，蚤休24克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

三、气血瘀阻型

病变进展到晚期，便前腹痛剧烈，腹部可扪到包块，质硬固定，表面不平，有压痛，甚则可出现其他脏器转移病变及腹水，舌质紫暗，脉涩。治宜活血化瘀，软坚散结。

处方：莪术15克，石见穿30克，夏枯草30克，败酱草30克，当归12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，甲珠15克，昆布30克，海藻30克。水煎服。

四、气阴两伤型

病至晚期，气阴两伤，气短乏力，口干舌燥，消瘦，大便燥结难解，腹痛剧烈，包块更明显，舌红绛无苔，脉细数。治宜益气养阴，兼清热解毒，活血化瘀。

处方：北沙参30克，麦冬20克，黄芪30克，白术24克，茯苓30克，鳖甲30克，莪术15克，败酱草30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，蚤休24克。水煎服。

五、脾肾阳虚型

病至晚期，阴损及阳，气短乏力，四肢不温，饮食少思，消瘦，腹胀，腹水。水肿不退，舌质淡，苔薄，脉沉细无力。治宜温中回阳，化气行水。

处方：人参10克（嚼服）干姜10克，制附片30克（先熬），白芍12克，茯苓15克，白术15克，莪术15克，败酱草30克，石见穿30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

据国内报道，肿节风、猪苓、莪术，大黄、蟾皮、蜈蚣，单用这些药物或入复方治疗结肠癌，均有一定疗效，因此，结肠癌的治疗，除上面介绍的分型治疗外。也可服下列基本方：猪苓30克，肿节风30克，莪术15克，大黄30克（便秘时用，腹泻时则不用），干蟾皮6克，蜈蚣2条。水煎服。

90. 直 肠 癌

直肠癌是消化道常见恶性肿瘤之一，早期可无症状，偶见大便带血。后期有排便习惯改变和排便性质改变。肛门指检时可扪及肿块，X线钡灌肠检查、直肠镜检查及活体组织病理切片检查可确诊。直肠癌早期最好用手术切除，并可配合用中草药及化学疗法治疗。

直肠癌类似于中医的“脏毒下血”、“肠覃”、“结阴”等病证。中医认为多因七情过度，损伤肠胃，加之湿热蕴结，气血运行受阻，结而成肿块。

直肠癌早期症状不明显，只是偶有便血。若继续发展，分泌物增加，可见肛门潮湿或肠直内有不适感。大便可带有粘液及脓血，而误诊为痢疾，甚至大便失禁，流出粘液和恶臭脓血。肿块长大，肛管狭窄时，大便变得扁而细，大便表

面可有凹陷畸形。或有便秘，解便时疼痛。如肿块腐烂脱落则可出现大出血，到了晚期，男性患者可出现尿频及排尿困难（癌细胞侵犯尿道），女性患者虽病变侵犯子宫及附件，但多无症状。病程到最后，形体瘦弱，疼痛剧烈，不能睡眠，气血日亏，全身衰竭。

中医治疗直肠癌目前尚无疗效理想的方药，可参考以下证型，辨证施治：

一、湿热下注型

大便次数频繁，粘液脓血杂下，里急后重，常有便意，口干心烦，小便黄少，苔黄腻，脉滑数。治宜清热利湿，解毒行滞。

处方：黄连9克，黄柏12克，白头翁30克，地榆12克，槐花12克，苦参12克，石见穿30克，露蜂房15克，蛇蜕6克，肿节风30克，龙葵15克，败酱草30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、气滞血瘀型

腹痛，里急后重，大便带粘液脓血，或便结细小难下，便时疼痛更剧，苔薄，舌边舌尖有瘀斑，脉细涩。治宜活血化瘀，佐以清热解毒。

处方：桃仁10克，红花10克，当归12克，石见穿30克，莪术15克，甲珠15克，生大黄6克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

三、气阴两虚型

形体消瘦，气短懒言，食少便秘，心烦易怒，口干但饮水不多，小便黄，舌红绛无苔，脉细数。治宜气阴双补，佐以解毒活血。

处方：北沙参24克，麦冬12克，五味子15克，龟版30克，鳖甲24克，石斛15克，甲珠15克，莪术15克，石见穿30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

四、肺脾气虚型

多见于手术切除或化学治疗之后，正气大伤，气短无力，饮食不多，食后脘腹胀满，大便稀溏，小便清，舌质淡，苔薄，脉细无力。治宜补益肺脾，佐以解毒抗癌。

处方：南沙参15克，北沙参15克，黄芪30克，白术15克，茯苓24克，陈皮12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，败酱草30克，蚤休24克。水煎服。

加減：食欲不振加砂仁、白蔻、山楂、神曲。肛门红肿加地榆、槐花、银花藤、蒲公英。肢冷不温，畏寒加淫羊藿、仙茅、枸杞、附片（先熬）。

直肠癌除上述分型治疗外，尚可选用下列方剂治疗：

1. 水蛭3克，焙干，研粉，开水吞服，每日一次。
2. 鸦胆子15~25粒，装入胶囊，开水吞服。
3. 猪苓30克，肿节风30克，石见穿15克，莪术15克，蜈蚣6克。水煎服。

猴菇菌、蜂乳对直肠癌也有一定疗效，可作为辅助治疗。

91. 原发性肝癌

原发性肝癌是我国常见的恶性肿瘤之一，中壮年男性的发病率较高。病因还不清楚，与病毒因素和化学因素关系较为密切。因其恶性程度较高，死亡迅速，对人民生命危害极大。在早期诊断方面，除超声波、同位素扫描外，甲胎蛋白

的检测是简便有效的普查方法。腹腔镜、肝穿刺、剖腹探查虽有确诊的意义，但有其局限性和并发症，还不能大量采用。早期治疗以手术为主，较晚期病员以中西医结合非手术治疗为主，中草药和免疫疗法更得到大家的重视。

肝癌类似于中医的“肝积”、“肥气”等病证，《灵枢》论“肥气”说：“在胁下，如覆杯”，说明肝癌患者在右上腹部有包块。中医认为肝癌的发病与喜怒无常、忧愁思虑过度有关。加上外在因素如寒温不调，饮食不节，则更易形成。《内经》说：“怒气逆则伤肝，其候在于胁也。”又说：“邪在肝，则两胁下痛”。

肝癌早期起病非常隐匿。晚期表现亦常多样化，通常以上腹胀满，肝区疼痛，上腹肿块，胃纳减退，乏力，消瘦为多见。肝痛往往多剧烈，并向肩背放射，肿块进行性增大，质地坚硬呈结节状或巨块状，伴有压痛。也有以腹泻、黄疸、急腹症为突出表现者。顽固性恶心、呕吐、严重腹泻多为极晚期表现。最后肝区疼痛无法忍耐，包块增大，左边与脾脏相连，下边直至脐下小腹，黄疸、腹水、消瘦、发热、衰竭、昏迷而死亡。若伴有肝硬化，或肝癌是在肝硬化的基础上发展而成的，则有食道静脉曲张，吐血，便血等。

中医治疗肝癌目前尚无疗效理想的方药，可参考以下证型，辨证施治。

一、肝胃不和型（早期）

病变早期，可无症状，因普查等偶然发现。或脘腹胀满，胁痛不甚，饮食减少，疲倦，苔白，脉稍弦。治宜疏肝和胃，佐以行气活血。

处方：柴胡15克，白芍15克，枳实12克，当归12克，香

茜12克，陈皮12克，莪术15克，丹参15克，铁树叶30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、气血瘀滞型（中、晚期）

胁痛增剧，有时肩背部亦痛，胁下扪及肿块，质硬，呈结节状或巨块状，食少，饱胀，大便干，小便少，舌质紫暗，舌边有瘀斑，脉弦或弦涩。治宜活血逐瘀，佐疏肝理脾止痛。

处方：当归12克，白芍12克，水蛭3克，莪术15克，丹参15克，铁树叶30克，白术24克，茯苓24克，白英30克，败酱草30克，虎杖15克，龙葵15克，八月札15克，鳖甲15克，九香虫6克。

三、肝胆湿热瘀毒型（晚期）

肝痛剧烈，彻夜不眠，形体消瘦，腹胀如鼓，青筋暴露，四肢瘦削，全身皮肤发黄，腹水较多，大便秘，小便不利，苔薄脉细，舌边有瘀斑。治宜破瘀止痛，兼理脾逐水退黄。

处方：莪术15克，当归12克，水蛭3克，猪殃殃30克，败酱草30克，人参10克（嚼服），半枝莲30克，白花蛇舌草30克，虎杖30克，鳖甲15克。水煎服。

病至此期，治疗甚难，但若能有效地止痛，病人精神愉快，仍能延长一些寿命。

肝癌除上述分型治疗外，尚可选用：

1. 鳖甲30克，猪苓30克，莪术15克，败酱草30克，肿节风30克，龙葵15克，山豆根15克，水煎服。

2. 天龙（守宫，壁虎）3克，蜈蚣1条，全蝎3克，土鳖虫3~6克，每日服3次。

上述各药经药理研究证明，均有抗肿瘤作用，临床用于治疗肝癌，有一定疗效。

92. 胰 腺 癌

胰腺癌是消化系统比较少见的恶性肿瘤。病因尚无定论，以环境因素（环境致癌物）和慢性胰腺疾病恶变的可能性较大。临床以腹痛，腹部不适，饮食不多，恶心呕吐，消瘦乏力，腹泻，黑便为主要表现。若癌症位于胰头部位则黄疸、发热较多，若位于胰腺体尾部则以包块多见。诊断存在问题较多，尤其是早期无明显症状，即使有症状亦为非特异性，故易误诊为其他疾病。细胞学检查是诊断胰腺癌的直接方法，此法需放置一双腔管至胃和十二指肠内，一面吸出胃液，一面注射促胰液素后吸取十二指肠液进行染色检查，近来有用“纤维十二指肠镜”直接插入胰管吸液的方法。其他如X线检查等方法也可辅助诊断，亦可在作其他疾病的手术过程中作胰腺活体组织病理切片检查而确诊。当前唯一的根治方法是手术切除。胰腺癌对放射疗法、化学疗法不敏感（即放射疗法、化学疗法对胰腺癌作用不大）。

胰腺癌类似于中医的“黄疸”、“症瘕”。中医药治疗胰腺癌，能减轻黄疸等症状，减慢病情恶化。

胰腺癌早期多无症状，仅上腹胀满疼痛，食欲不振，恶心呕吐，消瘦疲乏，多不被患者自己所重视。至全身出现黄疸，腹部扪及包块，患者始到医院就诊。此时黄疸多进行性加剧，发热，包块疼痛。晚期腹腔淋巴结转移时可有腹水。若贲门食管下部被转移淋巴结压迫，还可产生吞咽困难。

中医治疗胰腺癌目前尚无疗效理想的方药，可参考以下证型，辨证施治：

一、肝胃不和，脾胃虚弱型

腹痛，腹部胀满不适，食欲不振，疲乏无力，恶心呕吐，或腹泻，苔薄黄，脉缓。治宜疏肝和胃，益气健脾。

处方：柴胡12克，白芍12克，枳实12克，泡参30克，白术15克，茯苓24克，陈皮12克，法半夏12克，败酱草30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、气滞血瘀型

上腹部出现包块，质硬，固定不移，腹部胀满不适，食欲不振，乏力，或腹泻，黑便。苔薄白，舌边有瘀点，脉弦涩。治宜疏肝理脾，活血逐瘀。

处方：莪术15克，水蛭3克，甲珠15克，柴胡15克，白芍12克，枳壳12克，半枝莲30克，白术24克，黄药子15克。水煎服。

三、肝胆湿热型

脘部胀满不适，包块质硬，疼痛，固定不移，身目黄染，进行性加重，小便黄，大便干结，苔黄腻，脉弦滑数。治宜疏肝理脾，利湿退黄，佐以活血化瘀。

处方：茵陈30克，栀子12克，大黄6克，柴胡12克，败酱草30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，虎杖30克，莪术15克，甲珠15克。水煎服。

加减：体虚甚者，加人参6~10克（嚼服），黄芪30克。

胰腺癌除上述分型治疗外，尚可用肿节风30克，大黄30克，人参10克（嚼服），黄芪30克，水煎服。本方服后有泻下作用，可减轻黄疸、发热等症状。而且肿节风、大黄、人

参、黄芪经药理研究证明，均有抗肿瘤作用，临床上常用于胰腺瘤的治疗。

93. 肾 癌

肾癌以无痛性血尿、腰部或上腹部肿块、腰部疼痛为主要表现。诊断方法很多，尿脱落细胞学检查对早期肾癌有一定的诊断意义，测定尿乳酸脱氢酶活力（增高）是诊断肾癌的有效方法，X线造影也是诊断肾癌的重要方法。其他检查方法很多，可以起辅助诊断的作用。治疗以手术切除为主，放射疗法、化学疗法、激素疗法都不太敏感（效果不太好）。中西医结合的综合治疗对肾癌有一定疗效。

肾癌属于中医的腰痛、血尿范畴，因肾虚受邪，气血瘀滞，血络受伤所致。

肾癌早期无明显症状，也不易被发觉。待出现血尿时始被察觉，但多已是晚期。此时可有腰部疼痛，发热，恶心呕吐，食欲不振，消瘦，贫血等。腰部或上腹部包块则出现较晚，包块逐渐增大，边缘清楚，质较硬，表面常有隆起。若向骨、肝、脑部转移，则可出现相应的症状。

中医治疗肾癌目前尚无疗效理想的方药，可参考以下证型，辨证施治：

一、心肾阴虚型

腰部包块较小，边缘清楚，质较硬，固定不移，表面可有隆起，腰部痛，喜按，心慌，手足心热，小便色黄带红，大便正常，舌尖红，苔薄，脉沉细。治宜滋阴补肾，凉血止血。

处方：生地30克，山药30克，山萸15克，茯苓30克，寄生30克，鳖甲30克，三七粉6克，阿胶12克，小蓟12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、气血瘀结型

腰部或上腹部包块增大，腰痛较剧，血尿更加严重，食欲不振，面色苍白无华，小便色红，大便干而易解，舌边舌尖有瘀点，苔薄，脉细涩。治宜活血逐瘀。

处方：大黄12克，水蛭3克，莪术15克，土鳖虫6克，生地30克，红参10克（嚼服），黄芪30克，甲珠15克，赤芍12克。水煎服。

加减：疼痛剧烈加玄胡、郁金、乳香、没药。出血多加炒蒲黄、阿胶、三七粉。

三、肾阳虚衰型

病至后期，阴损及阳，包块更明显，尿血不多，腰痛，四肢不温，大便溏，小便清长，舌质淡，苔薄，脉沉细。治宜温补肾阳，佐以攻瘀。

处方：肉桂6克，制附片30克（先熬），熟地15克，山药30克，山萸15克，茯苓30克，淫羊藿30克，三七粉6克（吞服），人参10克（嚼服），丹参30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

肾癌除上述分型治疗外，还可服用下列处方：

猪苓30克，苡仁60克，汉防己12克，八月札20克，石上柏15克，夏枯草30克，石见穿30克。水煎服。

经药理研究证明，上述各药均有抗肿瘤作用，临床上常用于肾癌的治疗。

94. 膀胱癌

膀胱癌是泌尿系统最常见的恶性肿瘤，病因与化学致癌物、病毒因素及吸烟等有关。血尿是它的最早症状，并可伴有尿频、尿急、尿痛等症状。膀胱癌的检查方法较多，用尿液细胞检查，无痛苦，简便易行，可作初筛；膀胱镜可直接查明肿瘤部位、大小、数目、浸润范围、与输尿管口和膀胱颈的关系。作活体组织病理切片检查可以确诊；X线造影可弥补上述检查之不足。早期治疗以手术切除为好。手术切除后仍宜用中草药治疗、化学治疗或放射治疗，以防复发。

膀胱癌属于中医的血尿、淋症等范畴。两千多年前中医即有血尿的记载。《素问·气厥论》说：“胞移热于膀胱，则癃溺血”。《金匱要略》说：“热在下焦则尿血”。《巢氏病源》说：“血淋者，是热淋之甚，即尿血，谓之血淋”。《类证治裁》说：“溺血与血淋异，痛为血淋，不痛为尿血，痛为火盛，不痛为虚”。这些描述，记载了包括膀胱癌在内的血尿、淋痛的症状，并叙述了它的病因病机。

膀胱癌早期无特殊表现，往往以小便常规检查发现红血球而引起重视，病情进一步发展可出现尿频及排尿困难。晚期症状较复杂，下腹部出现包块，进行性增大，甚至出现尿潴留、发热、寒战、腰痛、脓血尿、下肢浮肿、盆腔内疼痛（疼痛放射至阴部），易误诊为其他疾病，可因感染、尿闭，形成尿毒症而死亡。亦可因消瘦、衰竭而死亡。

中医治疗膀胱癌目前尚无疗效理想的方药，可参考以下证型，辨证施治：

一、阴虚血热型

尿血已久，心悸怔忡，五心烦热，腰膝酸软，口干唇红，小便黄赤，大便干结，包块不大，舌质红，苔薄，脉细数。治宜养阴清热，凉血止血。

处方：生地30克，山药30克，山萸12克，茯苓30克，猪苓30克，紫草30克，芦荟6克，小蓟12克，蒲黄炭12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

二、湿热下注型

尿血，尿时急痛，淋漓不尽，大便或结或软而不畅利，疲乏无力，口淡无味，饮食不多，苔黄腻，脉滑数。治宜清热利湿导滞。

处方：猪苓30克，汉防己12克，大黄6克，芦荟6克，茯苓30克，虎杖30克，龙胆草12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

三、气虚血瘀型

形体消瘦，疲乏无力，包块增大，小便闭塞不通，甚则点滴难下，或盆腔内疼痛，牵连阴部及大腿内侧疼痛，下肢浮肿，舌质淡，舌边有瘀斑，苔薄，脉细涩。治宜益气扶正活血化瘀。

处方：黄芪30克，白术24克，茯苓24克，菌灵芝30克，莪术15克，龙葵15克，蛇莓15克，白英30克，土茯苓24克，白花蛇舌草30克，苡仁30克。水煎服。

膀胱癌除上述分型治疗外，尚可用下列由具有抗癌利尿作用的中药组成的方剂治疗：

白英30克，半枝莲30克，龙葵15克，蛇莓15克，肿节风30克，猪苓30克，苡仁60克，汉防己12克，水煎服。

95. 睪丸肿瘤

睪丸恶性肿瘤多发生于青壮年，病因除隐睪和睪丸异位外，外伤、遗传、内分泌功能障碍、病毒感染等为主要因素。睪丸恶性肿瘤位于体表，易于诊断，包块质地坚硬、固定。活体组织病理切片检查可确诊。睪丸肿瘤早期治疗可手术切除。稍晚期就要采取综合治疗，即手术加中草药、放射疗法、化学疗法等，疗效较好。

睪丸恶性肿瘤初起没有什么症状，继后出现无痛性肿块，质地坚硬固定，患侧可有沉重感，有时阴囊或下腹部、腹股沟有牵拉感，跳跃或跑步时更明显，少数有时疼痛，晚期可形成腹股沟、对侧睪丸或腹腔转移，出现相应的症状。

中医治疗睪丸肿瘤目前尚无疗效理想的根治方药，可参考以下症型，辨证施治：

一、气滞血瘀、湿热蕴毒下注型

睪丸胀痛，结节坚硬，与皮肤粘连，皮色紫暗，小便坠胀不畅利，舌质红绛，苔黄腻，脉沉细有力。治宜化瘀利湿。

处方：苡仁30克，猪苓24克，茯苓24克，土茯苓24克，大黄6克，龙葵30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，汉防己12克，干蟾皮6克，甲珠15克，黄芪30克。水煎服。

二、肝肾阴虚，肝经气滞型

睪丸肿胀不适，累及少腹，腰酸腿软，疲乏无力，面色少华，舌质暗，有瘀点，苔白或少苔，脉沉细。治宜补益肝肾，理气散结。

寄生30克，肉苁蓉15克，橘核15克，荔枝核15克，茴香12克，莪术15克，虎杖30克，夏枯草30克，白术24克，半枝莲³0克，白花蛇舌草30克。水煎服。

睾丸肿瘤除上述分型治疗外，尚可用下列方剂治疗：

八月札20克，石上柏15克，夏枯草30克，石见穿30克，水煎服。

96. 乳腺癌

乳腺癌是我国常见的恶性肿瘤之一。发病机理尚不清楚，与卵巢功能关系较密切，与生育、哺乳及遗传等因素也有关。乳腺癌以乳房出现包块为特征。作X线检查、液晶热图象检查、超声波探测、³²磷体外探测、强光透照法，乳头溢液的涂片细胞学检查都有助于乳腺癌的诊断，唯活体组织病理切片检查是公认的确诊法。治疗以手术切除为主，可配合用中草药治疗、放射治疗、化学治疗、免疫治疗等。对晚期体弱者，中草药治疗更有其优越性。

历代中医对乳癌虽有不同病名，但从元代开始多数已称“乳岩”了，以其形状近岩穴而得名。多由情志失调，导致气血瘀滞而成。

肿块为乳腺癌的首要症状。凡成年妇女乳房中触到肿块，即应高度怀疑有乳腺癌的可能。肿块大多为单发或多发，多为边缘不整，坚硬，少数可如橡皮样硬，早期能推动。乳腺癌病人约30%有疼痛感，多为钝痛。当肿瘤侵犯皮肤时，多出现不同程度的凹陷点，称为“酒窝征”。随着肿瘤

继续发展，可出现皮肤变粗增厚等“桔皮样变”及与皮肤粘连现象。肿瘤继续发展侵蚀皮肤便可发生破溃。患者乳头可有溢液或溢血。当乳腺癌发生肺、肝及骨等处转移时，则出现相应的症状。

中医认为乳腺癌的发生多与情志失调有关，患病之后又易急多怒，故疏肝解郁必须贯彻治疗的始终。后期气血瘀滞，瘀久化热成毒，又当以活血祛瘀、清热解毒、软坚散结为治疗重点。

中医治疗乳腺癌目前尚无疗效理想的根治方药，可参考以下证型，辨证施治：

一、肝郁气滞型

乳中出现小包块，乳房胀痛，痛连两胁，情绪易波动，急怒后疼痛加剧，苔薄白，脉弦。治宜疏肝解郁，养血散血。

处方：柴胡15克，白芍15克，当归12克，白术15克，茯苓15克，瓜蒌15克，橘叶12克，夏枯草30克，半枝莲30克，水煎服。

二、冲任失调型

除了有肝郁气滞的症状外，并有月经不调，或经行先后不定期，或经期较长，或经行腹痛较甚者。治宜疏肝解郁，兼固冲任，脾肾同治。

处方：柴胡12克，当归12克，瓜蒌12克，夏枯草30克，半枝莲30克，郁金12克，寄生30克，白术15克，熟地30克，茯苓30克。水煎服。

加减：虚寒、肾阳不足者加淫羊藿、肉苁蓉、鹿角片。经络阻滞不通者加山甲、路路通、丝瓜络。

处方：生地30克，熟地20克，女贞子30克，山萸12克，

三、气血瘀结型

包块逐渐增大，坚硬不痛，固定不移，边界不清，腋下及锁骨上无明显包块，舌边有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。治宜活血祛瘀，软坚散结。

处方：当归12克，莪术15克，甲珠15克，鳖甲24克，昆布30克，海藻30克，瓜蒌24克，丹参30克，漏芦12克，王不留行12克，皂刺12克。水煎服。

加减：气郁不舒加柴胡、香附，疼痛加乳香、没药。

四、热毒蕴结型

包块坚硬红肿，或翻花溃烂，或腋下、锁骨上瘰疬肿大疼痛，饮食减少，形体消瘦，尿黄，大便干结，苔黄腻，脉弦数。治宜清热解毒，软坚散结。

处方：浙贝12克，甲珠15克，鳖甲24克，白英30克，铁树叶30克，败酱草30克，露蜂房15克，山慈菇24克，鬼箭羽15克，银花15克，紫花地丁30克，蒲公英30克。水煎服。

加减：出血者加血余炭、炒蒲黄、三七粉；形体消瘦较快者加黄芪、党参。

注：病至此期，治疗多难收效，故治疗宜早。

中医治疗乳腺癌，除上述分型治疗外，尚可选用下列方剂：

1. 天冬30克，山慈菇15克，猪殃殃30克，核桃树枝30克，甲珠15克，水煎服。

2. 新鲜蟾皮，晒干，研粉，制成丸子，每粒0.3克，每次服5粒，每日服3次。

3. 鸦胆子15~25粒装入胶囊内服（一次量），每日服三次。

口服蜂乳，可作为乳腺癌的辅助治疗。

97. 子宫颈癌

宫颈癌是我国最多见的恶性肿瘤之一，居妇女恶性肿瘤首位。与早婚、多产、子宫颈创伤、性生活频繁、包皮垢刺激及内分泌失调等多方面因素综合作用有关。慢性宫颈炎、子宫颈糜烂是子宫颈癌的诱发因素之一。近年来病毒病因也得到更多人重视。临床症状以阴道不规则出血或绝经后下血及白带多而恶臭为特征。阴道细胞学检查有重要诊断意义，作宫颈活体组织病理切片检查即可确诊。近年来由于普查的广泛开展，多数病人能早期发现，得到治愈。目前，放射疗法、手术、中草药治疗三种方法，可单独应用或联合应用。化学疗法可作为综合治疗的手段之一，或作为姑息治疗之用。

子宫颈癌属于中医崩漏、带下范畴。其病因多与肝郁气滞、肝肾亏损、冲任损伤、湿热下注等有关。中药早期治疗效果较好。

子宫颈癌早期多无临床症状，少数病人易疲劳，易激动，月经来潮时腰酸腹痛加重，或性交后出血，或作妇科检查后出血，白带清稀。此时尚不易被人察觉。待月经错乱，崩漏不止，白带多且恶臭时多已是中晚期，根据转移部位的不同可出现一些全身症状，如疲乏、消瘦、食欲不振、局部疼痛及腰腹疼痛。若侵犯膀胱，可出现尿频、尿急、尿痛；侵犯盆腔可出现外阴及下肢水肿；侵犯直肠可出现里急后重、便脓血等症状。癌细胞还可通过血液循环转移至肺、

肝、骨等部位，产生相应的症状。到晚期疼痛剧烈，影响进食和睡眠。

。 中医治疗子宫颈癌可参考以下证型，辨证施治：

一、肝郁气滞型

心情抑郁，胸胁或少腹胀满，一身串痛，心烦易怒，口干苦，不思饮食，白带稍多，舌质正常，苔白脉弦。治宜舒肝理气，佐以解毒活血。

处方：生南星30克（先熬二小时），莪术15克，当归12克，茯苓24克，白术24克，栀子12克，香附12克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，丹皮12克，青皮12克。水煎服。

二、湿热蕴毒型

。 白带多，色如米泔，甚则外阴发痒，气臭秽，少腹胀痛，尿黄便干，口苦口干或秽臭，舌质暗红，苔白腻或黄腻，脉滑数。治宜清热利湿解毒。

处方：苍术10克，黄柏10克，苡仁30克，土茯苓24克，赤芍12克，蚤休24克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，莪术15克，猪苓34克，干蟾皮15克。水煎服。

三、肝肾阴虚型

头晕耳鸣，腰膝酸痛，口干心烦，手足心热，大便干结，小便短赤涩痛，有时阴道出血，舌质红绛无苔，脉细数或弦细数。治宜滋补肝肾，佐以解毒。

处方：知母12克，黄柏12克，生地20克，山药30克，蚤休24克，莪术15克，半枝莲30克，女贞子30克，白花蛇舌草30克，寄生30克。水煎服。

四、中气下陷型

气短神疲，白带较多，少腹下坠，腰酸痛，饮食不多，

舌淡红，苔白，脉沉细无力。治宜补中益气，佐以活血解毒。

处方：黄芪30克，太子参30克，白术24克，茯苓30克，升麻6克，柴胡12克，寄生30克，生苡仁30克，莪术15克，生南星12克（先熬二小时）。水煎服。

五、脾肾阳虚型

神疲乏力，腰酸腿软，四肢不温，纳呆，大便稀溏，白带多而清稀。舌胖，苔白润，脉沉细无力。治宜温肾健脾为主。

处方：附片30克（先熬），干姜10克，党参30克，白术24克，茯苓24克，山药30克，丹皮10克，熟地12克，淫羊藿30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。水煎服。

加减：出血较多加三七粉、云南白药。出血太急加人参。

腹痛属气滞者加玄胡、香附，偏血瘀者加五灵脂、乳香、没药。晚期剧痛加郁金、九香虫、玄胡、没药。

白带多者加苦参、苡仁、败酱草；便秘加大黄、芦荟；尿频涩痛加知母、猪苓、瞿麦；下肢及外阴发肿加生南星、土茯苓、防己。

中医治疗宫颈癌除上述分型治疗外，加用外用药则效果更好。外用药如莪术注射液局部注射，鲜蟾皮注射液局部注射，天南星注射液局部注射。尤其是早期病例，外用药内服药合用常可提高疗效。

内服药也可选用下列方剂，对早期或晚期宫颈癌均适用。当然，早期治疗效果较好。

方一：半枝莲30克，白花蛇舌草30克，莪术15克，黄药子15克，山豆根15克，龙葵15克，核桃树枝30克，黄芪30克，淫羊藿30克，寄生30克，水煎服。

方二：土鳖虫10克，穿山甲15克，天龙（守宫）6克，蜈蚣2条，水煎服。

经药理研究证明，上述药物均有抗肿瘤作用。据国内报道，上述各药单用或入复方治疗子宫颈癌均有较好疗效。

98. 卵 巢 癌

卵巢癌以一側或兩側少腹出現包塊為主要臨床表現，原因尚不清楚，多與激素分泌功能障礙有關。檢查方法雖多，但難以鑒別其為良性或惡性。陰道細胞學檢查雖有助於診斷，但陽性率不太高。剖腹探查或手術時取活體組織作病理切片檢查可以確診。治療以廣泛性手術切除為主，可配合用放射治療、中藥治療及化學治療，以減少復發。

中醫無卵巢癌的病名。但類似卵巢癌症狀的記載甚早。如《靈樞·水脹篇》說：“寒氣客于腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所系，癖而內著，惡氣乃起，息肉乃生。其始也，大如雞卵，稍以益大，其成如懷子之狀，久者離歲，按之則堅，推之則移，月事以時下，此其候也”。這段描寫與今之卵巢癌很相似。

卵巢癌早期多無特殊表現，患者往往以小腹一側或兩側扪及包塊而就診。大多數患者是在體格檢查時偶然發現，包塊為結節狀或實質性腫塊，可固定不動，也可移動（有蒂）。一般疼痛不劇烈，痛時可向下肢放射，伴有腰痛。晚期腫瘤病灶擠壓盆腔臟器可出現相應的症狀，如腫瘤擠壓膀胱可產生小便困難，腫瘤擠壓直腸可產生便秘，腫瘤阻礙下肢淋巴、

静脉回流可产生下肢浮肿、静脉曲张等等。若合并卵巢扭转，则有剧痛、发热、白细胞增高等表现，亦可产生腹水、胸水及呼吸困难，如治疗不及时，最后往往极度瘦弱、贫血、恶病质而死亡：

中医治疗卵巢癌目前尚无疗效理想的根治方药，可参照以下证型辨证施治：

一、肝郁气滞型

包块较小，质中，按之能轻度移动，情绪易激动，月经来潮时两侧少腹疼痛，苔薄脉弦。治宜疏肝理气，佐以活血。

处方：当归12克，白术24克，茯苓24克，柴胡12克，香附12克，莪术15克，益母草15克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，水煎服。

加减：疼痛较剧加玄胡、台乌、五灵脂。包块巨大加甲珠、牡蛎、蚤休、夏枯草。

二、气滞血瘀型

包块逐渐增大，状若怀子，质地坚硬，固定不移，或有腹水，大便结燥，小便不利，月经紊乱，身渐瘦弱，舌质红，苔薄，脉细涩。治宜活血祛瘀。

处方：甲珠15克，白花蛇舌草30克，半枝莲30克，莪术15克，土鳖虫12克，黄药子15克，白芍15克，桔梗12克，枳实12克，柴胡15克，川芎12克。水煎服。

加减：若有腹水加大腹皮、车前草、汉防己、猪苓、茯苓皮。疼痛剧烈加玄胡、郁金、乳香、没药、九香虫。正气太虚加红参（嚼服）、黄芪，并酌减祛瘀药物。

据国内报道，龙葵、莪术、水蛭粉单用或入复方治疗卵

巢瘤均有一定疗效。临床上用龙葵25克，莪术15克，煎水送服水蛭粉3~6克，治疗卵巢瘤，可提高疗效。

99. 白血病

白血病是造血系统的一种恶性疾病，应视为血液的恶性肿瘤。其特点是白细胞某一系统的过度增生，并浸润到体内的各种组织和脏器，尤其是肝、脾和淋巴结。周围血液中经常出现各种幼稚的白细胞，白细胞的总数经常增多，常有严重贫血与明显的出血倾向，并可危及病人的生命。白血病的发生多与环境因素及机体的遗传、代谢、免疫等有关。诊断主要依靠血象检查和骨髓象的检查。白血病一般分为急性、亚急性、慢性三种。增生的白细胞类型有粒细胞、淋巴细胞、单核细胞三型。治疗以联合化学疗法为主，可配合应用中草药疗法、免疫疗法、支持疗法等。

白血病属于中医的“虚劳”、“血证”、“温病”、“症积”、“痰核”等范畴。中医认为多因七情太过，肝脾损伤，而成虚劳，日久气滞血瘀结成痰核而为本虚标实之症。

急性白血病以儿童为多见，发病急，病程短，发热，口腔溃烂，有严重贫血、普遍出血现象。慢性白血病发病缓慢，初起多无特殊不适，后期表现亦较复杂，多为疲乏无力，饮食减少，消瘦，头晕，头痛，面色苍白无华，或发热出汗，或腹胀腹痛，或颈、腋、腹股沟等部位出现包块，或皮肤瘙痒，出现斑疹，吐血，衄血，便血、尿血，甚则头痛加剧，出现肢体瘫痪，感觉麻木等等。

中医治疗白血病目前尚无疗效理想的根治方药，可参考以下证型辨证施治：

一、温热型

高热，汗出，口渴、饮水多，神昏烦躁，甚则谵语，吐血，衄血，舌绛苔黄，脉洪弦数。治宜清热（清瘟）解毒，凉血消瘀。

处方：生石膏30克，生地15克，青黛6克（装入胶囊吞服，不入煎剂），黄连9克，蚤休24克，虎杖30克，丹参30克，苦参15克，丹皮12克，银花12克。水煎服。

加减：若以高热为主，则重用生石膏、柴胡。若以出血为主，重用生地、丹皮，加用尿角。若舌边舌尖瘀斑多，加三七、水蛭、土鳖虫。若昏迷不醒，可加服安宫牛黄丸、至宝丹、紫雪丹等。

二、肝郁火盛型

温热型白血病经治疗后高热渐减，仍有低热汗出，头痛头晕，心烦失眠，疲乏消瘦，食欲甚差，胸胁疼痛，面红目赤，两肋下可出现症块，颈、腋、腹股沟出现包块，舌尖红，有瘀点，苔薄，脉弦数。治宜清肝泻火，佐以活血化瘀。

处方：黄连12克，芦荟12克，龙胆草9克，青黛6克（入胶囊吞服），大黄6克，莪术15克，黄药子15克，夏枯草30克，柴胡6克。水煎服。

三、热结痰核型

发热不高，汗出不多，疲乏消瘦，颜面苍白，皮肤瘙痒，体重大减，腹痛，腹中有包块，颈、腋、腹股沟包块多而明显，苔黄或黄腻，脉弦滑或滑数。治宜清热化痰，软坚散结。

处方：玄参12克，牡蛎30克，浙贝12克，甲珠15克，夏

枯草30克，昆布30克，海藻30克，法半夏12克，生南星12克（先煎二小时），瓜蒌15克，黄药子15克，山慈菇24克，半枝莲30克，蚤休24克，白花蛇舌草30克。水煎服。

四、心脾不足型

消瘦疲乏，食欲不振，心慌心悸，失眠，皮肤粗糙欠润，或吐血，便血，大便稀溏，小便清长，苔薄，脉细缓。治宜补养心脾。

处方：人参6克（嚼服），黄芪30克，白术24克，茯苓24克，当归12克，菌灵芝30克（先熬），刺五加30克，大枣30克，阿胶10克，水煎服。

五、肝肾阴虚型

五心烦热，午后潮热，腰酸腿软，疲乏无力，纳呆，面色潮红，口鼻出血，舌质胖嫩，苔薄，脉细数无力。治宜滋补肝肾。

处方：熟地24克，山药30克，寄生30克，山萸15克，茯苓30克，鳖甲24克，女贞子30克，旱莲草30克。水煎服。

加减：颈、腋部有包块则加昆布、海藻、半枝莲。口鼻出血可加茅根、知母、小蓟。

六、脾肾阳虚型

消瘦，极度疲乏，食欲不振，怕冷，四肢不温，腰腿酸痛，大便溏薄，小便清长，舌质淡，舌边有齿印，苔薄，脉沉细弱。治宜温补脾肾。

处方：熟地24克，山药30克，山萸12克，肉桂6克，炮姜10克，龟胶24克，鹿角胶15克，枸杞15克，淫羊藿30克，制附片30克（先熬）。水煎服。

加减：气短加人参、黄芪、白术。

中医药治疗白血病，除上述分型治疗外，尚可选用下列方剂：

方一：青黛，每次服3~6克，每日三次，装入胶囊内服（煎服无效）。青黛的有效成份靛玉红，是治疗白血病的有效药物，药理研究和临床应用均已证实这一点。但青黛必须装入胶囊内服，水煎或泡酒服均无效。青黛及其有效成份靛玉红，具有良好的抗白血病作用，又不抑制骨髓，还能增强机体免疫功能，是治疗白血病的疗效较好的中药。

方二：羊蹄根30克（又名土大黄，牛舌头、羊舌头、野菠菜、羊蹄叶），猪殃殃30克，猪苓30克，山慈菇15克，天冬30克，山豆根15克，水煎服。

方三：茵灵芝30克，加水煎熬二小时，煎三次服。同时服蜂乳以增强疗效。

方四：穿山甲15克，土鳖虫10克，昆布30克，海藻30克，鳖甲30克，水煎服。

经药理研究证明，上述药物均有抗肿瘤作用。根据报道，上述各药单用或入复方治疗白血病均有较好疗效。其中蜂乳、茵灵芝为滋补强壮药，配合青黛用于白血病的治疗，则疗效可望提高。也可将上述四个方剂轮流服用。

100. 脑 瘤

生长于颅内的肿瘤统称为脑瘤（颅内肿瘤）。脑瘤种类繁多，男女老幼均可发生。儿童以小脑幕下的肿瘤为多见，成人以小脑幕上的肿瘤为多见。临床表现可因肿瘤的类型、部位、生长速度和患者全身情况而有所不同，但最终均可导致颅内压的增高而见头痛、呕吐、视力障碍、头晕、复视、精

神症状、癫痫发作、颈项强直、角膜反射减退以及呼吸改变、血压改变等。脑瘤的诊断方法很多，头颅X线平片、超声波检查、脑电图、同位素扫描、脑血管造影、脑室及气脑造影均有助于诊断。治疗以早期手术为好，但因脑瘤多为浸润性生长，故须同时配合中药治疗、放射治疗、免疫治疗、化学疗法等。

脑瘤属于中医的“头痛”、“呕吐”等范畴，病因与气血瘀滞所致之痰滞有关，气血瘀滞日久，渐成肿块，故治疗以行气活血为主，疏肝解郁，祛痰除湿，息风解痉为辅。

颅内肿瘤不论原发或转移，早期多无明显症状，偶有头痛，逐渐加剧，同时可伴喷射样呕吐，食欲减退，睡卧不安，或出现一侧耳失聪、失听、目偏盲、复视，或癫痫样发作，或血压升高，甚至肢体瘫痪，智力迟钝，运动障碍，平衡失调，精神错乱，嗜睡，昏迷等，表现很复杂，依病灶部位不同而表现各异。

中医治疗颅内肿瘤目前尚无疗效理想的方药，可参照以下证型辨证施治：

一、痰浊阻滞型

头痛较轻，呕吐痰涎，坐卧不安，恶梦多，胸脘痞闷，苔黄厚腻，脉缓或滑数。治宜除痰导滞。

处方：茯苓30克，陈皮12克，法半夏12克，生南星12克（先熬），瓜蒌24克，天麻12克，苡仁30克，甲珠15克，白芷12克，半枝莲30克。水煎服。

二、气血瘀滞型

头痛较剧，固定不移，进行性加剧，或同时伴发喷射性呕吐、偏盲、复视或一侧耳聋等。

处方：当归12克，川芎12克，赤芍12克，生地15克，桃仁12克，红花12克，莪术15克，甲珠15克，土鳖虫12克。水煎服。

加减：头痛剧烈加蔓荆子、藁本、柴胡、白芷、葛根。耳鸣、眩晕、复视，加用杞菊地黄丸。耳聋加柴胡、黄芩、石菖蒲、远志。癫痫样发作加天麻、石决明、生龙骨、生牡蛎、全蝎、地龙、僵蚕、钩藤、磁石。喷射性呕吐加夏枯草、车前草、半边莲、白花蛇舌草、大黄。

脑瘤除上述分型治疗外，尚可用下述方剂治疗：

地龙10克，蜈蚣2条，全蝎6克，僵蚕10克，苍耳子10克，黄药子15克，昆布30克，海藻30克，水煎服。

上述各药单用或入复方治疗脑瘤均有一定疗效，且药理研究证实均有抗肿瘤作用。

附：癌症患者的饮食注意事项

1. 宜采用“生食疗法”

“生食疗法”即吃生菜、吃水果，吃生花生米、核桃等，而不吃熟食。这种疗法又称“生食抗癌疗法”。

生食抗癌疗法在国外已有一百多年的历史。早先，犹太籍博士格尔森发明一种抗癌疗法，主要采用苹果汁、桔汁以及芹菜等生菜为病人治疗，收到良好效果。美国科学家安妮·威格莫尔，在患癌症濒于死亡的绝望中，忽然想起了生食疗法。于是，安妮一日三餐都吃生的蔬菜和瓜果，不吃熟食。一连数年，说也奇怪，安妮不用药物治疗，也没有采用放射治疗，但她的癌症却治好了，多活了20年。她把这种生食抗癌疗法向其他癌症患者介绍，竟治愈了上千名癌症病人。

生食疗法之所以能预防和治疗癌症，是因为：生的蔬菜和

瓜果能保护人体的免疫系统，而免疫系统则是人体内的抗癌卫士。熟食是会伤害人体的免疫系统的。科学家作过实验，当人吃了熟食后，人体内的白血球马上就增加。白血球是人体内的保卫战士，一旦发现敌情（指致病的细菌或癌细胞等），白血球就马上聚而歼之。所以，当致病的细菌侵入人体之后，白血球就马上包围这些病菌，并与之斗争。病人有炎症（感染）时，白血球升高，就是这个道理。有趣的是，当人吃了熟食后，人体内的白血球也马上增加，说明人体白血球对待熟食的态度和对待致病的细菌一样。人们一天三餐都先吃熟食，而不先吃水果或生菜，白血球经常如临大敌，经常处于戒备状态（暂时性的升高），久而久之，血液内的白血球也会疲乏，削弱了战斗力，也就是人体的免疫系统受到损害。

食物（包括蔬菜）生吃后丝毫不会引起血液内白血球暂时性的升高，这就保护了人体的免疫系统。如果人们在吃熟食之前，先吃一些生食物（生的蔬菜和水果），由于生食物的吸引作用，生食后再吃熟食也不会引起白血球增多，多吃生菜及生食物实际上能使被熟食伤害的免疫系统功能得到恢复。

生的蔬菜中含有丰富的酶、维生素、纤维素、矿物质及微量元素等，这些营养是人体必需的，缺乏了就会生病。生菜中所含的大量维生素和酶往往遇热分解而被破坏。

很多蔬菜都可生吃，如萝卜、莲花白菜心、芹菜、莴苣、蒿笋、黄瓜、蕃茄、子姜、灯笼辣椒、藕、地瓜、葱、蒜等等。

奉劝癌症患者实行“生食疗法”，延长生命，顽强地生

活。

2. 宜常吃富含维生素A的食物。

因为维生素A能防癌，特别是上皮组织的癌。

上皮组织分布在口、喉、胃肠、气管、食管、肺、肾、输尿管、膀胱、睾丸或卵巢、子宫、阴道、全身皮肤等。上皮组织出色完成人体的保卫、消化、呼吸、物质交换、新陈代谢等功能。

上皮组织有极强的再生能力，例如口腔粘膜烫伤后，数小时内即可再生。

上皮组织的结构和功能维持正常，都依赖维生素A。如果体内缺乏维生素A，则上皮组织的分化成熟、功能等都会发生改变。因此，维生素A缺乏，会使食管鳞状上皮过度角化增生，重度增生就会发展成为食管癌。维生素A缺乏，会使肺的腺上皮失去纤毛，不再分泌粘液，萎缩甚至变性而发展成肺癌。

维生素A还能提高人体对致癌物质的耐受性，使人对致癌物质不那么敏感，也就是得癌症的机会可减少。

基于以上所述，癌症患者宜常吃富含维生素A的食物如牛奶、羊奶、蛋黄、动物肝脏等。

我国人民主要靠摄入胡萝卜素来补充维生素A。胡萝卜素在体内可转化为维生素A。胡萝卜、辣椒、苋菜、菠菜、杏、玉米、柿子中都含有较丰富的胡萝卜素。

维生素A能溶于脂肪，抗酸、抗硷力亦较强，一般的烹调温度对食物中的维生素A不会产生多大破坏作用。

胡萝卜素可转化为维生素A。多吃胡萝卜也能防癌。美国科学家曾把488名摄取胡萝卜素最少的人编为一组，发现

其中有14人患肺癌；而另一组摄取胡萝卜素较多的人中，患肺癌者仅有2人。

还有一位患肺癌的60多岁的妇女，手术时发现癌灶已转移，病人回家后因常口渴，经人推荐，常饮胡萝卜汁，每天喝4~5杯，病情逐渐好转，已存活四年多，和正常人一样健康。

3. 宜常吃富含维生素C的食物。

因为维生素C能阻挡癌细胞的发生和发展。

癌细胞是一种异常细胞，它扩张和增生异常迅速。癌细胞扩张的第一步，先要破坏其周围的细胞基质，细胞基质是一种高粘性物质，可以形成对癌细胞的“包围圈”。癌细胞分泌出一种“透明质酸酶”，专门破坏高粘性物质形成的包围圈。“透明质酸酶”是癌细胞的武器。但是人体里还有一种“生理性透明质酸酶抑制物”，专门抑制“透明质酸酶”，使癌细胞的武器失效。维生素C就是合成“生理性透明质酸酶抑制物”的主要原料。如果人体内有足够的维生素C，癌细胞向外扩张就很困难了。

维生素C能提高细胞表面环一磷酸腺苷的水平。环一磷酸腺苷能使正常细胞不发生癌变，还能使已经发生轻度恶变的细胞恢复正常。

维生素C还是一支“督战队”，使体内没有抗癌能力的淋巴细胞具备抗癌能力。

维生素C可以参加人体内的物质代谢，使有致癌能力的化合物不仅溶于脂肪，甚至溶于水，增加致癌化合物的排泄途径，减轻致癌物质对人的刺激。维生素C还能促进纤维组织生长，在肿瘤周围形成“天罗地网”，防止肿瘤扩散。

维生素C摄入量多，癌症的发病率就低。晚期癌症患者口服大剂量维生素C，可延长生命。

富含维生素C的食物较多，新鲜水果如鲜枣、猕猴桃、柑桔、柠檬、芒果、柿子等等，新鲜蔬菜如蕃茄、黄瓜、花菜、白菜、绿叶蔬菜等，均含丰富的维生素C。

4. 宜常吃卷心菜、花菜等抑癌食物。

某些食物含有特殊有机物，称之为“癌抑制物”。这种癌抑制物与体细胞（尤其是肝细胞）中的一种微粒体多功能氧化酶系统，协同分解进入人体内的有害物质。在正常情况下，毒物（如致癌物）一旦进入体内，会刺激机体诱导出相应的能分解该毒物的酶，以对抗毒物，保护机体。近来研究发现，某些食物也会诱导这类酶的合成。这就为人类抵抗癌症提供了有力的武器。

人们常吃的卷心菜、花菜中含有吲哚类化合物，这类化合物具有酶诱导能力，可使肝脏中的芳烃羟化酶活性提高54倍。可使小肠粘膜中的这些酶的活性提高30倍。

癌症患者常吃卷心菜、花菜等抑癌食物以配合治疗，有益无害。

5. 宜常吃真菌类抗癌食物。

如香蕈、蘑菇、平菇、猴头菌等。因为这些食物含有多糖，有抗肿瘤的作用

6. 宜常吃大蒜、白萝卜、菱、莼菜、箬竹等“抗癌食物”。

大蒜中含有一种新的氨基酸，叫“亚力新”，有人用这种物质喂小鼠，结果抑制了移植的癌细胞的分裂和增殖，延长了试验接种的患癌鼠的寿命。学者们认为大蒜抗癌大有希

望。

我国山东苍山县胃癌死亡率很低，当地农民就喜欢种大蒜和吃大蒜。大蒜通过抑制细胞而减少了合成致癌物的原料亚硝酸盐的产生，从而防止致癌物亚硝胺的形成。

白萝卜也有抗癌功效。白萝卜中有三件武器可以对付致癌的亚硝胺，一是“酶”，二是维生素C，三是木质素。

大白菜、元白菜（莲花白）也有抗癌功效。这是因为大白菜、元白菜中含有一种叫“钼”的微量元素，钼可以抑制人体内亚硝胺（致癌物质）的吸收与合成。

菱也有抗癌功效。著名老中医叶橘泉治疗一位70多岁的幽门癌患者，病人饮食不下，骨瘦如柴，大便如羊屎，奄奄一息。叶老医师用菱角、苡仁加入旋覆代赭汤中，给病人煎汤服用，获得满意疗效。

莼菜，一名蓴菜，产我国南方湖泽中，南方人将其作蔬菜食用，味鲜美。莼菜生于水中，叶背生有一种琼脂样粘液，有抗癌功效。其未露水面的嫩叶卷而未展，粘液更多。据日本汉方医界报道，本品治胃癌、肠癌，用其嫩叶煮食，拌以食醋。初服时可能胃痛稍加重，半月后食欲可恢复。一胃癌患者，经手术后服用莼菜，防止了复发和转移。

箬竹也有抗癌功效。箬竹为禾本科植物，浙江、安徽、江西、四川等地都有出产。箬竹叶含有箬竹多糖体，有防腐抗癌作用。其抗癌功效可能是由于它对癌细胞分泌的毒性物质起解毒作用，并可防止肝过氧化氢酶活性下降，促进肝脏的酶的活性化。

7. 宜常吃绿叶蔬菜。

绿叶蔬菜中所含的叶绿素能防癌，这是国外科学实验证

明了的。蔬菜中所含的叶绿素越高，防癌作用越强。科学实验还证明，95%的叶绿素不会被人体肠道的酸碱物质所破坏。

8. 宜常吃苡仁、蜂乳、海带。

苡仁不仅具有健脾利湿、清热排脓的作用，而且有抗癌作用。苡仁中的苡仁酯有抑制艾氏腹水癌细胞的作用。苡仁加水煮服，对人体癌细胞也有抑制作用。常用于胃癌、子宫颈癌、绒毛膜上皮癌的辅助治疗。

蜂乳不但是滋补强壮剂，而且也有抗癌作用。科学研究证明，蜂乳的抗癌有效成份为脂肪酸，能使艾氏腹水癌鼠寿命延长，腹水出现较迟，癌细胞发育有退行性变化。有科学家作过实验，蜂乳喂患癌的家鼠，能够活一年，而不喂蜂乳的患癌家鼠，只能活21天。蜂乳有抑制多种实验性肿瘤的癌细胞生长的作用。可作为肝癌、胃癌、肠癌患者以及其他癌症患者手术后的辅助治疗。每天吃2—3支（安瓿）为宜。

海带营养丰富，不仅有消痰、软坚、散结等功效，而且有抗癌作用。海带中所含的藻胶酸能与鼠体内的放射性物质镭、镭结合，成为不溶解的化合物，当镭未被肠壁吸收以前，服用藻胶酸有预防白血病（血液癌）的作用。当今，治疗癌症的化学药物，都是既杀敌、又伤己，因其有效剂量和中毒剂量很接近，稍有不慎，即可造成“玉石俱焚”的恶果，而食物中的多糖类（海带中的昆布素也是一种多糖类）却不杀伤正常细胞，而是以恢复、完善和提高人体免疫功能而发挥抗癌作用的。因此，癌症病人多吃海带是大有好处的。

9. 宜常吃红枣和酸牛奶。

红枣（大枣）有抗肿瘤的作用。有人做了动物实验，给两组大白鼠同时喂饲一种叫做MNNG亚硝胍类的致癌物，其中一组加饲大枣。结果，十个月后，未食大枣组胃肠道恶性肿瘤的发生率高达71.4%，而加食大枣组只38.4%。即使先食MNNG7个月，再开始食用大枣8个月，也有同样的效果。最近，国外学者分析出大枣中的抗癌有效成份，是一组三萜类化合物，其中山楂酸在动物实验中抑癌力超过了常用抗癌药5-氟脲嘧啶。科学研究还发现，大枣中含有丰富的环磷酸腺苷，这种物质能调节细胞的分裂繁殖，而在癌细胞中环磷酸腺苷的含量低于正常细胞，但若在体外培养时增加癌细胞中的环磷酸腺苷含量，可使它向正常细胞转化。这是大枣抗肿瘤的另一机理。

癌症患者还宜常吃酸牛奶。因为酸牛奶有抗癌作用。国外科学研究证明，给予酸牛奶可以抑制小鼠艾氏腹水癌细胞的增殖，对肝癌的发生也有抑制作用。

10. 宜常吃枇杷。

枇杷果中含有抗癌物质维生素B₁₇。

枇杷叶也有抗癌功效。采用枇杷叶浸膏并配合其他抗癌药，能使血液净化，细胞本身功能获得恢复，癌症症状减退以至消失。经有关单位测定，枇杷叶的有效成份之一就是苦杏仁甙，即青酸配糖体。它经人体吸收后，可分解为氰酸和苯甲醛。这两种物质都具有抗癌作用。苯甲醛进一步转变为一种类似阿斯匹林（安息香酸）的物质，它能发挥很强的镇痛作用，可用于治疗各种癌症疼痛。枇杷果、枇杷叶所含的苦杏仁甙中，含有抗癌物质维生素B₁₇。黑龙江制药厂与黑龙江制药工业研究所现已研制出抗癌新药B₁₇。经上海同仁医

院、曙光医院临床试用，疗效喜人。B₁₂亦名AT素注射液，毒性低，无副作用，可杀伤癌细胞，对正常人体细胞则无杀伤作用。同仁医院自1982年以来，用此药治疗的大部分癌症晚期患者，用药后症状明显缓解，疼痛减轻，食欲增进，精神好转，未发现骨髓受抑制等副作用，白血球亦正常。个别转移性晚期肝癌患者甚至肿块消失。曙光医院试用AT素注射液与单用中药汤剂组、化学疗法组作了对比，观察结果，以AT素组疗效最佳。该院肿瘤科认为，AT素注射液是值得推广的治癌有效新药。由此可见。枇杷果是较为理想的抗癌食品。如能常吃枇杷及其加工食品，对于防止癌症发生（或复发）或作为癌症患者的辅助治疗，都是有益无害的。

11. 宜常吃带鱼、鹅血、魔芋。因为这些食物均含有抗癌成分。

带鱼身上的银白色表层既非鱼鳞，也不是不洁之物，而且含有多种不饱和脂肪酸的油脂，具有降胆固醇的作用。取鲜带鱼蒸熟后的上层油食用，能改善肝炎患者的症状。近年来，科学研究发现，带鱼体表油脂内还含有一种抗癌成分。它能有效地治疗急性白血病及其他癌症。用这种油脂提取的新药，治疗急性白血病的有效率高达70%。上海东海制药厂从带鱼体表油脂中提制6-硫代鸟嘌呤，用于治疗急性白血病，疗效较好。

鹅血也有抗癌作用。鹅血既可食用，又可供药用。古人对它的药用价值早有记载。《本草纲目》载有：鹅血“解药毒”。民间亦有用鹅血与韭菜治疗肿瘤的验方。近代名医张梦侬用白鹅血、白鸭血治疗食道癌、胃癌，均获良效，谓其能“解毒化瘀软坚，又能养血润燥。

现代医学认为，动物血含丰富的蛋白质、糖、脂肪以及钾、钠、磷、钙、铁等多种元素，还含有许多生物活性物质，如甲状腺素、肾上腺皮质激素、前列腺素等。此外，血液中含有转移因子、丙种球蛋白等多种免疫活性分子，这些物质能增强机体免疫功能。鹅血中含有较高的球蛋白，还含有某种抗癌因子，能增强人的体液免疫而产生抗体。动物实验表明，鹅血对小鼠艾氏腹水癌可使癌性腹水形成减慢，液量减少。而且还能使癌细胞发生质的改变。大癌细胞明显退变，色变浅，胞核消失，胞浆内还可见退变的核仁，着色浅蓝；小癌细胞则有核溶解变化。实验动物用灌胃方式给药，仍能达到抑制癌细胞作用。表明鹅血中抗癌因子不受胃肠中酸、硷、酶的破坏。鹅血主要用于消化系统肿瘤及白血病等。上海、浙江鹅血制剂研究协作组用鹅血治疗各种癌症共334例，经治疗后，其中肿块缩小或消失、症状缓解、白细胞回升、能接受化学治疗或放射治疗（副作用较大）、胃纳增加、精神好转者217例，总有效率为65%。对各种原因引起的白细胞减少症，有效率为62.8%，被认为是一种缓解恶性肿瘤症状、提高白细胞的有效食物。

魔芋也有抗癌防癌功效。魔芋具有消肿、散结、解毒的功效，传统用于治疗疮痈疔肿、瘰疬结核等病症。近年来临床上有用魔芋治疗癌肿、脑瘤等疾病，取得一定疗效。

魔芋含葡萄糖聚糖达60%，其次富含蛋白质、氨基酸及纤维素等。所含的甘露聚糖能降低人体胆固醇。日本神户大学医学部上井邦雄曾给糖尿病患者每天服用从魔芋中提炼的纤维素4—8克，过一段时间抽血化验，发现血糖和胆固醇都有明显下降，症状大有好转。据报道，魔芋对各种肿瘤都

有一定的疗效。魔芋凝胶有特异性的“魔法”，它进入人体肠道后，可形成不同大小孔径的半透明膜，贴着肠壁，阻碍各种有害物质特别是致癌物质对肠壁的侵袭，从而发挥防癌的功效。日本理化研究所的水谷武夫先生，为进一步确认纤维食品的功效，用老鼠做了一种动物实验，他把老鼠分为两组，从直肠注入一种致癌物质DMA，每周注入一次。在饲料喂养上，A组给的是普通饲料，B组给的是饲料中混入5%从魔芋中提取的纤维素。经过十三周的观察，结果A组老鼠患直肠癌的有75%，B组老鼠患直肠癌的只有22%。为此，水谷先生得出结论说：“魔芋中的纤维成分很快地吸收了肠内的二次胆汁酸，使之随粪便迅速排出体外，充分发挥了防癌的效能”。国内外肿瘤专家一致认为，人们的食物中如果有丰富的纤维素，可以使大肠癌的发病率减少40%。食物纤维素可使粪便量增加，促使肠蠕动加快，这样就会使肠腔内致癌物质迅速排出，减少致癌物质与肠壁接触的机会。同时，粪便量增加还会使致癌物质浓度稀释，减轻对肠壁的刺激作用。近年来，临床上用魔芋制剂治疗淋巴瘤、乳腺癌、腮腺癌、大肠癌等，尽管病例还不很多，但魔芋作为防癌食物，却是不容置疑的了。

12. 宜常吃猕猴桃和无花果。

猕猴桃原系野生植物，现已人工栽培成功。猕猴桃不仅是一种营养丰富的水果，而且具有抗癌作用。

猕猴桃，酸甜可口，风味特异，富含维生素C（每百克鲜果含量达160~200毫克），还含有丰富的蛋白质和磷、钙、钾、镁、铁等营养元素及碘、锌、铬等微量元素。果实中所含的蛋白质水解酶，能分解肉类纤维蛋白质，具有清

热利尿、生津润燥、滋补强身等功效。对食欲不振、肝炎、尿路结石、高脂血症均有治疗作用。

近来，科学研究发现，猕猴桃有抑癌作用。猕猴桃鲜果汁有阻断致癌物质“亚硝基吗啉”在人体内合成的功效，其阻断率为98.5%，优于相同浓度的维生素C溶液。猕猴桃防癌作用的发现，受到国际营养学界和肿瘤研究机构的重视。

据浙江省兰溪县癌症研究小组报道，用猕猴桃配茅根、半边莲等煎水内服，治胃癌获效。一病人服上方三个月，肿块逐渐消失，十个月后复查已无肿块。另据报道，用猕猴桃配合虎杖，以乙醇（酒精）提取法制成糖浆（每60毫升含猕猴桃100克，虎杖50克），治疗胃癌，每次服20~30毫升，饭前服，共治18例，显效7例（原发肿瘤或转移癌灶缩小1/2，症状、体征均有不同程度好转）。初步观察，对胃癌有近期缓解症状的作用，并能增进食欲。

猕猴桃还可作为食道癌、乳腺癌的辅助治疗，每日生吃猕猴桃250克。

猕猴桃于1978年已正式列入我国国家药典，并被加工成系列食品投放市场，如猕猴桃果汁、果酒、果脯、果酱等多种食品，被誉为滋补强身、治病防癌的上等佳品。

无花果也是防癌佳品。

无花果，又名蜜果，营养丰富，甘甜可口。祖国医学认为，无花果味甘酸，性平，无毒。具有健脾、滋补、消肿毒等功能。鲜品有润肠作用。无花果的果、叶、枝、茎、根均可入药。常用来治疗咽喉肿痛、消化不良、肝炎、肺结核、老年性便秘、痔疮等病症。

无花果的果实含有蛋白质4.3%，脂肪0.3%，碳水化合物

物74.3%。葡萄糖、果糖、蔗糖含量很高。干果中的糖含量高达75%左右，还含有枸橼酸、苹果酸、醋酸、酵素及多种维生素，是一种理想的滋补珍品。

近年来，科学研究发现，无花果含有较丰富的维生素A和维生素D，可以阻止强致癌物质亚硝胺的形成，可以分解人体中已经形成的亚硝胺。更可贵的是，无花果内还有一种叫“葡聚糖”的物质，能抑制或杀灭癌细胞。因此，有人称无花果为“抗癌斗士”。国内有人用无花果制剂作动物实验，发现其对癌细胞有抑制作用，其抑癌率为43.6%。四川简阳县人民医院近年来用无花果叶制成片剂和冲剂，用于治疗胃癌等恶性肿瘤，使一些患者症状缓解，延长了生存期。一例纵膈障碍脂肪肉瘤患者，术后复发，经服用“无花果片”，至今已三年多，仍能料理家务，从事较轻的体力劳动。

无花果药源丰富，安全无毒，是一种很有前途的抗癌食物。国外已将无花果制成罐头，贴以“防癌食品”标签在市场出售。可以相信，随着抗癌食物的研究发展，无花果系列产品能进一步得到开发和利用，将为癌症患者带来新的福音。

13. 癌症患者忌吃以下食物：

(1)忌吃发霉的食物，特别是发霉的花生、黄豆、玉米等。因为发霉的食物中含有黄曲霉毒素，这是一种强烈的致癌物质。为了防止癌症复发或加重，癌症患者忌吃发霉的食物，健康人也忌吃发霉的食物。

(2)忌吃烧焦的食物。因为烧焦的食物中含有致癌物质3-4苯并芘，特别是烧焦的鱼、肉中含3-4苯并芘较多，癌症患者切忌食用，以免加重病情。

(3)忌吃残留杀虫剂的食物。因为某些杀虫剂含有致癌物质，且有毒，故癌症患者切忌食用残留杀虫剂的食物（水果、蔬菜如新近喷洒杀虫剂者不可食用，食用时有苦涩味大致可资鉴别）。

(4)忌生吃泡菜。未经炒熟的泡菜含有硝酸盐。硝酸盐在肠道细菌作用下，可还原为亚硝酸盐，亚硝酸盐能使人体血液中血红蛋白变成不能带氧的高铁血红蛋白，导致亚硝酸盐中毒。硝酸盐还有致癌作用。泡菜经炒熟后，则硝酸盐挥发，对人体无害了。

(5)忌喝酒抽烟，特别要严格禁忌喝酒同时吸烟。

(6)忌吃熏烤、油炸食物。因为熏烤、油炸食物中含有致癌物质3-4苯并芘。

(7)忌多吃肥肉等高脂肪食品。因为高脂肪饮食会提高肠中厌氧细菌的比例，产生更多的致癌物质。加上过多摄入脂肪，影响进食足够的蔬菜，可致大便结燥，使这些致癌物质长时间同肠壁接触，从而导致病情恶化。此外，高脂肪膳食还可使血液中雌激素水平升高，可能诱发妇女乳腺癌或子宫颈癌。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病良方 第二集（增订本）

作者=贾河先 王辉武编著

页数= 2 4 3

S S 号= 1 0 4 6 1 6 6 7

出版日期= 1 9 8 9 年 0 5 月第 2 版